

평가자료
평가 2025-68-215



캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 (2019 - 2023 / 700만불) 종료평가 결과보고서

2025. 2.

캄보디아 동북부
소외지역 모자보건 프로그램
(2019 - 2023 / 700만불)
종료평가 결과보고서

2025. 2.

2024년 KOICA 국제개발협력 전문가 양성사업
M&E 과정팀
서울대학교 휴먼시스템의학과

평가보고서 관련 공지

책임 평가자 김웅한은 KOICA 본부 및 캄보디아 사무소, 수원국 정부 등 이해관계자의 도움으로 '캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 종료 평가'를 수행하였습니다. 동 보고서는 책임 평가자인 김웅한의 주도하에 작성되었으며, 평가내용 및 편집 일체에 대한 책임은 평가자에게 있습니다.

평가 완료일 : 2025년 2월 18일

평가자

책 임 평 가 자 : 김웅한 (서울의대 휴먼시스템의학과)

평 가 전 문 가 : 허종호 (서울의대 휴먼시스템의학과)

평 가 보 조 원 : 김윤진 (서울의대 이종욱글로벌의학센터) 외 KOICA 대학원 ODA
전문가 양성과정(M&E) 수강생 16명

평가 품질심의 완료일 : 2025년 6월 16일

평가품질 등급 : B

평가품질 검토위원

위 원 장 : 김혜애 (경기환경에너지진흥원장)

외 부 위 원 : 이은석 (대외경제정책연구원 부연구위원)

외 부 위 원 : 정지선 (대외경제정책연구원 선임연구원)

외 부 위 원 : 최순영(월드비전 국제사업본부 본부장)

본 보고서의 평가결과, 해석 및 결론은 한국국제협력단 사업수행 관계자의 의견과 일치하지 않을 수 있습니다. 동 보고서의 사실관계에 대한 평가팀과 피평가자(KOICA 및 사업수행기관) 간 이견이 접수된 경우, 해당 내용은 본문에 삽입된 사실관계확인서를 통해 확인하실 수 있습니다.
또한 동 보고서는 KOICA 독립평가패널의 평가 품질검토 심의를 거쳤습니다. 품질 등급이 A~C인 보고서는 품질 기본 요건을 갖춘 보고서, 품질 등급이 D인 경우 품질 요건에 미부합하는 보고서로 사업평가등급을 제외한 본문만을 공개하오니 참고하시기 바랍니다.

본 연구보고서의 내용은 출처와 집필자 명시 하에 인용이 가능하며, 아래와 같이 표기 바랍니다.
장서희. 2024. KOICA 말라위 중부지역 지속가능농업 및 조합 가치사슬 개선을 통한 소득증대사업(2021-2023/1,927백만원) 종료평가 결과보고서. 성남:한국국제협력단.

평가 등급 결과표

○ 평가대상 사업명 : 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램(2019-2023 / 700만불)

평가 기준	핵심 질문	점수		산정 이유
1. 적절성	· 사업은 이해관계자의 주요 정책 및 수요(needs), 우선순위를 반영하여 설계(design)되었는가?	4	/4점	사업 내용이 소수민족 위주의 지역 특수성과 수요를 적절하게 반영하였고 캄보디아의 CPC 및 주보건국과의 협력 하에 지역사회-의료시설 간의 서비스 연계성을 고려함
	· 내·외부 상황변화에 맞추어 사업 설계를 적절히 관리 및 유지하였는가?	4	/4점	사업초기, 코로나19에 대해 적절하게 대응하여 지역사회의 코로나 대응 물품 제공 비대면 방역 활동 등을 수행함
	적절성 평점(a)	4	/4점	
2. 일관성	· (내적 일관성) 한국 정부, 국내 타 기관, KOICA 타 사업, 주요 국제규범 및 기준과의 상호보완성, 조화/조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?	4	/4점	SDGs의 주요 및 세부 목표, 대한민국의 CPS 전략, KOICA의 보건 분야 중기전략에도 부합
	· (외적 일관성) 현지 내 타 주체(타 공여기관, 수원국 정부 및 민간분야)의 개입과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?	4	/4점	캄보디아의 보건분야 국가 정책과의 일관성 및 H-EQIP과의 상보성. CNP 등의 사업과의 조율 등을 추진함
	일관성 평점(b)	4	/4점	
3. 효과성	· 사업의 직접적, 일차적 산출물(output)을 계획한대로 달성하였는가?	3	/4점	일부를 제외한 대부분의 산출물 지표 목표를 초과 달성함
	· 사업의 중장기 성과(outcome) 및 목표(goal)를 달성하였거나 달성할 것으로 예상하는가?	2.7	/4점	객관적인 의료서비스 이용 지표에 있어서 목표를 달성하지 못하였으나 코로나19의 영향 및 불가피했던 몬둘끼리주의 비협조 등을 고려
	· 해당 사업 사회적 소외계층을 포용하여 형평성있게 성과를 달성하였는가?	3.9	/4점	사업의 지역 및 대상 자체가 소외된 소수민족을 목표로 하고 있으나 더욱 소외된 일부 경우 추가적인 형평성 개선 여지 확인
	효과성 평점(c)	3.2	/4점	

평가 기준	핵심 질문	점수		산정 이유
4. 효율성	· 사업은 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가?	4	/4점	사업 진행 순연에도 사업 기간의 연장 없이 소기의 성과를 올림
	· 사업은 주요 투입 및 활동 간 균형, 상호작용을 고려하여 효율적으로 추진되었는가?	4	/4점	주립병원-보건소-마을보건요원-아웃리치 프로그램이라는 의료시설과 지역사회의 연계, 공급자와 수요자 측면의 동시 고려, 임신부터 출산, 영유아 관리까지 치료와 예방의 연계를 고려한 보건의료서비스의 연속성을 고려함
	효율성 평점(d)	4	/4점	
5. 지속 가능성 (준비도)	· 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기대응 능력을 갖추었는가?	2.8	/4점	사업 지속에 대한 공급자들의 적극적인 의지와 협력 의사가 있으나 소외지역의 자원 한계로 인해 재정적 차원에서의 주보건국 자체 역량은 미흡함
	· 사업 편익이 장기적으로 지속될 수 있는 제도적, 사회적 환경이 갖추어졌는가?	2.8	/4점	사업종료 후 사업파트너 예산으로 사업이 지속되고 VHSG 중심의 자발적 활동이 진행되고 있으나 수원 당국 차원의 구체적인 조치는 취해지지 않음
	지속가능성 준비도 평점(e)	2.8	/4점	
종합 점수 (a+b+c+d+e)		18.0 / 20점		
종합 평가 등급		매우 성공적		
KOICA 평가등급		A		

목 차

국문 요약	viii
-------------	------

Executive Summary	xvii
-------------------------	------

제 I 장 대상사업 개요	1
1. 사업 추진배경	3
2. 사업개요	5
3. 사업설계매트릭스(PDM)	6

제 II 장 평가개요	9
1. 평가의 목적과 범위	11
2. 평가매트릭스(Evaluation Matrix)	B
3. 평가 수행 단계	14
4. 평가의 한계 및 보완사항	16
5. 평가팀 구성 및 시행체계	18

제 III 장 성과 달성도	20
----------------------	----

제 IV 장 기준별 평가결과	22
1. 적절성	26
2. 일관성	30
3. 효과성	32
4. 효율성	44
5. 지속가능성	48

6. 영향력	52
7. 범분야 이슈	53

제 V 장 결론 56

1. 평가 결과	58
2. 작동요인 및 비작동요인	58
3. 교훈	61
4. 후속사업 방향 제언	61
5. 환류과제 및 교훈	63

첨부 / 66

1. 현지(원격)조사 개요(출장자·출장일정·출장지)	8· 6
2. 일별활동내역(주요 협의내용 및 평가활동 정리 서술)	2· 7
3. 평가단계별 세부 계획	7
4. 면담자 목록 및 주요 면담 질문	8
5. 설문조사지 및 설문조사 결과	9
6. 참고문헌	125
7. 건축, 기자재, 소모품 점검 결과(라따나끼리 주 국한)	71
8. 준실험적 방법을 적용한 통계 분석: 라따나끼리 행정데이터 분석	91
9. 세부 평가매트릭스(Evaluation Matrix)	132

표 목 차

<표 1> 평가 수행 단계 개요	41
<표 2> 성과 검증방법의 비교	71
<표 3> 단절적 시계열 분석 결과	43
<표 4> 성과 목표(Outcome)에 대한 종료평가 설문 결과	6·3

그림 목 차

<그림 1> 평가대상 지역	4
<그림 2> 4회 이상 산전관리 받은 임신부 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3
<그림 3> 전문가에 의한 분만 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3
<그림 4> 산후 48시간 이내 산후관리(PNC1) 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3
<그림 5> 산후 14일 후 산후관리 비율(PNC 2)에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3
<그림 6> 산후 6주 후 산후관리 비율(PNC 3)에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3
<그림 7> 산후 8주 후 산후관리 비율(PNC 4)에 대한 단절적 시계열 분석 결과	5... 3

국문 요약 Executive Summary



국문 요약

1. 평가대상사업 개요

- ☐ 사업명(기간/예산) : 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램('19 -'23 / 700만불)
- ☐ 대상지 : 캄보디아 라타나끼리주 및 몬돌끼리주
- ☐ 사업목적 : 모성 및 아동보건 지표가 전반적으로 향상된 캄보디아 내에서도 여전히 취약한 라타나끼리주와 몬돌끼리주의 모자보건 분야의 의료서비스 접근성과 서비스 질 향상
- ☐ 주요내용
 - 공급자의 측면에서 병원 및 보건소 시설 개선, 기자재 지원, 보건의료 인력 역량강화를 통한 해당 사업지역의 보건의료서비스의 질적 개선 및 이용 확대를 통해 산모 및 신생아의 건강 향상에 기여하고자 함.
 - 수요자 측면에서 지리적으로 접근이 어려운 격오지 마을이나 사회적·문화적으로 보건의료서비스의 수혜로부터 소외되어 있는 소수민족 거주지를 대상으로 마을보건요원(VHSG) 활동 및 아웃리치를 강화하여 접근성을 개선하고 지역사회 보건 인식개선과 역량 강화를 목표로 함

2. 평가의 목적

- ☐ 본 사업은 2023년도에 종료된 국별협력사업으로, 본 종료평가를 통해 사업 종료 시점의 성과 점검과 사업 기획 및 수행 과정, 사후 운영 준비도의 적정성을 판단하고자 함
- 사업의 집행 계획과 실제 수행 내용이 일치하는지 검토하고 당초 의도한 산출물의 달성도, 사업 초기 성과와 중장기 성과, 영향의 달성 가능성 등을 측정함으로써, 사업 기획 및 수행 과정의 적정성을 판단함
- 작동/비작동 요인을 분석해 평가 교훈과 환류 과제를 도출함으로써 향후 유사 사업의 원조 효과성 제고를 위한 근거로 활용함

3. 평가 방법

- 혼합연구방법론을 활용한 삼각 검증을 통해 타당도와 신뢰도 높은 평가를 수행하고 작동/비작동요인에 대한 규명과 향후 유사사업 추진을 위한 교훈 도출을 통해 향후 사업의 내실을 도모함
 - 양적 평가분석으로는, 해당 사업의 주요 수혜자 대상의 양적 평가(설문조사) 및 엄밀한 영향 평가(impact evaluation)를 위한 준실험적방법론인 Interrupted Time Series design의 적용을 통해 사업대상 지역 내 주요 성과지표의 변화를 확인하고자 함
 - 질적 평가분석으로는 이해관계자 및 수혜자 대상으로의 FGI 및 개인심층인터뷰 등을 통해 사업의 과정 및 결과, 원인 등에 대한 심층 평가를 실시함
 - 양측 결과의 통합을 통한 결과의 삼각화설계(triangulation design) 검증을 통해 평가의 질 향상
- KOICA 평가 기준을 적용하되 사업 내용과 특수성을 고려한 평가
 - 본 과업은 기초조사, 과정평가, 성과평가, 종합분석(제언 도출 및 환류)의 과정으로 수행함
 - OECD/DAC 6대 기준과 성평등을 기반으로 평가를 수행하되, 획일적이고 기계적인 평가가 아닌 본 사업의 특수성을 고려한 입체적인 평가를 계획함
- 제언 도출 방향
 - 이해관계자 입장에서 프로젝트의 작동과 비작동 요인에 대한 양, 질의 데이터 수집 및 분석을 통해 향후 KOICA에서 유사 사업 추진 시 고려 사항으로 제안함
 - 굿네이버스를 통해 진행되고 있는 자체적인 후속사업 상황과 현재 캄보디아에서 진행 중인 H-EQIP(The Health Equity and Quality Improvement Project) 사업과 시너지 효과를 유도하면서도, KOICA 예비조사가 완료된 라따나끼리 주의 “포괄적 공공 보건의료체계 역량강화사업” 등과의 연계성을 높일 수 있는 사업의 환류 과제 등을 제언하고자 함

4. 평가 결과 및 등급

- 5개 평가 기준(적절성, 일관성, 효과성, 효율성, 지속가능성)에 대한 평가팀의 평가결과는 18.0점으로 성공적이었으며, KOICA 평가등급은 A임

5. 기준별 주요 평가 결과 요약

□ 총평

- 대상 사업은 공급자 측면에서의 건축 및 의료진 역량 강화를 통한 모자보건 서비스의 질 향상과 더불어 VHSG 및 아웃리치 활동을 포함한 지역사회 중심의 사업수행 결과, 코로나 19로 인한 모자보건 관련 서비스 이용률의 급감에도 불구하고 보건의료서비스에 대한 접근성 및 신뢰도 향상 및 모자보건 관련 인식과 태도, 행태의 근본적인 변화를 가져옴
- 이를 가능하게 한 요인은 ① 물리적 접근성의 문제를 해결하기 위한 지역사회 중심, 수요자 중심의 사업 수행, ② 사업파트너 간의 신뢰와 협력 구축, ③ 수요에 맞춘 의료진 역량 강화, ④ 기자재 지원과 함께 역량교육을 제공해 주는 사업자원 제공 방식에 기인한다고 볼 수 있음
- 그러나, ① 문물끼리 지역 내 사업 수행의 어려움, ② 기자재 관리, 활용 역량의 부족, ③ 언어적, 문화적 장벽으로 인한 일부 의료진 서비스 제공 태도의 불만족 ⑥ 전원체계의 미흡은 추후 보완해야 할 사항으로 판단됨

□ 적절성

- (사업 대상지역의 특수성 반영한 기획) 대상 사업은 모자보건 사업이 필요한 소외된 지역의 특성을 반영하고 특유의 문제점을 보완할 수 있도록 사업 내용이 구성되어 있음
- (파트너 기관의 적절성) 순천향대 중앙의료원 및 굿네이버스가 오랜 기간 캄보디아에서 활동하며 경험과 역량을 축적했으며 각 파트너 기관이 가진 의료 및 지역사회 활동의 강점을 가진 활동을 주도하고 상호 보완하는 방식으로 사업이 이행되었다는 점에서 사업수행 주체의 선정은 적절하다고 할 수 있음
- (사업 기획의 적절성) 사업 기획 시, 주립병원-보건소-마을보건요원-아웃리치 프로그램이라는 의료시설과 지역사회의 연계, 공급자와 수요자 측면의 동시 고려, 임신부터 출산, 영유아 관리까지 치료와 예방의 연계를 고려한 보건의료서비스의 연속성을 고려한 사업요소 설계가 되었다는 것이 본 사업체계의 강점임
- (의료진 역량강화 비중) 다만, 지역사회 중심의 활동 비중이 크고 우선적으로 실시되다 보니 의료진의 서비스 역량 개선에는 현실적인 제한점이 있었던 것으로 판단되며 이는 관련 성과지표 미달성 원인의 일부로 판단됨

□ 일관성

- (내적일관성) SDGs의 주요 및 세부 목표, 대한민국의 CPS 전략, KOICA의 보건 분야 중

기전략에도 부합하는 것으로 평가됨

- (외적일관성) 캄보디아의 보건 분야 국가 정책과의 일관성 및 H-EQIP과의 상보성을 가지고 있음
 - 사업지역에서 월드뱅크의 ‘캄보디아 영양강화 사업(CNP, Cambodia Nutrition Project)’이 진행되어 월드뱅크와도 사업 시너지 효과 및 중복지원 방지 위한 분기별 회의를 추진함
 - 대상 사업은 관련 시설 및 백신 인식개선 교육을 종합적으로 제공함으로써 백신을 전국적으로 공급하고 있는 UNICEF 및 GAVI의 사업과는 상호보완적임

□ 효과성

- (산출물 및 성과지표 달성) PDM에서 제안한 산출물 지표는 목표치 또는 초과한 달성률을 보여 사업의 수행 자체에 대해서는 탁월성을 보임
 - 다만, 성과 목표 중 4회 이상의 산전 관리, 전문가에 의한 분만 및 산후 48시간 이내 산후 관리의 3가지 객관적 지표는 목표치를 미달성함
- (단절적 시계열 분석 결과) 미달성한 3가지 지표에 대해 라따나끼리주 행정데이터를 활용한 단절적 시계열 분석 결과, 산전 관리와 전문가에 의한 분만 이용률은 코로나19로 인한 유의미한 단절적 이용률 급감을 상승시키는 성과를 보였으나 통계적으로 유의미한 추세의 변화는 아님
- (PNC 2~4의 추가 분석) 추가적으로, PDM에서 설정하지 않은 산후 14일, 6주, 8주 후의 PNC 서비스 이용에 대해서 분석한 결과, 사업 이전의 이용률 하향 추세를 통계적으로 유의미하게 반전시켜 이용률을 높이는 긍정적인 사업의 효과를 확인함
- (사업 종료 이후) 사업 종료 후 통계적으로 유의미한 단절적인 변화나 추세의 변화는 없어 사업의 효과는 지속되고 있는 것으로 확인되어 사업 기간 이후 지속하고 있는 굿네이버스의 지역사회 중심의 자체 사후관리의 효과가 일부 기여한 것으로 볼 수 있음
- (설문조사 결과) 종료평가의 설문 결과는 좀 더 고무적으로 나타나, 서비스 만족도는 유사한 수준으로 유지되고 있으며, PNC를 제외하고는 전문가에 의한 분만과 4회 이상 산전 관리 이용률은 종료선 보다 높은 수치를 보여주고 있음
- (문돌끼리주의 제한적 사업수행) 문돌끼리 주 대상의 사업의 경우 계획대로의 사업 진행이 불가능하게 되면서 일부 공급자에 대한 교육과 기자재 지원, 일부 지역에 대한 아웃리치만 제한적으로 이뤄진 것으로 파악됨
- (질적 면담 결과|수요자) 수요자 측면에서는, 특히 가족 대상 홍보 및 교육, 소외지역의 아

아웃리치 서비스와 교육된 지역사회 VHSG를 통해 지역사회의 모자보건 서비스에 대한 만족도가 상승하고 인식과 행태가 개선됨

- (질적 면담 결과|공급자) 공급자들은 대상 사업이 지역 모자보건 서비스 체계 개선에 기여했다고 평가하며 환자 경험 및 대처역량이 증진하여 보건소 출산 비율이 증가하고 이를 데이터화하고 관리하는 등 행정적인 역량도 강화되었다고 보고함
 - 특히, 교육 및 시설 지원을 통해 의료서비스 제공 능력이 향상되었음을 강조함. 특히 교육수요가 반영된 역량강화 사업에 대해서 전반적으로 높게 평가하고 있었으나, 의사 대상 및 CEmONC 단계의 심화 교육에 대해서는 수요를 충족하기에 부족함
- (건축 및 기자재) 건축 및 기자재 제공으로 모자보건 서비스의 질 향상 및 만족도 향상을 가져옴
 - 다만, 일부 기자재의 경우 활용 인력의 역량 부족 등으로 사용되지 않거나 기자재가 지급되지 않아 현장의 필요에 대응하지 못한 경우도 확인할 수 있었음

□ 효율성

- (코로나19 대응) 2020~2021년 코로나-19 팬데믹 발생 이후 사업계획을 적절하게 변경하여 코로나 긴급 대응 활동을 기획하여 현실에 맞게 비대면 방식으로 활동을 수행함
 - 일부 국제개발협력 사업의 경우와 같이 코로나19로 인한 목표 하향 또는 사업 연장이 이뤄진 것에 비해 계획 변경 없이 소기의 목표를 달성한 점, 또한 효율성 측면에서 높이 평가될 지점임
- (공급자 입장) 본 사업의 아웃리치 활동을 통해 예방접종 및 교육에 대한 서비스 제공 시간의 효율성이 향상된 것에 대한 만족감을 확인함
- (공급자 교육의 방식) 전형적인 의료진의 연수사업 대신 보건부 산하 위탁 교육 등을 통한 의료진 교육을 실시하여 효율성을 높이고 기존에 교육을 받은 사람들이 받지 못한 동료 또는 전달체계의 하부로 교육을 전파하는 ToT(Training of Trainers) 형태로 교육함으로써 교육이 효과적이고 효율적으로 전파되고 유지되고 있는 것을 확인함
- (기자재 활용) 제공된 기자재의 경우, 효율적으로 활용을 하고 있으나 일부의 경우 제공 사실의 혼동 및 관리 부실이 있음
- (사회적 자본의 구축) 수혜자들의 건강 증진을 위해 대상 사업의 수행을 통해 코이카-파트너 기관-현지 주보건국-지역사회 간의 신뢰와 협력이라는 사회적 자본을 구축할 수 있었고 코로나19에 민첩하게 대응하고 단기간에 성공적인 사업의 성과를 올릴 수 있었음

- (전원체계 개선) 응급 상황 시 이동 수단의 부족이 효율성을 낮추는 요인으로 작용하고 있어 후속 사업에서 체계적인 응급의료 전원체계 개선의 필요성을 반영할 필요가 있음

□ 지속가능성

- (H-EQIP 사업과의 연계) 현재 캄보디아의 H-EQIP 사업으로 조성된 건강 형평성 기금 (HEF)을 통해 빈곤층 및 저소득 가정을 상대로 의료비를 지불해 주고 있어 후속 사업의 지속가능성을 보장하는 하나의 요인으로 작용할 수 있음
- (사업지속의 의지 및 자발적 활동) 보건의료서비스 공급자와 수요자 모두 사업 지속의 의지가 강하고 자발적인 지속활동도 있어 지속가능성의 측면에서도 양호함
 - 현지 보건부 주요 직원 면담에 따르면, 프로젝트 종료 이후에도 사업을 지속할 의지가 강하게 존재하나 안정적인 운영을 위해서는 지속적인 예산 지원이 필수적일 것으로 보임
 - 수요자의 경우, 여러 사회경제적 맥락에서 자원이 빈곤함에도 불구하고 특히, 산모 및 가족 등 KIRI Class 참여경험자의 경우, 후속 사업 참여 의향이 높고 일부 자조 모임은 사업 종료 후에도 지속되고 있어서 후속 사업의 요소로 반영하여 사업 수행 지역을 확대할 필요가 있음
 - VHSG들은 보건소에서 제공되던 교육이 사업 종료 후 더 이상 제공되지 않아 아쉬움을 느끼고 있었으며 일부 지역에서는 굿네이버스의 지원 하에 VHSG들의 교류나 회의를 지속하는 등 주인의식을 가지고 자체적인 활동을 하고 있음
- (시설 및 장비 운용) 시설, 장비운용 등은 전반적인 활용 수준은 양호하나, 인력 교육과 감염관리, 장비 관리에서 추가적인 역량 강화 기회 마련이 요구됨

□ 영향력

- (전반적 건강관리의 개선) 수혜자들은 사업 참여경험을 통해 기존의 건강관리 방식의 지식, 태도, 실천의 변화가 있었으며 이러한 건강 관리는 생활의 타 분야에도 적용되고 있음
- (보건의료행정 역량 강화) 공급자들은 사업 이후 정부 및 지역사회 간 신뢰 관계 향상, 보건소와 VHSG 간 협력 체계 강화와 더불어 보건소 및 OD의 데이터화 및 정책 관리 등 보건의료행정 역량도 강화되어 전반적인 보건의료체계역량 강화에 기여함
- (보건소에 대한 신뢰 향상) 특히, 보건소에 대한 지역사회의 신뢰 수준이 향상되었으며, 이러한 점들이 보건소의 이용행태에 대해 긍정적인 영향력을 행사한 것으로 보고함

□ 범분야 소결

- (소수민족 주류화) 대상 사업 자체가 캄보디아 내 소외된 지역을 대상으로 이뤄진 사업으로 사업의 목적과 성과로 인권주류화에 기여하는 바가 있음
- (여성 지위 향상) 대상 사업을 통해 여성 건강에 대한 인식개선 및 접근성이 강화될 뿐만 아니라 여성 VHSG 활동으로 일방적 수혜자에서 주도자로 전환시키며 지역사회 여성의 참여율을 높임
- (성평등 기여) 대상 사업의 KIRI Class의 경우 남편과 시어머니도 교육에 참여하도록 설계되어 여성의 모자보건 서비스 이용 및 출산 후 여성의 신체 회복과 육아 부담 경감을 위한 남성의 역할이 강조되어 성평등 관점에서 개선이 있었음

6. 작동요인 및 비작동요인

1) 수요자 측 작동요인

- (지역사회 중심의 사업수행) VHSG 및 보건소의 아웃리치 활동 등을 통한 교육과 홍보, 모자보건 서비스 제공 등을 통하여 현대적 모자보건 서비스에 대한 인식개선을 이룬 것이 사업의 핵심적인 작동요인으로 판단됨
- 물리적 접근성의 문제를 해결하기 위해 지역사회 중심, 수요자 중심의 사업 수행을 통해 사업지역 전반에 걸쳐 지역사회의 모자보건 관련 인식과 행태의 기준(social norm)의 변화를 가져온 것으로 볼 수 있음

2) 공급자 측 작동요인

- (사업파트너 간의 신뢰와 협력) 코로나19로 인한 사업의 지체 및 몬톨끼리주에서의 사업 수행의 미진 등의 어려움 속에서도 단기간 내에 성과를 이룬 것의 가장 근본적인 작동요인은 신뢰에 근거한 코이카-파트너 기관-현지 후보건국-지역사회와의 밀착된 협력 관계임
- (의료진 역량 강화) 교육 및 시설 지원을 통해 의료서비스 제공 능력이 향상되었음을 강조함. 특히 교육수요가 반영된 역량강화 사업에 대해서 전반적으로 높게 평가하고 있었음
- (사업의 자원 제공방식) JICA, GAVI와 UNICEF 등이 건축, 백신 현물 등 일부분을 단편적으로 지원해주는 것에 비해 KOICA 사업의 특징은 기자재 지원과 함께 교육을 제

공해 주는 것이 사업의 효과성과 효율성을 높인 것으로 평가할 수 있음

3) 수요자 측 비작동요인

- ☐ (언어적, 문화적 장벽으로 인한 의료진 서비스 제공 태도의 불만족) 언어적, 문화적 장벽이 상대적으로 큰 소수민족일수록 치료진의 비우호적인 태도와 지지로 인해 서비스 만족도 및 서비스 이용률이 떨어지는 모습을 볼 수 있음
- ☐ (의료진 부족 및 대기시간 소요) 일부의 경우, 보건소 방문 시 의료진의 부족으로 인하여 긴 대기 시간 및 대기 장소 미흡에 대한 불만이 보고됨
- ☐ (전원체계의 미흡) 구급차 공급 등으로 보건소-주립병원 간의 전원 체계가 강화되었으나 여전히 원거리 마을에서 보건소까지의 접근성 문제는 여전히 개선이 필요한 것으로 파악됨

4) 공급자 측 비작동요인

- ☐ (몬돌끼리주 리더십의 비협조) 몬돌끼리 주 대상의 사업의 경우 주보건국의 리더십 문제로 계획대로의 사업 진행이 불가능하게 되면서 일부 공급자에 대한 교육과 기자재 지원만 제한적으로 이뤄짐
- ☐ (기자재 관리, 활용 역량의 부족) 건축 및 기자재 제공으로 인하여 모자보건 서비스의 질 향상 및 만족도 향상을 뒷받침할 수 있었으나 일부 기자재의 경우 활용 인력의 역량 부족 또는 관리 부실, 미활용 사례도 확인할 수 있었음

7. 환류 과제

- VHSG 및 아웃리치 활동이 지역사회의 인식 및 행태 변화에 결정적이며 주인의식을 기반으로 한 자율적 활동이 지속되고 있음. 따라서 후속 사업에서도 VHSG 주도 지역사회 보건인식 개선을 지속할 수 있도록 후보건국-보건소를 통한 VHSG 역량강화를 지원할 필요가 있음
- (의료서비스 제공에 있어서의 언어적, 문화적 장벽 해소) 다양한 언어로 된 교육 자료 제공이 강화될 필요가 있으며 소수민족 비율이 높은 지역의 경우, 소수민족 언어 사용이 가능한 VSHG를 채용하여 의료서비스로의 접근성과 만족도를 높이는 방안이 필요함
- (기자재 추가지원 및 관리와 활용을 위한 역량 강화) 기증한 시설, 장비 운용 등은 전반적인 활용 수준은 양호하나, 일부 관리부실 및 미활용 사례가 보고됨. 현장 수요에 기초한 추가적인 기자재 지원 및 장비 관리 및 활용을 위한 추가적인 역량 강화 기회 마련이 요구됨

Executive Summary

1. Projects to be evaluated

- ☐ Project Name(Period/Budget) : Maternal and Child Health Program for the Isolated Regions of Northeastern Cambodia ('19-'23 / \$7 million)
- ☐ Target Area : Ratanakiri and Mondulakiri Provinces, Cambodia
- ☐ Project Purpose : Improving access to and quality of maternal and child health services in the still-vulnerable provinces of Ratanakiri and Mondulakiri, even within Cambodia, where maternal and child health indicators have improved overall.
- ☐ Key points
 - From the perspective of providers, the project aims to contribute to improving the health of mothers and newborns by improving the quality of health services and expanding their use in the target areas through improvements to hospitals and health center facilities, equipment support, and the strengthening of the capabilities of healthcare personnel.
 - From the perspective of consumers, the goal is to improve accessibility and strengthen the health awareness and capabilities of local communities by strengthening the activities and outreach of Village Health Support Group (VHSG) workers in remote villages that are difficult to access geographically or in minority ethnic settlements that are socially and culturally marginalized from health and medical services.

2. Purpose of the evaluation

- ☐ This project is a country-specific cooperation project that ended in 2023,

and this evaluation aims to check the performance at the end of the project and to determine the adequacy of the project planning and implementation process and the adequacy of the post-project operation preparation.

- The adequacy of the project planning and implementation process is determined by reviewing whether the project execution plan matches the actual implementation and by measuring the achievement of the intended initial outputs, the initial and mid- to long-term performance, and the feasibility of achieving the impact.
- By analyzing the factors that affect the operation and non-operation of the project, the evaluation will derive lessons learned and feedback to be used as a basis for improving the effectiveness of future aid projects.

3. Evaluation method

- ☐ A mixed-methodology triangular verification will be used to conduct a highly valid and reliable evaluation, and the identification of factors that affect the operation and non-operation of the project and the derivation of lessons learned for the promotion of similar projects in the future will help to strengthen the future project.
- In quantitative evaluation and analysis, the changes in key performance indicators in the project area are to be identified through a quantitative evaluation (survey) of the main beneficiaries of the project and the application of the Interrupted Time Series design, a quasi-experimental methodology for rigorous impact evaluation.
- In qualitative evaluation and analysis, an in-depth evaluation of the process, results, and causes of the project is to be conducted through focus group interviews and in-depth individual interviews with stakeholders and beneficiaries.
- Improve the quality of evaluation by verifying the triangulation design of the results through the integration of the results of both sides.
- ☐ Apply the KOICA evaluation criteria, but evaluate the project content and

its particularities.

- This task is carried out in the following process: basic research, process evaluation, performance evaluation, and comprehensive analysis (recommendation derivation and feedback).
- The evaluation will be conducted based on the six OECD/DAC criteria and gender equality, but a three-dimensional evaluation that takes into account the special nature of this project, rather than a uniform and mechanical evaluation, is planned.
- Direction of deriving recommendations
- Through the collection and analysis of quantitative and qualitative data on the factors that affect and do not affect the operation of the project from the perspective of stakeholders, the results will be proposed as considerations for similar projects to be promoted by KOICA in the future.
- We would like to recommend a project that can induce synergy with the H-EQIP (The Health Equity and Quality Improvement Project) project currently underway in Cambodia and the KOICA preliminary survey of the “Comprehensive Public Health and Medical System Capacity Building Project” in Ratnakiri Province, while also promoting the flow-back of projects that can increase the connection with the KOICA preliminary survey.

4. Evaluation Results and Grades

- ☐ The evaluation team's evaluation results for the five evaluation criteria (appropriateness, consistency, effectiveness, efficiency, and sustainability) were successful with a score of 18.1, and the KOICA evaluation rating was A.

5. Summary of major evaluation results by criteria

- ☐ General comment
 - The target project is to improve the quality of maternal and child health services by strengthening the capabilities of suppliers in terms of construction and medical staff, and to improve the accessibility and reliability of

healthcare services, as well as to fundamentally change the perceptions, attitudes, and behaviors related to maternal and child health as a result of community-oriented projects, including VHSG and outreach activities.

- The factors that made this possible can be attributed to (1) community-based, consumer-oriented business operations to solve the problem of physical accessibility, (2) building trust and cooperation among business partners, (3) strengthening the capabilities of medical staff to meet demand, and (4) providing business resources that provide equipment support and capacity training.
- However, the following issues should be addressed in the future: (1) Difficulties in conducting business within the Mondulkiri region, (2) Lack of equipment management and utilization capabilities, (3) Dissatisfaction with the attitude of some medical staff toward service provision due to language and cultural barriers, and (6) Inadequate power supply system.

☐ Appropriateness

- (Planning that reflects the particularities of the target business area) The target business is structured to reflect the characteristics of marginalized areas that need maternal and child health projects and to address their unique problems.
- (Appropriateness of partner organizations) Soon Chun Hyang University Medical Center and Good Neighbors have accumulated experience and capabilities through their long-term activities in Cambodia, and the project was implemented in a way that led and complemented the strengths of each partner organization's medical and community activities, so the selection of the project implementation entity can be considered appropriate.
- (Appropriateness of business planning) The strength of this business system is that it has been designed to take into account the continuity of healthcare services, which takes into account the linkage between medical facilities and the local community, simultaneous consideration of the perspectives of both the supplier and the consumer, and the linkage between treatment and prevention from pregnancy to childbirth and infant care.

- (Percentage of strengthening the capabilities of medical staff) However, since the proportion of community-oriented activities is large and they are carried out on a priority basis, it is judged that there were realistic limitations in improving the service capabilities of medical staff, which is considered to be part of the reason for the failure to meet the relevant performance indicators.

□ Consistency

- (Internal consistency) It is evaluated as being consistent with the main and detailed goals of the SDGs, the CPS strategy of the Republic of Korea, and the medium-term strategy for the health sector of KOICA.
- (External consistency) Consistency with Cambodia's national health policy and complementarity with H-EQIP.
 - The World Bank's 'Cambodia Nutrition Project (CNP)' is being carried out in the project area, so quarterly meetings are held with the World Bank to prevent project synergy and overlapping support.
 - The target project is complementary to the projects of UNICEF and GAVI, which supply vaccines nationwide by providing comprehensive training on related facilities and improving vaccine awareness.

□ Effectiveness

- (Achievement of deliverables and performance indicators) The deliverable indicators proposed by PDM show the target value or the achieved rate that exceeds it, demonstrating excellence in the performance of the project itself.
 - However, the three objective indicators of prenatal care for four or more times, delivery by a specialist, and postnatal care within 48 hours of delivery, which are among the performance targets, did not meet the target.
- (Results of Discrete Time-Series Analysis) For the three indicators that were not met, the results of discrete time-series analysis using administrative data from the province of Ratnankari showed that the utilization rate of prenatal

care and professional delivery services increased, proving the effectiveness of the project by offsetting the sharp drop in utilization rates due to COVID-19.

- (Additional analysis of PNC 2-4) In addition, an analysis of the use of PNC services 14 days, 6 weeks, and 8 weeks after childbirth, which is not set in PDM, confirmed the positive effect of the business on increasing the usage rate by reversing the downward trend in the usage rate before the business transfer.
- (Survey results) The survey results of the end-line evaluation were more encouraging, with service satisfaction remaining at a similar level and the utilization rate of expert deliveries and four or more prenatal care visits, except for PNC, showing higher numbers than the end-line.
- (Limited business execution for the target of the mutual aid group) In the case of the business for the target of the mutual aid group, it is understood that the business could not be carried out as planned, and only limited training for some suppliers, equipment support, and outreach to some regions were carried out.
- (Qualitative interview results|consumer) From the consumer's perspective, satisfaction with maternal and child health services in the community has increased, and awareness and behavior have improved, particularly through family-targeted publicity and education, outreach services in underserved areas, and trained community VHSGs.
- (Qualitative interview results|Suppliers) Suppliers evaluated that the target business contributed to improving the local maternal and child health service system, and reported that the administrative capacity was strengthened, such as the increase in the proportion of births at health centers due to the improvement in patient experience and coping capabilities, and the data collection and management of such data.
 - In particular, the ability to provide medical services has been improved through education and facility support. In particular, the capacity-building project, which reflected the demand for education, was highly evaluated overall, but the demand for in-depth education for doctors and CEmONC stages was insufficient to meet the demand.

- (Construction and equipment) Construction and equipment have improved the quality of maternal and child health services and satisfaction.
- However, in some cases, some equipment was not used due to a lack of capacity among the personnel who were to use it, or the equipment was not provided, so it was not possible to meet the needs of the site.

□ Efficiency

- (COVID-19 response) Since the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, the business plan has been appropriately changed to plan for emergency COVID-19 response activities and to carry out activities in a non-face-to-face manner that is tailored to the current situation.
 - In some cases of international development cooperation projects, the target was lowered or the project was extended due to COVID-19, but the project achieved its intended goals without changing the plan, which is also highly regarded in terms of efficiency.
- (From the perspective of the supplier) Satisfaction was confirmed that the outreach activities of this project improved the efficiency of the service provision time for vaccinations and education.
- (Method of supplier training) Instead of the typical training program for medical staff, medical staff is trained through commissioned training under the Ministry of Health to increase efficiency and ensure that the training is effectively and efficiently disseminated and maintained by conducting training in the form of Training of Trainers (ToT) that spreads the training to colleagues or lower levels of the delivery system who have not received the training.
- (Utilization of equipment) In the case of the equipment provided, it is being used efficiently, but in some cases, there is confusion about the fact that it was provided and poor management.
- (Building social capital) In order to improve the health of beneficiaries, the project was carried out to build social capital of trust and cooperation between KOICA, partner organizations, local public health centers, and local

communities, and it was possible to respond quickly to COVID-19 and achieve successful results in a short period of time.

- (Improving the emergency system) The lack of transportation in emergency situations is a factor that reduces efficiency, so it is necessary to reflect the need for a systematic improvement of the emergency medical transportation system in subsequent projects.

☐ Sustainability

- (Connection with the H-EQIP Project) Currently, the HEF created by the H-EQIP project in Cambodia is paying medical expenses for the poor and low-income families, which may serve as a factor in ensuring the sustainability of follow-up projects.
- (Willingness to continue business and voluntary activities) Both healthcare service providers and consumers are strongly willing to continue business and there are also voluntary activities to continue, which is good in terms of sustainability.
 - According to interviews with key local health department officials, there is a strong willingness to continue the business even after the project ends, but continued budget support will be essential for stable operation.
 - In the case of consumers, despite the lack of resources in various socio-economic contexts, especially in the case of KIRI Class participants such as mothers and families, there is a high willingness to participate in follow-up projects, and some self-help groups continue even after the project ends, so it is necessary to reflect this as an element of follow-up projects and expand the areas where the project is carried out.
 - VHSGs were disappointed that the education provided by health centers was no longer available after the project ended, and in some areas, VHSGs are continuing their exchanges and meetings with the support of Good Neighbors, taking ownership of their own activities.
- (Facilities and equipment operation) The overall utilization of facilities and equipment is good, but opportunities for additional capacity building in

personnel training, infection control, and equipment management are required.

☐ Impact

- (Improvement of overall health management) The beneficiaries have experienced changes in their knowledge, attitudes, and practices of existing health management methods through their participation in the project, and these health management methods are being applied to other areas of their lives.
- (Strengthening health care administration capabilities) Suppliers have contributed to strengthening the overall health care system by improving the relationship of trust between the government and the community after the project, strengthening the cooperation system between health centers and the VHSG, and enhancing the health care administration capabilities of health centers and ODs, including data collection and policy management.
- (Improving trust in health centers) In particular, the level of trust in health centers among the local community has improved, and it is reported that these factors have had a positive impact on the use of health centers.

☐ Cross-sectors

- (Mainstreaming of ethnic minorities) The target project itself is a project that targets marginalized areas in Cambodia, and the project's purpose and achievements contribute to the mainstreaming of human rights.
- (Improving the status of women) The target project not only improves awareness and accessibility to women's health, but also transforms women from passive beneficiaries to active participants through VHSG activities, increasing the participation rate of women in the community.
- (Contribution to gender equality) In the KIRI Class of the target project, the husband and mother-in-law are also designed to participate in the training, emphasizing the role of men in improving women's access to maternal and child health services and reducing the physical recovery and parenting burden

of women after childbirth, which has been improved from a gender equality perspective.

6. Operating factors and non-operating factors

1) Operating factors on the consumer side

- ☐ (Community-based project implementation) The project is considered to have achieved its core objective of raising awareness of modern maternal and child health services through education, promotion, and maternal and child health services provided through VHSGs and health centers' outreach activities.
- ☐ It is believed that the project has brought about a change in the social norms of the community's awareness and behavior regarding maternal and child health throughout the project area by implementing community-based and consumer-oriented projects to address the issue of physical accessibility.

2) Supplier-side operational factors

- ☐ (Trust and cooperation between business partners) The most fundamental operational factor behind the achievement of results in a short period of time despite the difficulties of business delays due to COVID-19 and poor business performance in the province of Mondulkiri is the close cooperative relationship between KOICA, partner organizations, the local provincial health department, and the local community based on trust.
- ☐ (Strengthening the capacity of medical staff) Emphasize that the ability to provide medical services has been improved through education and facility support. In particular, the capacity-building project, which reflected the demand for education, was highly evaluated overall.
- ☐ (Method of providing resources for the project) While JICA, GAVI, and UNICEF, etc. provide support in a fragmented manner, such as construction and vaccines in kind, the KOICA project is characterized by providing equipment and education, which is considered to have increased the effectiveness and efficiency of the project.

3) Non-operational factors on the consumer side

- ☐ (Dissatisfaction with the attitude of medical staff toward service provision due to linguistic and cultural barriers) The more the minority group has relatively large linguistic and cultural barriers, the lower the service satisfaction and service utilization rate due to the unfriendly attitude and support of the medical staff.
- ☐ (Lack of medical staff and long waiting times) In some cases, there have been complaints about long waiting times and inadequate waiting areas due to a lack of medical staff when visiting health centers.
- ☐ (Insufficient transfer system) Although the transfer system between health centers and state-run hospitals has been strengthened through the provision of ambulances, the accessibility problem from remote villages to health centers still needs to be improved.

4) Non-operational factors on the supplier side

- ☐ (Inconsistent leadership of the Mondulkiri province) In the case of projects in the Mondulkiri province, the province's health department's leadership issues have made it impossible to carry out the projects as planned, so only limited training and equipment support has been provided to some suppliers.
- ☐ (Lack of equipment management and utilization capacity) Although the provision of construction and equipment has helped improve the quality and satisfaction of maternal and child health services, some equipment has been used ineffectively due to a lack of capacity or poor management, and there have been cases of equipment not being used.

7. Operating factors and non-operating factors

- ☐ The VHSG and outreach activities are crucial to changing the community's perception and behavior, and autonomous activities based on ownership are continuing. Therefore, it is necessary to support the strengthening of the VHSG's capabilities through the Provincial Health Office and health centers so that the VHSG-led community health awareness improvement can

continue in subsequent projects.

- (Eliminating linguistic and cultural barriers to healthcare services) It is necessary to strengthen the provision of educational materials in various languages, and in areas with a high proportion of ethnic minorities, there is a need to increase the accessibility and satisfaction of healthcare services by hiring VSHGs who can speak the languages of ethnic minorities.
- (Strengthening capabilities for equipment donation support, management, and utilization) The overall utilization of donated facilities and equipment is good, but some cases of poor management and underutilization have been reported. Additional opportunities for equipment support and strengthening capabilities for equipment management and utilization based on on-site demand are required.

제 I 장

대상사업 개요

1. 사업 추진배경
2. 사업개요
3. 사업설계매트릭스
(PDM)



제 I 장 대상사업 개요

1. 사업 추진배경

- 캄보디아는 보건분야개발전략 2단계(Health Strategic Plan II, HSP2/2008-2015)의 이행을 통해 Millennium Development Goals(MDGs)의 모자보건 목표4 및 5a인 모성사망률과 5세 이하 영유아사망률을 달성하는 성공적인 결과를 얻었음(Kingdom of Cambodia, 2016)
- 그러나, 한편으로는 보건의료인력의 역량 및 보건의료 관련 인프라의 부족으로 인한 보건의료서비스의 질적 한계와 지역 간 건강 불평등에 관한 문제가 제기됨(WHO, 2104)
- 이에 당시 캄보디아 정부는 보건분야개발전략(HSP3/2016-2020) 및 모성·신생아 건강개선 로드맵(Fast Track Initiative Road Map for Reducing Maternal and Newborn Mortality 2016-2020)을 수립하여, 격오지역 아웃리치 서비스 확대, 보건소 및 병원 의료장비 지원 및 인프라 확충 등 모성 및 신생아 건강 개선을 주요 목표로 설정한 바 있음(Kingdom of Cambodia, 2016)
- 이러한 현지 국가 보건정책 하에, KOICA가 협력국으로부터 2016년 8월 공식 사업요청서(Project Concept Paper)를 접수하여 예비조사 및 심층 기획조사를 통해 개발되었음
- 해당 사업은 모성 및 아동보건 지표가 전반적으로 향상된 캄보디아 내에서도 여전히 취약한 라타나끼리주와 몬돌끼리주의 모자보건 분야의 의료서비스 접근성과 서비스 질 향상을 포함
- 캄보디아 동북부(라타나끼리주, 몬돌끼리주)는 캄보디아 내에서도 보건 의료 서비스 접근성이 낮은 지역으로, 지리적·경제적·문화적 요인으로 인해 모성 및 신생아 건강지표가 전국 평균보다 현저히 열악함(KOICA, 2018a)
 - 라타나끼리주의 모성사망률은 십만명 당 560명(2014년)으로 캄보디아 평균 170명보다 3배 이상 높으며, 5세 미만 아동사망률은 50/1,000명(2014년)으로 캄보디아 평균인

29/1,000 대비 현저히 높음(UNFPA, 2017)

- 소수민족이 주민의 80%를 차지하며 지리적으로 소외된 지역으로, 2개 주의 상위 병원(CPA 3)인 주립병원(Provincial referral hospital)은 보건부 지침에서 제시하는 기준을 대체적으로 충족하고 있지 못하고 있음
- 의료인력 충원이 어렵고 인력 유출 문제가 있으며, 기존의 인력도 역량 강화를 위한 지원을 충분히 받지 못하고 있어 숙련된 의료인력에 의해 이루어진 분만율은 50.2%(2014년)으로 전국 평균(89%)보다 낮음

□ 대상 사업은 공급자의 측면에서 모자보건 의료 인프라 및 서비스의 질적 개선 도모함

- 병원 및 보건소 시설 개선, 기자재 지원, 보건의료 인력 역량강화를 통한 해당 사업지역의 보건의료서비스의 질적 개선 및 이용 확대를 통해 산모 및 신생아의 건강 향상에 기여하고자 함

□ 아울러 수요자 측면에서 아웃리치를 통한 접근성 및 인식개선을 통해 건강불평등 해소를 도모함

- 지리적으로 접근이 어려운 격오지 마을이나 사회적·문화적으로 보건의료서비스의 수혜로부터 소외되어 있는 소수민족 거주지를 대상으로 마을보건요원(VHSG) 활동 및 아웃리치를 강화하여 접근성을 개선하고 지역사회의 보건 인식개선과 역량 강화를 목표로 함



[그림 1] 평가대상 지역

2. 사업개요

구 분		내 용	
사업 개요	사업명(국문)	■ 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램	
	사업명(영문)	■ Maternal and Child Health Program for Northeast isolated area in Cambodia	
	대상국가 (대상국내 지역)	■ 캄보디아 라따나끼리 주, 몬둘끼리 주	
	사업기간/ 총 사업예산	■ 구분 : 신규 ■ 기간 : 2019-2023년 ■ 총 사업예산 : 770만불	
	사업유형	■ 프로젝트	
	사업분야	■ 보건의료	
	사업 목적	■ 캄보디아 라따나끼리 및 몬둘끼리 지역 주민의 모자보건 증진	
	* 핵심 검토사항		
PCP 및 사전 타당성조사	◆ 관계기관 PCP (○) ◆ 수송기관 공문 (○) ◆ 사전타당성조사 (○)		
사업 세 부 내 용	우리정부 분담사항	전문가 파견	■ 소요예산 : 180.7만불 (2,039백만원) ■ 상주인력 파견을 통한 현장사무소 운영, 성과관리, 기자재 등 비상주 전문가 파견
		건축	■ 소요예산 : 126.5만불 (1,428백만원) ■ 3개 보건소 및 2개 병원 모자보건센터 신축
		기자재	■ 소요예산 : 140.1만불 (1,581백만원) ■ 4개 병원, 38개 보건소 대상 의료기자재 지원 ■ 코로나19 대응 보건물품 및 구급차 지원
		역량강화	■ 소요예산 : 11.1만불 (125백만원) ■ 초청연수 및 현지연수
		직접지원/ 프로그램	■ 소요예산 : 253.5만불 (2,862백만원) ■ 의료인력 역량강화 (PMC, 현지교육기관 활용) ■ 소외지역 통합 아웃리치 서비스 지원 ■ 마을보건요원 교육, 미디어 및 홍보를 통한 지역사회 인식개선 ■ 사업조정위원회 및 모니터링, 성과관리 등
		사업관리	■ 소요예산 : 42.1만불 (475백만원) ■ 사업 모니터링 및 사업 운영 제반비용
	수원국 분담사항	■ 각종 제반 행정 및 인허가 지원	

3. 사업설계매트릭스(PDM)

프로그램 요약 (Narrative Summary)	객관적 검증지표 (OVI: Objectively Verifiable Indicators)	검증수단 (MOV: Means of Verification)	중요가정 (Important Assumption)
영향(Impacts)			
캄보디아 라타나끼리주 및 몬둘끼리주 산모 및 신생아의 건강이 개선된다.			N/A
성과(Outcomes)			
1. 사업지역의 모성, 신생아 보건의료서비스의 질이 향상된다.	- 모자보건 서비스 미충족 욕구 - 모자보건 서비스 만족도	가구조사	- 보건의료시설 운영에 필요한 최소한의 국가 재정이 확보된다. - 수원국의 모자보건 개선을 위한 정책 기조가 변경되지 않는다.
2. 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근성이 개선된다.	- 전문가에 의한 분만 비율 - 산후 48시간 이내 산후관리를 - 4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율		
3. (추가) 모성, 신생아 보건에 대한 지역 주민의 인식이 개선된다.	- 모성, 신생아 보건 관련 지역주민 지식, 태도, 실천율		
산출물(Outputs)			
1.1. 모성 및 신생아 관리 역량 강화된 보건소 및 병원인력	- PMC 전문가에 의한 교육을 이수한 보건의료인력의 수 - PMC 전문가에 의한 교육 성취도 - 보건부 산하 위탁교육을 이수한 라타나끼리, 몬둘끼리 보건의료인력 수 - 보건부 산하 위탁교육 성취도	시설평가 보고서 사업 활동 보고서	- 사업 추진 시 유기적 협조체제가 유지된다. - 주요 지원 요청에 대한 변경 사유가 발생하지 않는다. - 우기에도 사업지역 도로망이 유지된다.
1.2. 병원 및 보건소 모자보건시설 및 의료기자재 개선을 통한 의료환경 개선	- BEmONC 서비스 제공 가능한 시설 수 - CEmONC 서비스 제공 가능한 시설 수 - 계획된 의료기구가 모두 지원된 의료시설의 수		
2.1. 소외지역 통합 아웃리치 서비스 강화	- 아웃리치 서비스 수혜자 수		
2.2. 개선된 지역-보건시설 간 전원체계	- 구급차 전원 사례 수 - 모터보트 이용자 수		
3.1. 마을보건요원(VHSG) 활성화	- 훈련된 마을보건요원(VHSG) 수		
3.2. 어머니 교실(KIRI Class)을 통한 여성 인식개선	- 어머니 교실(KIRI Class) 참여자 수		
3.3. 미디어 및 홍보를 통한 지역사회 모자보건 인식개선	- 헬스캠페인 참여자 수		

개별활동(Activities)	투입물(Inputs)	전제조건(pre-conditions)
1.1.1. PMC 주관 의료진 역량강화 교육 1.1.2. 캄보디아 보건국 주관 의료진 역량강화 교육 1.1.3. 모자보건 관리자 대상 초청연수 1.2.1. 병원 4개소 의료기자재 지원 1.2.2. 보건소 36개소 의료기자재 지원 1.2.3. 병원 2개소 및 보건소 3개소 중·개축	■ 사업 수행 기관 - 국내 : 순천향대학교 의료원 및 굿네이버스 인터내셔널 (현지 상주 3명) ■ 사업기간 : 2019-2023년 ■ 사업예산 : 총 8,510,388,322원 (사업예산) 470만불 - 인력역량강화, 보건프로그램, 기자재 및 건축 자문, 전문가 투입 등 전체 PMC 기준 (제안사 추가 투입예산) 총 20만불 - 사업종료 후, 사후지원 : 20만불(2024-25) (사업기간) : 7년 - KOICA 공식 사업기간: 50개월 (2019-23) - 제안사 추가 투입기간: 24개월 (2024-25) (전문가 인력) 총 27명 - 핵심 투입인력(PM): 1명 - 주요 투입인력(보건, 성과, 기자재/시설건축 전문가): 6명 - 일반 투입인력(PAO): 1명 - 제안사 추가 투입인력: 28명 - 의사(산부인과, 소아청소년과, 가정의학과): 4명 - 간호사(분만실, 신생아실, 회복실): 3명 - 전문가(방사선사, 감염관리): 2명 - 성과관리(연구, 보건통계): 1명 - 운영/총괄지원 : 6명 - 캄보디아 현장지원 : 3명 - 기타(법무, 인사총무, 회계, 홍보영상, 브랜드관리): 5명 - 사업자문: 영남대(이경수, 황태윤), 한국건강관리협회(채종일), 아주대(배기수): 4명	- 건축 및 기자재 지원 관련 비용의 급격한 상승요인이 발생하지 않는다.
2.1.1. 소외지역 통합아웃리치서비스 지원 2.1.2. 아웃리치 모니터링 2.2.1. 구급차 지원 2.2.2. 모터보트 구매 및 유튜브 지원		
3.1.1. 마을보건요원(VHSG) 역량강화 교육 3.1.2. VHSG 활동 지원(격월 VHSG 미팅 포함) 3.2.1. VHSG 활용 어머니 교실(KIRI Class) 운영 3.3.1. 인식개선, 교육자료 제작 배포 3.3.2. 헬스캠페인 개최 3.3.3. 오디오 방송을 이용한 주민교육 및 홍보		

제 II 장

평가개요

1. 평가의 목적과 범위
2. 평가매트릭스
(Evaluation Matrix)
3. 평가 수행 단계
4. 평가의 한계 및 보완사항
5. 평가팀 구성 및 시행체계



제II장 평가개요

1. 평가의 목적과 범위

- ☐ 프로젝트 및 프로그램 사업의 집행계획과 실제 수행 내용이 일치하는지 검토
 - 당초 의도한 성과, 즉 산출물(output) 달성도를 얼마나 달성했는지 측정 및 사업 기획 및 수행 과정 등 적정성을 판단하고, 추가적으로 성과(outcome)에 대한 평가와 더불어 엄밀한 영향평가(impact evaluation)를 수행함
- ☐ 혼합연구방법론을 활용한 삼각 검증을 통해 타당도와 신뢰도 높은 평가를 수행하고 작동/비작동요인에 대한 규명과 향후 유사사업 추진을 위한 교훈 도출을 통해 향후 사업의 내실을 도모함
- ☐ 목표 달성 전략

(1) 혼합연구방법론 적용을 통한 평가의 신뢰성과 타당성 확보

- 혼합연구방법론(Mixed methods)는 질적인 접근과 양적인 접근을 함께 활용해 자료를 수집하거나 분석하고, 결과를 통합해 추론을 이끌어 내는 연구방법임(Creswell & Creswell, 2017)
 - 양적 평가분석으로는, 해당 사업의 주요 수혜자 대상의 양적 설문조사 및 엄밀한 효과평가(impact evaluation)를 위한 준실험적방법론인 단절적 시계열(Interrupted Time Series, ITS) design의 적용을 통해 사업 대상의 outcome 변화를 확인하고자 함
 - 질적 평가분석으로는 이해관계자 및 수혜자 대상으로의 FGI 및 개인 심층인터뷰 등을 통해 사업의 과정 및 결과, 원인 등에 대한 심층 평가를 실시함

(2) KOICA 평가 기준을 적용하되 사업 내용과 특수성을 고려한 평가

- ☐ OECD/DAC 6대 기준과 성평등, 환경 요소를 기반으로 평가를 수행하되, 본 사업의 특수성을 고려한 입체적인 평가를 계획함

- (효과성) output 차원의 평가는 기존의 문헌 등에 기초한 평가가 여러 차례 이루어진바, 본 평가에서는 제3의 평가자에 의한 재검증 차원에서 수행하고 outcome의 평가를 위해 엄밀한 준실험적 방법을 적용하여 평가를 진행함
- (효율성) 사업 초기, 코로나19 팬데믹으로 사업의 수행이 어려움을 겪음에도 타 KOICA 사업과 다르게 1~2년의 사업 기간 연장 없이 이동금지 및 대면사업 제한조치 등을 어떻게 극복하고 output의 초과 달성을 올렸는지에 대한 분석을 수행할 예정임
- (지속가능성) ㉠ 정치적 지속성 (수원국 지방정부에서 사업을 계속 지속하겠다는 정치적 의지와 지지), ㉡ 인적 지속성(사업 종료 후 현지의 훈련된 인력이 자생적으로 사업을 이끌 수 있는 기반) ㉢ 재정 지속성(사업 전체 예산을 계속 확보할 가능성) ㉣ 인프라 지속성(시설 사업의 경우, 유지보수 할 수 있는 예산 등 관련된 인프라 유지를 위한 기반)의 측면을 고려하여 평가를 진행하고자 함

(3) 환류과제 및 교훈 도출 방향

- ☐ 이해관계자 입장에서 프로젝트의 작동과 비작동 요인에 대한 양, 질의 데이터 수집 및 분석을 통해 향후 KOICA에서 유사 사업 추진 시 고려 사항으로 제안함
- ☐ 현재도 굿네이버스의 자체 예산으로 후속 사업이 진행되고 있는 점과 현재 캄보디아에서 진행 중인 H-EQIP(The Health Equity and Quality Improvement Project) 사업과 시너지 효과를 유도하면서, KOICA 후속 사업인 라따나끼리 주의 “포괄적 공공 보건의료체계 역량강화사업” 등과의 연계성을 높일 수 있는 사업의 환류 과제 등을 제안하고자 함

2. 평가매트릭스(Evaluation Matrix)

평가기준	평가질문	측정지표	자료출처	분석방법
1. 적절성	1.1. 수원국 및 대상지역의 모자보건 문제 원인 해결에 적합한 사업인가? 1.2. 사업 수행 주체는 해당 사업을 추진하기에 적합한가? 1.3. 사업의 기획은 목표를 달성하기에 적절한가? 1.4. 기획된 사업 내용이 수혜자들의 문화적·민족적 배경과 일치하는가?	교육 및 자원 적절성과 적합성	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서 이해관계자 면담 자료 등)	문헌조사 검토, 현장 설문조사 분석, 이해관계자 인터뷰 분석
2. 일관성	2.1. 외적일관성 : 사업은 국가 정책, 국제 이니셔티브, SDGs 목표, 파트너 기관 전략에 부합하는가? 2.2. 내적일관성 : 사업 요소별로 일관성 있게 기획되고 수행되었는가?	내적일관성 및 외적일관성 시너지효과 여부		
3. 효과성	3.1. 계획 대비 사업의 산출물 및 성과가 달성되었는가? 3.1.1. 수요자 측면에서 서비스 미충족 경험 및 서비스 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가? 3.1.2. 공급자 측면에서 역량강화 프로그램 및 건축/기자재 지원에 대한 만족도 수준과 결정요인은 무엇인가? 3.2. 사업의 효과성을 높이기 위해 향후 추가적으로 필요한 사업의 내용은 무엇인가?	산출물 목표대비 달성률 사업 작동 및 비작동 요인 성과 달성의 촉진/저해 요인		
4. 효율성	4.1. 예상치 못한 상황(코로나-19)이 발생했을 시에 상황변화에 적합하고 현실적인 위기관리 대응이 마련되고 실현되었는가? 4.2 필요한 자원이 적절한 시기에 제공되었는가? 적절한 시기에 제공되지 못하게 된 주요 원인은 무엇인가? 4.3. 제공된 자원의 이용과 협력의 방식이 효율적인 방식으로 이루어졌는가? 더 효율적으로 변화하려면 어떤 것이 필요한가? 4.4. 파트너십사업(해당) KOICA-사업 주체-현지 이해관계자 간 파트너십 및 커뮤니케이션은 효율적으로 관리되었는가?	자원의 효율적 사용 및 의사결정 효율성		
5. 지속 가능성	5.1. 수원국 제도가 사업을 지원하는가? 5.2. 사업 대상 지역사회의 주인의식이 사후에도 사업을 계속 발전시킬 수 있을 만큼 충분한가? 5.3. 향후 프로그램이 지속적으로 운영되기 위한 사업의 요소는 무엇인가? 파악이 이뤄졌다면 어떤 부분들이 개선되어야 하는가? 5.4. 건축물의 관리 및 기자재/소모품의 관리와 활용은 잘 이뤄지고 있는가?	정치적·인적·재정적·인프라 지속성		
6. 영향력	6.1. 수요자들이 건강관리 방식의 변화를 인지하고 실천하고 있는가? 예상 밖의 영향력이 있다면 무엇인가? 6.2. 프로그램이 공급자 간, 공급자와 수요자 관계에서 신뢰 관계 및 행동양식에 미친 영향이 있는가? 향후 유사 사업 추진 시에 신뢰 관계를 형성하기 위해서는 어떻게 반영할 것인가?	지역사회에 미친 영향력과 향후 파급력		
7. 인권/성 주류화	7.1. 소수 민족, 원거리 마을주민, 여성 등 취약 계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요를 반영한 프로그램을 기획하였는가?	취약계층 식별 및 차별적 성과 달성 여부 성별에 따른 불이익		

3. 평가 수행 단계¹⁾

□ 평가는 총 4단계로 나누어 다음과 같이 진행함

<표 1> 평가 수행 단계 개요

단계	수행내용	수행방법	대상	산출물
[1단계] 기초조사	본 평가의 접근법 분석 및 평가매트릭스 도출	문헌조사	■ 사업제안서(PCP) ■ 월별/반기별 보고서 ■ PMC 종료보고서 등	평가매트릭스
[2단계] 과정평가	운영체계 및 수행과정 점검	문헌조사	■ 사업제안서(PCP) ■ 월별/반기별 보고서 ■ PMC 종료보고서 등	평가항목별 과정평가결과
		면담조사 (국내/외)	■ 굿네이버스 담당 직원 ■ 캄 현지사무소 직원 ■ 수원기관 관계자	
[3단계] 성과평가	산출물 및 단기성과 점검, 지속가능성 점검	준실험적 통계 분석	■ 수혜대상지 통계자료 ■ 각 지역별 자체 수집자료	평가항목별 성과평가결과
		면담조사 (현지실사)	■ 사업지 주 보건국 관료 및 주병원 의료진 ■ 보건소 인력 및 마을보건요원	
		설문조사 (현지실사)	■ 수혜지역 임신부, 5세 미만 아동 어머니, 남편, 시아머니	
		시설 및 기자재 관리 실태 파악	■ 시설, 기자재, 소모품의 점검 및 관련 가이드 라인 검토	
[4단계] 종합평가	양·질의 평가데이터 합성, 성과 및 한계 분석, 향후 유사사업기획 및 수행 관련 제언	분석결과 정리 제언도출	■ 1-3단계 평가 결과분석	사업성과 및 관련 제언

□ 1단계 기초조사

○ 문헌조사 및 이해관계자 및 면담 대상자 파악

- 사업 관련 자료를 참고하여 사업 전반에 대한 이해도를 높이고, 평가의 범위를 명확히 설정하여 평가항목 및 평가지표를 정교화함
- 국내외 유사 사업 관련 문헌과 정책 자료 등에 대한 기초 문헌조사를 실시하여 유사사례를 분석하고 국내외 모자보건 분야 ODA의 현황, 정책 방향, 트렌드를 파악함

1) 세부 평가방법은 첨부 4 참고

- 대상 사업의 의사결정자 및 사업수행자, 수혜자 등 이해관계자를 파악하고, 문헌조사 내용의 교차 검증 및 문헌에서 파악할 수 없는 내용 확인을 위한 사전 면담조사 대상을 선정함

□ 2단계 과정평가(문헌조사 및 면담조사)

- 기초조사에서 파악된 캄보디아 전략문서 및 통계자료 등을 기반으로 중앙부처 및 지역 정부의 개발목표와 정책을 파악하여 평가대상 사업의 적절성과 일관성 등에 대한 평가 기준을 설정함
- 사전조사 및 정기조사 자료 등 각 사업 수행기관에서 사업의 수행기간 동안 사업 품질 관리 및 평가를 위해 수집한 통계 자료, 면담 자료, 설문 자료 등에 대한 분석을 진행함
- 문헌조사에서 파악한 내용에 대한 교차 검증 및 문헌에서 파악할 수 없는 내용 확인을 위한 이해관계자들에 대한 사전 면담을 국내외에서 진행함

□ 3단계 성과평가

○ ITS를 적용한 통계 분석: 라파나끼리주의 보건행정 데이터 분석

- (목적) 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근 개선과 관련된 성과지표에 대해서 사업이 시행된 기간(2019~2022년) 전후의 시간에 따른 변화를 정량적으로 분석하여 엄밀한 사업의 효과성을 검증함
- (Outcome 성과지표) PDM 성과 달성도 내 미달성 outcome 지표인 ㉠ 의료전문가에 의한 분만 비율, ㉡ 산후 48시간 이내 산후관리 받은 임산부 비율(PNC1), ㉢ 4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율 외에 추가적으로 산후 14일, 6주, 8주 후의 산후관리(PNC2~4)에 대해서 분석·평가함

○ 설문조사

- (목적) 사업 PDM에 제시된 성과지표를 반영한 지역사회 모자보건 서비스 질 및 접근성 향상, 사업 수혜 모성의 모자보건 인식개선 확인, 수혜자의 만족도 분석, 산모와 신생아 건강에 미친 영향 조사, 미달성 항목에 대한 원인 등에 대한 설문을 수행함

○ 면담조사

- (목적) 사업의 이해당사자 및 직·간접 수혜자를 대상으로 사업 효과성 등의 (비)작동요인 등을 조사하여 사후관리 및 유사 사업 진행 시 교훈으로 삼고자 함
- (조사대상 및 조사방법) ㉠ 임산부 및 5세 미만 아동의 어머니, ㉡ 프로그램 참여자들의 가족(남편 및 (시)어머니), ㉢ 주보건국, 운영지역(Operation District, OD) 관계자, ㉣ 보건소 인력, ㉤ VHSG를 대상으로 초점집단인터뷰(Focus Group Interview, FGI)와 개인 심층인터뷰(In-Depth-Interview, IDI)를 실시함

- 시설 및 기자재 관리 실태 평가
 - (방문 대상) 라따나끼리주와 몬둘끼리주의 보건소 및 주립병원의 모자보건센터
 - (평가 전문가) 전문가 과정생 중 의료진 4인(의사 및 간호사)
- (서울대병원/의과대학 IRB 승인) 본 평가조사를 위한 양적, 질적 방법을 포함한 혼합적 평가 연구에 대해 서울대병원/의과대학으로부터 윤리적, 과학적 측면에서의 평가 연구계획 적절성을 승인 받음(No. 2501-091-1607)

4. 평가의 한계 및 보완사항

- 설문조사 표본 및 면담조사의 비대표성 문제 보완 사항
 - 설문의 대표성을 위해서는 사업이 수행된 라따나끼리주 및 몬둘끼리주 전역의 모집단을 대상으로 층화추출법 등 확률표본추출(probability sampling) 전략을 수립해야 하는 것이 원칙임
 - 그러나, 정확한 모집단(사업 기간 중 임신 및 출산 경험이 있는 여성)에 대한 자료를 확보하기 불가능하며 아울러 본 평가에 참여하는 대학원생 전문가 과정생 인력 및 평가 기간, 자원의 현실적인 제약으로 인해 마을 단위에서의 확률표본추출 적용이 어려움
 - 이에, 현지 주보건국 자료를 바탕으로 건축이 이루어진 보건소가 포함된 지역 여부, 소수 민족의 비율, 아웃리치 활성화 등에 따라 표본의 비율을 고려하여 조사 지역을 선택하는 목적적 표본추출(purposive sampling)을 수행함
 - 설문 및 면담 조사의 경우, 모두 선정된 지역에서 평가대상에 부합하는 여성을 모집하였으나 이들이 해당 지역의 대표적인 표본이 아닐 가능성이 있음. 본 평가가 시행된 1월 중순은 캐슈넛 수확 및 농작물 수확 등으로 여성이 농장 및 가정 등에서 분주할 가능성이 높으므로 상대적으로 시간적, 물리적, 언어적으로 수월한 여성이 설문 및 면담에 응할 가능성이 있음
- 비교집단(Comparison Group) 부재 보완사항
 - 대상 사업 기획 시 비교집단을 고려하지 않았기 때문에 사전 현지 조사를 통해 인근 지역인 끄라체 방문을 통해 비교집단 설정을 고려하였으나 동 사업 기간 유니세프 등을 통한 유사한 모자보건 관련 사업이 실시된 것을 확인하여 비교집단으로 설정할 수 없었음
 - 이에 비교집단이 없을 때 활용할 수 있는 준실험적방법론인 ITS 분석을 적용하여 엄밀한 평가를 수행함

<표 2> 성과 검증방법의 비교

구분	기초선	중간선	종료선	종료평가
수집 시기	2020.12.~2021.2 (3개월)	2022.4.~8. (4개월)	2023.9.~10. (2개월)	2025년 1월 19일~22일(4일)
수집 대상	임산부 및 5세 미만 아동의 어머니			본격적 사업수행 기간 (2021.1~2023.12.) 임산부, 출산 경험이 있는 모성
표본 수 ²⁾	총 1,500명 라타나끼리: 1,024 몬둘끼리: 476	총 1,532명 라타나끼리: 1,154 몬둘끼리: 378	총 1,578명 라타나끼리: 1,183 몬둘끼리: 395	총 377명 라타나끼리: 275 몬둘끼리: 102
수집 방법	가구 설문조사(단순 확률비례표본추출)			가구 설문조사 (목적적 표본추출)
수집 주체	PP	Angkor Research & Consulting Ltd.		대학원 ODA 전문가 과정 평가팀 및 pheak Consulting

□ 설문응답자 및 면담대상자의 회상편의(Recall Bias) 보완 사항

- 일부 응답자는 경험을 정확히 회상하는 데 어려움을 겪었을 가능성이 있음. 이를 보완하기 위해 설문 및 면담 시작 전 의료진의 경우, 당시의 교육 주제나 에피소드 등을 회상시켰고, 모성의 경우, 당시의 임신, 출산 경험을 회상케 하고 관련 사진 등을 제공하여 편이를 줄이도록 함

□ 응답자의 사회적 바람직성 편익(Social Desirability Bias) 발생 가능성 최소화

- 설문 및 면담 대상자들이 평가자가 기대하는 방향으로 답변하는 경향이 있을 가능성이 높을 수 있음. 특히, 후속 사업 등을 기대하는 이해관계자의 경우, 사업의 긍정적인 영향을 과대평가하거나 부정적 경험을 축소할 가능성이 있음
- 이에, 평가의 목적이 객관적인 의견을 취합하고 제한점을 환류하기 위함임을 강조하여 솔직한 응답을 부탁하며, 중립적인 질문을 활용하고 면담 시 상반된 답변은 확증을 위해 확인함

□ 통역 및 번역 과정에서의 의미 왜곡 가능성 최소화

- 영어 설문지와 질문지를 현지어로 번역 및 통역 과정에서 원래 의미가 일부 왜곡될 가능성이 있음. 특히, 문화적으로 함축적인 표현이나 미묘한 의미 차이가 있는 경우 번역 및 통역

2) 기초선, 중간선, 종료선 : 98% 신뢰구간(Confidence Interval) / 3% 오차범위(Margin of Error), 종료평가 : 95% 신뢰구간 / 5% 오차범위

과정 중 질문자나 응답자의 의도를 완전히 이해하기 어려울 수 있음

- 이를 보완하기 위해 구조화된 설문지 및 반구조화된 면담질문지 번역 및 면담 내용 분석에 있어 현지 전문가 및 이중 언어를 사용하는 통역사의 검토를 받았으며, 현지 조사 전 통역사 대상으로 통역 시 의미 왜곡 최소화에 대한 교육을 실시함

□ 면담 환경 및 여건의 영향 최소화

- 설문과 면담 조사 시 응답자가 조직이나 상사의 입장을 고려하여 답변했을 가능성을 최소화하기 위하여 개인별 면담을 조용하고 독립적인 공간에서 진행함
- 마을 단위에서의 설문과 면담은 일반 주민이나 보건 요원의 솔직하고 적극적인 응답을 저해하지 않도록 가족구성원이나 상급 보건 관계자가 같은 공간에 있지 못하도록 개별적이고 익명성이 보장된 환경에서 면담을 진행함
- 포커스그룹인터뷰의 경우, 구성원 간에 권력관계가 나타나지 않는 수평적인 면담자들로 구성하였고 면담 진행자가 발언 기회를 공평하게 분배하도록 노력함

5. 평가팀 구성 및 시행체계

구분	이름/소속/직함	담당업무
평가책임자	김웅한 (서울대학교 의과대학 휴먼시스템의학과 교수 겸 서울대병원 소아흉부외과 교수)	• 평가 총괄
평가전문가	허중호 (서울대학교 의과대학 휴먼시스템의학과 겸임부교수 겸 국회미래연구원 보건의료 연구위원 및 삶의질데이터센터장)	• ODA 전문가 과정 교육 • 현장평가 총괄 • 과정생 인솔 및 지도
평가보조원	김윤진 (서울의대 이종욱글로벌의학센터, 연구원)	• 출장 준비 총괄 및 현지 연락
평가보조원	김소예, 김지민, 박선우, 신채린, 오세욱, 오홍상, 윤예진, 이민찬, 이석희, 이운영, 이호연, 정다운, 하나영 (ODA 전문가 과정생)	• 국내외 조사 및 양적·질적 현장평가
평가보조원	김민, 김수희, 김지영 (서울대학교 대학원생)	• 국내외 조사 및 양적·질적 현장평가

제Ⅲ장

성과 달성도



제III장 성과 달성도

성과달성도	성과지표 (OVI)	기획단계		수행단계		달성도 ((C-A)/(B-A)) *100	지표입증 수단 (MOV)
		기초선 (Baselines,A)	목표치 (Targets,B)	중간선 (Midline)	종료선 (Endline,C)		
성과(Outcome)	모자보건 서비스 미충족 욕구	20.7%	10.7%	1.2%	0.2%	205.0	연간 보고서
1. 사업지역의 모성 신생아 보건의료 서비스의 질이 향상된다	서비스 만족도	36.5%	51.5%	91.1%	97.1%	404.0	
2. 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근성이 개선된다.	전문가에 의한 분만비용	77.4%	87.4%	77.9%	82.1%	47.0	
	산후 48시간 이내 산후관리 받은 비율	77.4%	87.4%	86.4%	86.7%	93.0	
	4회 이상 산전관리 받은 임신부 비율	51.3%	71.3%	52.1%	63.7%	62.0	
3. 모성, 신생아 보건에 대한 지역주민의 인식이 개선된다.	모성, 신생아 보건관련 지역주민 지식, 태도, 실천율	22.3%	42.3%	13.1%	50.6%	147.4	
산출물(Output)	PMC 전문가에 의한 교육을 이수한 보건의료인력의 수	0명	40명	43명	192명	480.0	사업수행 기관 종료선 조사결과 보고서
1.1. 모성 및 신생아 관리 역량 강화된 보건소 및 병원 인력	PMC 전문가에 의한 교육 성취도	-	40%	40%	35.0%	87.5	
	보건부 산하 위탁교육을 이수한 주보건의료인력 수	0명	342명	204명	403명	117.8	
	보건부 산하 위탁교육 성취도	-	10%	51.5%	37%	370.0	
1.2. 병원 및 보건소 모자보건시설 및 의료 기자재 개선을 통한 의료 환경 개선	BEmONC 서비스 제공 가능한 시설 수	0개소	3개소	0개소	3개소	100.0	
	CEmONC 서비스 제공 가능한 시설 수	0개소	1개소	0개소	1개소	100.0	
	계획된 의료기구가 모두 지원된 의료시설의 수	0개소	40개소	0개소	48개소	120.0	
2.1. 소외지역 통합 아웃리치 서비스 강화	아웃리치 서비스 수혜자 수	0명	65,986명	30,601명	74,375명	112.7	
2.2 개선된 지역-보건시설 간 전원체계	구급차 전원 사례 수	0회	958회	377회	1,267회	132.2	
	모터보트 이용자 수	0회	792회	227회	309회	39.0	
	훈련된 마을보건요원(VHSG) 수	0명	1,094명	2,184명	2,961명	270.7	
3.1 마을보건요원(VHSG)	어머니 교실(KIRI Class) 참여자 수	0명	160명	92명	643명	401.9	
	헬스캠페인 참여자 수	0명	34,245명	72,627명	140,403명	409.9	

제Ⅳ장

기준별 평가결과

1. 적절성
2. 일관성
3. 효과성
4. 효율성
5. 지속가능성
6. 영향력
7. 범분야 이슈



제Ⅳ장 기준별 평가결과

1. 적절성

1.1. 수원국 및 대상 지역의 모자보건 문제 원인 해결에 적합한 사업인가?

- ☐ (열악한 모자보건 지표) 사업 형성 당시, 캄보디아의 영유아 사망률은 모성사망률에 비해 상당히 감소하는 경향을 보였으나, 도시와 농촌 간 격차가 크고 농촌 지역에서 도시에 비해 더 높게 나타나고 있었으며, 특히 사업대상 지역인 라타나끼리주와 몬둘끼리주의 영유아 사망률은 출생아 1,000명당 72명으로 캄보디아 전역에서 가장 높았음(DHS, 2015)
- ☐ (제한된 보건의료 접근성) 사업대상 지역인 라타나끼리주와 몬둘끼리주는 캄보디아 내에서도 가장 열악한 동북부 국경에 위치 해있으며 산간 지형으로 인해 마을주민들의 보건의료 접근성 또한 취약함
 - 2017 캄보디아 사회 경제 조사에 따르면 크메르인이 캄보디아 인구의 97%를 차지하는 주요 민족 그룹이고 기타 민족은 3%로 보고되었으나(NIS, 2018), 2개 사업지역에서는 소수민족 및 이민자들이 해당 지역 인구의 절반 이상을 차지함(라타나끼리 75%, 몬둘끼리 65%)(CDC, 2013)
- ☐ (대상 지역 모자보건 관련 외부사업 희박) 이와 같은 지리적, 인구적 특성으로 인해 사업 수행과 성과 달성이 어려울 것으로 판단되어 그동안 모자보건 분야에 있어 해외 원조 기관의 의미있는 규모의 지원이 거의 없음(KOICA, 2018)
- ☐ (사업 목표 및 요소) 이에 사업의 목표는 해당 지역의 ① 모자보건 서비스 질 향상, ② 모자보건 서비스 접근성 향상, ③ 모자보건 인식개선이며, 이를 위해 모자보건 인력 역량 강화, 모자보건 환경 개선, 아웃리치 및 전원체계 개선, 마을 보건 요원 활성화 및 인식개선으로 구성됨

- (질적 면담 결과|공급자) 이러한 맥락에서 보건소 및 주보건국 관계자들은 사업을 통해 제공된 교육과 자원이 지역사회의 필요에 부합했다고 응답하였으며, 특히 VHSG의 아웃리치 활동이 현지에 매우 적합한 사업요소로 보고함
 - 이동이 어려운 지역 특성을 고려한 서비스 제공 방식은 소수민족 대상의 효과적인 활동으로, 산모들은 아웃리치 활동을 통한 예방접종 및 모자보건 교육 등의 서비스에 만족감을 보여 대체로 현지 상황에 적합하게 구성되었다고 판단됨
 - 라타나끼리주와 몬둘끼리주 내 외곽 지역은 적절한 전원 수단이 부족하여 이에 대한 구급차의 지원은 적절한 것으로 판단됨
 - 다만, 모터보트의 경우, 해당 지역 내 강 인근 마을이 많아 보건의료시설로의 접근을 위해 고려될 지점임은 분명한 것으로 보임
 - 다만, 사람들 일부가 모터보트를 소유하고 있다 보니 제공된 모터보트는 신속성, 수월성이 상대적으로 떨어져 활용 횟수는 목표치의 50% 정도의 달성도를 보임
 - 그러나, 양적으로는 연간 300건 이상 활용되며, 최근 모터보트 안에서 출산한 한 사례가 미디어에 소개되는 등 사업의 적절성을 증명하는 사례로 회자한 바도 있음(Fresh News, 2025)
- (질적 면담 결과|수요자) 모자보건 프로그램(KIRI Class 등)은 정부에서도 존재하지 않았던 새로운 접근 방식으로 지역주민들에게 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타남
 - 산모 및 가족 대상의 면담 결과도 이와 일관되어, 산모의 경우, 어머니를 위한 교육, 임신 관리, 백신 접종 등의 서비스를 제공하며, 적절한 내용으로 구성되었고, 남편을 대상으로 한 교육 프로그램의 추가적인 활성화를 요청하는 의견이 있음
 - (시)어머니 군은 임신부터 출산 후 관리까지 포괄적인 서비스가 제공된 것과 예방접종 서비스 및 건강검진 등에 대한 만족감을 보였으며 대체로 수요자들의 필요 요구를 충족시킴
- (평가 결과) 대상 사업은 캄보디아 모자보건 향상에 있어서 소외된 지역의 특성을 반영하고 특유의 문제점을 보완할 수 있도록 사업 내용이 구성되어 있었으며 실제 공급자와 수요자의 만족도 등으로 적절하다고 판단할 수 있음

1.2. 사업 수행 주체는 해당 사업을 추진하기에 적합한가?

- (상호보완적인 공동 수행주체) 캄보디아 내에 다양한 보건 관련 사업을 추진한 바 있는 순천향대 중앙의료원 및 굿네이버스 공동으로 본 사업을 추진하면서 의료적 역량강화 및 지역사회 활동 연계를 통해 목표 달성을 위한 모자보건시스템 서비스의 연속성 확보라는 강점을 가진 적합한 사업 수행 주체라고 볼 수 있음
 - 굿네이버스는 전문사회복지사업 및 국제개발협력사업을 활발히 수행한 NGO 기관으로 2004년 처음 사무소를 개설한 이후 몬둘끼리와 라따나끼리를 포함한 지역에 사무소를 개설하고 캄보디아 보건의료 분야에서 지역사회 기반 시설 및 역량 강화를 위한 지역개발사업을 전략적으로 추진한 기관임(굿네이버스 캄보디아, 2025)
 - 순천향대 중앙의료원은 2002년부터 조직된 한캄봉사대의 정기적인 봉사활동을 시작으로 캄보디아 양두영병원 이비인후과 역량강화 사업 등으로 2020년 캄보디아 국왕 훈장 수훈(메디포뉴스, 2022 등 보건의료 분야의 전문성으로 다년간 캄보디아 보건의료 사업 참여 경험을 축적함
- (질적 면담 결과) 사업수행 관계자 및 현지 보건부 직원 등을 면담한 결과도 이와 일관되어, 두 파트너 기관이 각자의 역량과 경험을 통해 현지 예산 집행, 사업수행 및 모니터링, 기술 자문사업 등의 활동을 전개하고, 사업지역 정부 부처, 관련 기관, 지역사회 등과 원활한 의사소통 및 협의를 진행한 것으로 나타남
- (평가 결과) 이에 각 파트너 기관이 강점을 가진 활동을 주도하고 상호 보완하는 방식으로 사업이 이행되었다는 점에서 사업 수행 주체의 선정은 적절하다고 할 수 있음

1.3. 사업의 기획은 목표를 달성하기에 적절한가?

- (보건의료서비스의 연속성) 사업 기획 시, 주립병원-보건소-마을보건요원-아웃리치 프로그램이라는 의료시설과 지역사회의 연계, 공급자와 수요자 측면의 동시 고려, 임신부터 출산, 영유아 관리까지 치료와 예방의 연계를 고려한 보건의료서비스의 연속성을 고려한 사업요소 설계가 되었다는 것이 본 사업체계의 강점임
- (사업 요소별 비중) 다만, 지역사회 중심의 비중이 크고 우선적으로 실시되다 보니 상대적으로 보건의료 공급자에 대한 집중적이고 체계적인 지원을 통한 의료진의 서비스 역량 개선에는 현실적인 제한점이 있었던 것으로 판단됨
 - 이는 PMC 전문가에 의한 교육성취도(달성도 87.5%) 미흡과 보건의료접근성 관련 성과지표

미달성 원인의 일부로 볼 수 있음

- 순천향대 중앙의료원이 수행한 주요 사업 요소인 의료진의 역량 강화는 보건의료서비스 역량 개선의 필수요소이나 전체 보건의료서비스체계 내 일부이며, 성과지표 수준의 개선을 위해서는 의료서비스 접근성 개선, 전원체계 강화, 병원 중심의 치료의 질 개선 등이 유기적으로 작용해야 하나 단일 양자 사업으로는 모든 부분을 단기간에 수행하기에는 현실적으로 역부족임
- (후속사업의 적합성) 라타나끼리주에서 수행될 예정인 “포괄적 공공 보건의료체계 역량 강화사업”의 경우, 대상 사업의 한계점인 전반적인 보건의료 역량 강화를 목표로 추진되는 것은 매우 적절하다고 판단됨. 다만, 대상 사업의 강점인 보건소 아웃리치와 VHSG 사업의 지속성을 확보하는 것을 전제로 의료서비스의 접근성과 질 향상에 비중을 두는 것이 적절할 것으로 판단됨
- 병원 건축 등의 사업 요소는 지역 내 최상위 의료기관으로써 의료 품질 향상에 필수적인 부분 위주로 지원하되, 전원체계 강화 및 병원 내 감염 예방, 의료진 수급 및 역량 강화 등에 보다 중점을 두고 추진할 필요가 있음
- 현재 굿네이버스가 지역사회의 VHSG 중심의 사업 활동을 지속하고 있으나 제한된 자체 예산으로 인해 라타나끼리주 지역 전체를 포괄하지 못하기 때문에 VHSG의 탈락 방지 및 역량 강화를 지원할 필요가 있음
- 보건의료체계 내에서 서비스의 연속성을 확보해야 산출물 수준이 아닌 성과지표 수준에서의 의미 있는 변화를 가져올 수 있기 때문에 KOICA 측에서는 사업수행 주체 선정 시 이러한 컨소시엄 형태의 공동 사업수행 주체 선정을 긍정적으로 검토할 필요가 있음

1.4. 기획된 사업 내용이 수혜자들의 문화적·민족적 배경과 일치하는가?

- (낮은 문해율) 2019 캄보디아 인구 조사(General Population Census of Cambodia, 2019) 결과에 따르면 각 사업대상 지역의 문해율은 라타나끼리 74.2%, 몬돌끼리 75.8%로 캄보디아에서 가장 낮음(NIS, 2020)
- (높은 소수민족 구성) 해당 사업 예비조사 결과보고서에서 지원 필요성 및 배경으로 ‘라타나끼리주는 소수민족이 구성 인구의 80%를 차지해 전통 관습에 따른 보건의료 행태를 보이는 경향이 높다’는 의견을 제시한 바 있으며, 캄보디아 사무소도 ‘2개 사업지역 모두 소수민족 및 이민자들이 많은 부분을 차지하므로 타지역과 차별적인 개별화 접근이 필요하다’는 심층 기획 조사 결과를 보고함(KOICA, 2018)

- (설문조사 결과) 실제 현지 설문조사에서 크메르어를 완벽히 읽고 이해할 수 있는 응답자는 29.71%에 불과함. 또한, 크메르 민족이 응답자 중 26.79%를 차지함. 민족 구성의 비율도 행정자료와 유사하게 수집되어 소수민족 및 이민자들의 문화적·민족적 특성을 고려한 사업수행이 성공의 중요한 측면이자 지표임을 확인함
- (질적 면담 결과|수요자) 현재 모자보건서비스 자료는 대부분 크메르어로 제작된 동시에 크메르어를 알지 못하는 일부 소수민족을 위해 교육 요소에 그림, 영상, 오디오 등 시각적·청각적 자료를 제공하였으며 이는 의료서비스 만족도와 교육 효과를 향상시키는 주요 요인임
 - 일부의 경우, 소수민족이 실제 보건소 및 병원 서비스 이용 시 언어적 장벽으로 인해 해당 서비스를 충분히 인지하고 활용하는 데 어려움이 잔존하고 있음을 확인함
 - 이는 지역마다 차이가 있어, 오츄 보건소나 안동미아 보건소의 경우 통역이 필요하다고 하였으나, 꾀똌 보건소의 경우 주변 소수민족들이 대부분 크메르어를 잘한다고 답한 경우도 있었음
 - 라따나끼리 주립병원에는 다양한 소수민족들이 오나, 의사소통이 되지 않는 경우에 대부분 보건소의 소견서 등으로 진료하고 있으며, 환자들은 치료에 순응하는 편이나 입원 등의 경우 환자 관리에 건강 관련 전통적 신념과 의사소통 어려움으로 인한 문화적, 언어적 장벽이 잔존함
- 소수민족 비율이 높은 지역의 경우, 주립병원 입·퇴원 시 소수민족 언어 사용이 가능한 VSHG가 동행하여 의료서비스로의 접근성과 만족도를 높이는 방안도 고려해 볼 수 있음

2. 일관성

2.1. 내적일관성 : 한국 정부, 국내 타 기관, KOICA 타 사업, 주요 국제규범 및 기준과의 상호보완성, 조화/조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?

- (SDGs) 지속가능발전목표(SDGs)의 여러 목표 달성에 기여할 수 있는 사업임
 - SDGs 3번 건강한 삶과 복지 목표의 3.1 산모 사망 비율 감축, 3.2 신생아 및 5세 미만 아동 사망 감축, 3.7 성과 생식 보건 서비스에 대한 보편적 접근 보장, 3.8 모두를 위한 보편적 의료보장(UHC) 달성 등의 세부 목표 및 SDGs 4번 성평등과 여성 및 여아의 자력화 목표의 5.6 생식보건 접근성 제고 및 생식에 대한 권한 증대 세부 목표와 본사업의 활동 간의 적절성이 높음(UN, 2025)

- (대한민국의 CPS 전략) 사업 기획 당시 캄보디아는 대한민국의 제2기 중점협력국(2016-2020)으로서 ‘물관리 및 보건위생’ 분야가 중점분야 중 하나임
- 특히, 모자보전이 한국의 대캄보디아 보건 프로그램 실행 계획에 제시되어 있어(관계부처 합동, 2019) 대상 사업은 캄보디아 국가협력전략(CPS)과 잘 연계되어 형성된 사업임
- (KOICA 전략) 대상 사업은 KOICA의 보건 분야 중기전략(2016-2020) 3대 전략목표 중 ‘양질의 필수 모자 청소년 보건 서비스 제공’의 핵심 프로그램 ‘성생식 모자 청소년 보건’과 일치함(KOICA, 2017)
- 전략에서 제시한 주요 활동인 ‘산전/출산/산후 관리 서비스, 조산사 및 지역사회 보건 인력 교육’ 등이 본 사업의 내용과 일치함

2.2. 외적일관성: 현지 내 타 주체(타 공여기관, 수원국 정부 및 민간분야)의 개입과 상호 보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?

- (캄보디아 국가 정책) 대상 사업은 캄보디아가 사업 형성 당시의 국가 개발 전략 및 보건분야 발전전략 3단계(HSP3 2016-2020)에서 우선순위를 두고 있는 성생식·모자·청소년 보건 개입에 필요한 방향으로 형성됨(Kingdom of Cambodia, 2014)
- 캄보디아 정부는 HSP3에서 5대 정책 우선순위 중 모자보건 증진의 목표로 모성 사망비와 영유아 사망률 감소를 선정하고(Kingdom of Cambodia, 2016) 이를 가속하기 위한 2차 로드맵(FTIRM 2016-2020)을 수립하여 모성사망과 신생아 사망 감소 촉진에 집중함(MOH of Cambodia, 2016)
- (H-EQIP과의 상보성) 사업 형성 과정에서 KOICA가 캄보디아에서 국가 보건의료체계 역량 강화를 위해 월드뱅크 등과 함께 참여 중인 다자성 양자사업인 H-EQIP(Health Equity and Quality Improvement Project) 사업과의 연계가 충분히 고려되었음
- KOICA는 사업 형성 당시, 캄보디아 보건의료 분야에서 다자성 양자(PBA 방식) 원조 사업으로 2017년부터 2023년까지 건강 형평성 및 질 향상 프로그램(H-EQIP) 1차 사업을 추진 중으로, 건강형평성 개선을 위해 전국적인 보건의료 기관의 질 향상 및 서비스 접근성을 목표로 하고 있었음
- 본 사업 기획 당시 H-EQIP 사업의 구성 요소 중 하나인 건강 형평성 기금(HEF, Health Equity Fund)을 확장하여 의료서비스의 수혜 범위를 확대하고 대상 지역주민의 건강 형평성을 향상할 수 있음을 확인함(KOICA, 2018)

- (기타 공여기관 사업과의 연계, 중복성) 2019년부터 시작된 월드뱅크의 ‘캄보디아 영양 강화 사업(CNP, Cambodia Nutrition Project)’이 생애 첫 1,000일 동안의 모자보건과 영양에 중점을 둔 사업으로 본 사업지역에서도 진행되고 있어(World Bank, 2025) 대상자와 사업체계가 일부 겹칠 여지에 대해 월드뱅크와도 사업 시너지 효과 및 중복지원 방식을 분기별 회의를 통하여 논의하고 추진함
- VHSG 활용에 있어서 CNP와 일부 중복이 발생할 가능성이 있어서 향후 검토가 필요함
 - 본 사업에서는 보건소 단위로 2명의 VHSG를 선발하는 반면, CNP는 커문 단위에서 선발하고 월별로 활동비(최대 약 150불)를 지원하고 있어서 향후 월드뱅크 측과 어떻게 중복지원을 피하며 시너지를 낼 것인지에 대한 지속적인 논의가 필요해 보임
- 대상 사업은 백신 이외에 관련 시설 및 백신 인식개선 교육을 종합적으로 제공함으로써 백신 공급체계를 운영하고 있는 UNICEF 및 GAVI의 사업과는 상호보완적임. 본 사업을 통해 소수민족이 가지고 있던 감염병에 대한 전통적인 관념 타파 및 백신에 대한 인식개선 효과가 컸으며 이는 백신접종률 제고라는 시너지 효과를 가져옴
- 그 외, 일부 해외 NGO 등이 라타나끼리주 및 몬둘끼리주에서 모자 대상 사업을 수행하고 있으나 이들과도 정기적인 사업수행 관련 회의를 통해 모니터링하고 검토한 바 있으며 이들의 사업도 비중 있는 활동으로 볼 수는 없어 본 사업과의 체계적인 연계 가능성은 낮음

3. 효과성

3.1. 당초 계획 대비 사업의 산출물 및 성과가 달성되었는가?

- (사업 PDM 지표 검토) PDM에서 제안한 산출물의 주요 사업 활동은 목표치 또는 초과한 달성도를 보여 사업의 수행 자체에 대해서는 탁월성을 보임. 아울러 성과 목표 중 사업지역의 “모성, 신생아 보건의료 서비스의 질 향상” 및 “모성, 신생아 보건에 대한 지역주민의 인식 개선”은 초과 달성을 이룸
- 모자보건 서비스 미충족 욕구는 기초선 대비 20.5%p 감소하여 목표 달성도 205%, 서비스 만족도는 60%p 이상으로 상승하여 달성도 404.0%, 모성, 신생아 보건 관련 지역주민 지식, 태도, 실천율은 역시 30%p 상승하여 147.4%의 초과 목표를 달성함
- 사업 초기, 코로나19 팬데믹으로 인한 사업 진행의 순연 등으로 2021년부터 본격적인 사업이 수행되었음에도 불구하고 대부분의 산출물 및 다수의 성과지표에서 탁월한 성과를

보임

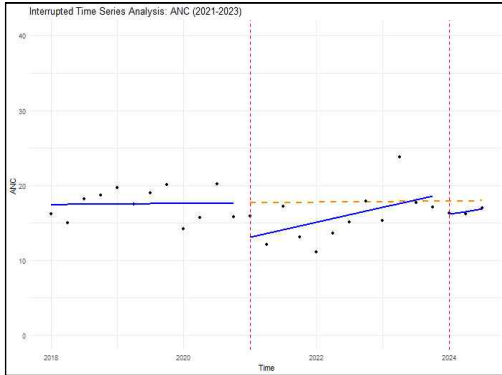
- (일부 지표의 목표 미달성) 다만, 성과 목표 중 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근성 개선의 3가지 객관적 지표에서는 목표치를 미달성함
 - 4회 이상의 산전관리는 기초선의 20%p 상향치, 전문가에 의한 분만 및 산후 48시간 이내 산후 관리의 목표 설정은 기초선 대비 10%p 상승 목표로 설정되었으나, 목표치 대비 산전 관리이용률은 12.5%p 상승(62.0% 상승), 분만 이용률은 4.7%p 상승(47.0% 상승), 산후 관리 이용률은 9.3%p 상승(93.0% 상승)에 그침
- 종료평가가 산출물 수준의 평가가 주목적이며, 목표 설정의 절대적인 기준이 없기 때문에 성과지표 달성 여부보다는 준실험적 방법을 활용한 엄밀한 분석을 통한 그 원인을 파악하고 그로부터의 환류 과제 도출에 중점을 두는 것이 바람직할 것임
 - 목표를 달성하지 못한 세 가지 성과지표(전문가에 의한 분만 비율, 산후 48시간 이내 산후 관리 받은 비율, 4회 이상 산전 관리받은 임산부 비율)에 추가하여 캄보디아 MoH의 가이드라인의 정의에 따라(MoH Cambodia, 2019; 2020) 산후 14일 후 산후관리 비율(PNC 2), 산후 6주 후 산후관리 비율(PNC 3), 산후 8주 후 산후관리 비율(PNC 4)에 대해 사업 전의 시간에 따른 경향과 사업이 시행됨에 따른 변화를 정량적으로 분석하여 사업의 효과성을 검증하고자 함
- (준실험적 방법 분석 결과) 2018년부터 2024년까지 라타나끼리주 NHIS 데이터를 활용하여 단절적 시계열 분석을 진행한 결과(자세한 내용은 별첨9 참고), PNC2~4에서 사업 수행 전의 하향 기울기를 통계적으로 유의미하게 역전시킨 효과가 나타남
- (사업시행 시점) 전반적으로, 2020년 초 발생한 코로나19로 인해 본격적인 사업 시행 시점인 2021년에는 보건의료서비스 이용이 급감된 상태였으며 특히 산후 PNC1과 PNC2 지표는 상대적으로 큰 폭의 하락을 보임
 - 전문가에 의한 분만 비율을 제외하고 모두 사업 시행 시점에 통계적으로 유의미한 서비스 이용률의 단절적인 급락을 보임
- 본격적인 사업 수행시기인 21년~24년에는 산전관리 및 분만 관련 서비스 이용률을 상승시키는 성과를 보이나 추세적으로 통계적 유의성이 있는 변화는 아님. 산전관리의 경우 24년에 가서야 코로나19 이전 수준으로 회복하였고 나머지 지표는 회복하지 못함
- 오히려 사업의 성과지표로 설정하지 않은 PNC2~4에서 통계적으로 유의미한 추세의 변화를 확인할 수 있음

- PNC3 이후는 아이에 대한 필수예방 백신접종(DPT-HepB-Hib, OPV, PVC)이 이뤄지고 있기 때문에(MoH of Cambodia, 2019), 본 사업의 백신접종의 인식 개선의 효과로 볼 수 있으며 이는 산모와 VHGS의 면담에서도 일관되게 보고된 내용임
 - 다만, 대상 사업이 백신공급 체계까지 기획한 것은 아니므로 순수 본 사업의 효과로 보긴 어렵고 UNICEF 및 GAVI 등의 백신 제공공급 사업과의 시너지 효과로 볼 수 있을 것임

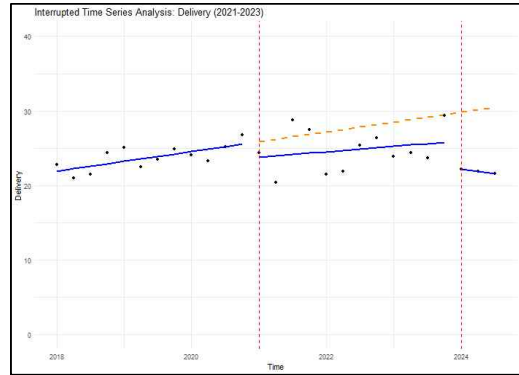
<표 3> 단절적 시계열 분석 결과

	사업 시행 시점				사업 종료 시점			
	수준변화		추세변화		수준변화		추세변화	
	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI
ANC 4	-10.7	[-19.7, -1.8]	0.5	[-0.2, 1.1]	-10.0	[-107.6, 87.6]	0.3	[-3.5, 4.1]
Delivery by prof	0.4	[-1.2, 2.0]	-0.1	[-0.2, 0.1]	13.6	[-3.9, 31.1]	-0.6	[-1.3, 0.1]
PNC 1	-12.5	[-24.4, -0.7]	-0.2	[-1.0, 0.7]	-5.2	[-134.4, 124.1]	-0.6	[-5.6, 4.5]
PNC 2	-61.0	[-93.0, -29.1]	3.1	[0.9, 5.3]	-97.6	[-445.4, 250.2]	4.9	[-8.6, 18.3]
PNC 3	-18.2	[-27.5, -9.0]	1.2	[0.6, 1.9]	19.6	[-81.3, 120.6]	0.1	[-3.8, 4.0]
PNC 4	-5.6	[-10.6, -0.5]	0.3	[0.1, 0.6]	-5.2	[-60.1, 49.8]	0.4	[-1.7, 2.5]

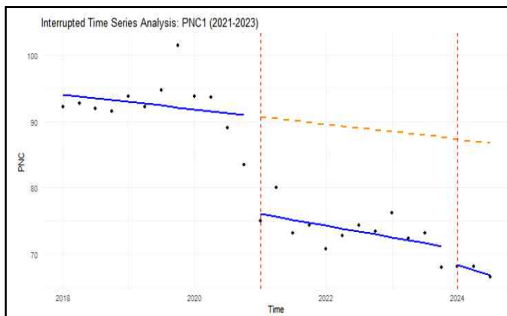
- (사업 종료 시점) 사업 종료 후 통계적으로 유의미한 단절적인 변화나 추세의 변화는 없어 사업의 효과는 지속되고 있는 것으로 확인됨
 - 사업 기간 이후 지속하고 있는 굿네이버스의 지역사회 중심의 자체 사후관리의 효과가 일부 기여한 것으로 볼 수 있음
- 다만, 전문가에 의한 분만률과 PNC1의 경우, 유의하지 않지만 기울기가 음수 방향으로 나타나 추후 지속적인 데이터의 관찰이 필요해 보임
 - 종료 이후의 시점이 4분기밖에 되지 않기 때문에 추후 데이터가 축적되면 추세의 경우 유의미한 변화로 바뀔 가능성도 있음



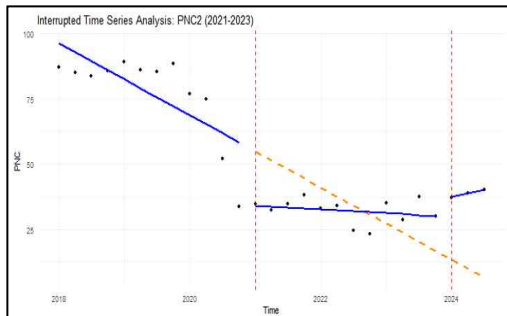
[그림 2] 4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과



[그림 3] 전문가에 의한 분만 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과



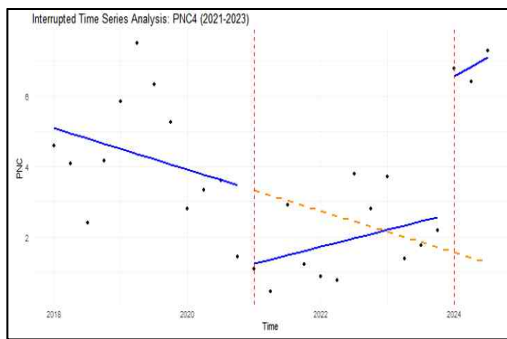
[그림 4] 산후 48시간 이내 산후관리(PNC1) 비율에 대한 단절적 시계열 분석 결과



[그림 5] 산후 14일 후 산후관리 비율(PNC 2)에 대한 단절적 시계열 분석 결과



[그림 6] 산후 6주 후 산후관리 비율(PNC 3)에 대한 단절적 시계열 분석 결과



[그림 7] 산후 8주 후 산후관리 비율(PNC 4)에 대한 단절적 시계열 분석 결과

- (설문 결과) 성과 목표에 대한 종료평가 설문 결과, 추가로 확인한 각 모자보건 서비스의 만족도는 목표치 51.5%에 비해 높게 유지되고 있었으며(ANC 97.5%, 분만 93.3%, PNC 89.3%), 특히, 지역주민의 인식개선도는 88.2%로 종료선 50.6%보다 크게 상승한 것으로 나타남(표 3)

<표 4> 성과 목표(Outcome)에 대한 종료평가 설문 결과

성과 목표	프로그램 성과지표	기초선 (2021)	중간선 (2022)	종료선 (2023)	목표치 (2023)	종료 평가 (2025)
사업지역의 모성, 신생아 보건의료 서비스의 질이 향상된다.	서비스 만족도	36.5%	91.1%	97.1%	51.5%	93.6% ANC 97.5% 분만 93.9% PNC 89.3%
소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근성이 개선된다.	전문가에 의한 분만 비율	77.4%	77.9%	82.1%	87.4%	92.7%
	산후 48시간 이내 산후관리 받은 비율	77.4%	86.4%	88.7%	87.4%	86.7%
	4회 이상 산전관리를 받은 임산부 비율	51.3%	52.1%	63.7%	71.3%	77.7%
모성, 신생아 보건에 대한 지역주민의 인식이 개선된다.	모성, 신생아 보건 관련 지역주민 지식, 태도, 실천율	22.3%	13.1%	50.6%	42.3%	88.2%

- 전문가에 의한 분만 비율과 4회 이상 산전 관리받은 임산부 비율은 각각 응답자 중 92.7%, 77.7%로 각각의 종료선 82.1%, 63.7%에 비해 상승하였으며 각각의 목표치도 사후에 달성한 것으로 나타남

- 다만, 산후 48시간 이내 산후 관리(PNC1)를 받은 비율은 86.7%로 종료선 및 목표치 비율보다는 낮게 나타나 사업 후 서비스 이용률이 감소하는 것으로 보임
- 그 원인은 산후 관리 서비스는 산모의 선택뿐 아니라 의료진의 판단에 따라 행해지는 서비스라는 점을 감안할 필요가 있음. 산후 48시간 이내 산후 관리(PNC1)는 출산한 의료기관에서 바로 퇴원하지 않고, 48시간을 머물며 경과를 지켜보는 의료서비스임
 - 면담조사 중 산모 중에서 산후 관리를 자의에 따라 받지 않았다고 대답한 사람도 있었으나, 특정 지역 주민들은 공통적으로 담당 의료진 판단에 따라 해당 서비스를 받지 못했다고 답함
 - 즉, PNC1의 경우 특히, 사업 기간에는 지침에 따라 수행되다가 사업이 종료 후 의료진의 판단 또는 물리적 수용 불가 등의 이유로 서비스가 제공되지 않았을 가능성이 있음
- 그러나, PNC2~4 서비스 이용에는 단절적 시계열 분석의 결과처럼 이전의 가파른 하향 추세와 코로나 19로 인한 서비스 이용 급감에도 불구하고 상승추세로의 전환이 이루어져

전반적인 PNC 서비스이용률 상승에 있어서는 사업의 극적인 효과로 볼 수 있음

- (몬둘끼리주 대상의 사업 평가) 몬둘끼리 주 대상의 사업의 경우 계획대로의 사업 진행이 불가능하게 되면서 일부 공급자에 대한 교육과 기자재 지원, 일부 지역에 대한 아웃리치만 제한적으로 이뤄진 것으로 파악됨
- 각 활동별 주요 계획 및 결과 보고 내용 미비 등 활동 파악이 어렵고 주 보건국의 비협조적인 태도로 인해서 해당 지역에서의 사업 활동 수행이 어려워짐에 따라 몬둘끼리 지역의 서비스 수혜율이 낮았음
- 이는 종료평가 시 몬둘끼리주 주립후송병원장과의 면담을 통해서 사업수행이 원활하지 못한 것은 주단위 보건국의 의사결정자로 인한 것으로 확인하였으며 해당 담당자는 종료평가 당시에도 동일한 직위를 유지하고 있음을 확인함
- 후송병원 및 지역사회 내 사업 수요가 명확하며 굿네이버스의 여러 차례 설득에도 불구하고 결국 보건국 차원에서 다소 정치적인 의사결정으로 인하여 사업 수행이 제대로 이뤄지지 못함
 - 인구수(라타나끼리 21만 명, 몬둘끼리 9만 명)와 더 열악한 지역(프놈펜에서 몬둘끼리까지 동동북쪽으로 365km, 몬둘끼리에서 라타나끼리까지 북쪽으로 188km)을 고려하여 사업 구성요소 비율을 라타나끼리:몬둘끼리 약 3:1로 설정하였으나 하지만, 몬둘끼리주 보건국에서는 본인들이 라타나끼리주에 비해 혜택이 적다는 이유로 비협조적이 됨(KOICA, 2020b)
 - 주보건국을 통하지 않는 병원 및 지역사회 지원은 NGO 차원에서만 가능하여 최근 굿네이버스로부터 관련 기자재 등을 지원받은 경험이 있었으나 KOICA 차원에서 수행할 수 있는 사업의 성격은 아님
- 이에, 후속 사업은 라타나끼리주에 국한하여 진행하는 것이 바람직하다고 판단됨

3.1.1. 수요자 측면에서 서비스 미충족 경험 및 서비스 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가?

- (설문조사 결과) 사업 기간 중 모자보건 관련 인식증진 위해 경험한 서비스를 묻는 질문에 약 19.6%(74/377명)를 제외한 산모가 다중의 사업의 경험이 있었으며 전체 응답자의 98.7%가 산전, 출산, 산후 관련 서비스를 중복적으로 받은 것으로 나타남(참고 별첨 6 참조)
- (ANC) 아울러 서비스를 받은 산모들 중 산전서비스는 평균적으로 5.0회에 가까운 이용

을 한 것으로 나타났으며 모두 필수적인 모자보건서비스로 인지하고 있었음

- 이 중 ANC의 만족도는 96.8%의 응답자가 만족한다고 하였으며, 그 이유는 케어의 질 및 서비스 제공 태도와 신뢰도, 낮은 비용의 순으로 나타났음
- (전문가에 의한 분만) 사업기간 동안 분만을 경험한 산모 중 4.5%(17/371명)는 제왕절개를 받았고 나머지는 자연 분만을 하였으며 98.1%가 의료시설에서 출산하는 것이 필수적이라고 답함
- 분만 장소로는 보건소(59.7%), 후송병원(25.9%), 집(8.2%)의 사립시설(4.5%)로 나타났으며, 분만 지원은 81.9%가 간호사/산파, 의사(8.2%), 전통산파(6.9%)로 나타남
- 분만서비스를 받은 산모 중 92.0%의 산모가 만족하였다고 하였고, 그 이유는 케어의 질 및 서비스 제공 태도와 신뢰도, 낮은 비용의 순으로 나타났음
- (PNC) 마지막 아이를 출산할 때 PNC 서비스를 받았는지에 대해서는 81.4%가 그렇다고 답함
- (서비스 접근성 비작동요인) 모든 모자보건 서비스에 있어서 이용하지 않은 이유를 물었을 때 물리적 거리, 교통수단 제한 등의 물리적 접근성의 어려움, 서비스에 대한 무지, 서비스의 불필요로 응답함
- (면담조사 결과/수요자) 사업의 요소별 인지도가 높았으며 대부분 필요한 서비스를 제공받을 수 있었고 이에 대한 만족도도 높다고 보고함
- (가족 대상 홍보 및 교육) 어머니를 위한 교육, 임신 관리, 백신 접종 등의 서비스를 제공하며, 적절한 내용으로 구성되었고, 나아가 남편을 대상으로 한 교육 프로그램의 추가적인 활성화가 필요하다는 의견이 있음
- 특히, 본 사업을 통해 가정 내 권력관계에 있는 시어머니 집단의 모자보건에 대한 관심과 이해가 증가한 것을 확인할 수 있었으며, 며느리와 아이가 아프면 보건소를 보내는 등 인식 개선을 통한 실질적인 행동 변화를 보여줌
 - 시어머니 집단은 임신부터 출산 후 관리까지 포괄적인 서비스가 제공된 것과 예방접종 서비스 및 건강검진 등에 대한 만족감을 보였으며 대체로 수요자들의 필요 요구를 충족 시킴
 - 시어머니, 친정어머니들이 자녀의 위생에 대하여 신경을 더 쓰게 되었고 가정에서 분만을 하던 것에서 병원이나 보건소에서 출산하는 것으로 선호하는 것으로 변화하게 되었음

- (가족 대상 홍보 및 교육) 어머니를 위한 교육, 임신 관리, 백신 접종 등의 서비스를 제공하며, 적절한 내용으로 구성되었고, 나아가 남편을 대상으로 한 교육 프로그램의 추가적인 활성화가 필요하다는 의견이 있음
 - 특히, 본 사업을 통해 가정 내 권력관계에 있는 시어머니 집단의 모자보건에 대한 관심과 이해가 증가한 것을 확인할 수 있었으며, 며느리와 아이가 아프면 보건소를 보내는 등 인식 개선을 통한 실질적인 행동 변화를 보여줌
- (현대적 모자보건 서비스에 대한 인식개선) 본 사업을 통해 모자보건 및 건강 증진에 대한 실질적인 유용성을 경험하면서, 질병에 대해 조상에게 빌기보다는 보건소 및 병원 이용과 투약을 이루는 등 전통적인 방식에서 현대적 의료방식으로의 변화를 보임
 - 특히, 예방접종과 건강검진 서비스가 건강에 도움이 됨을 확인하며 현대적 의료방식에 대한 수용성이 높아짐
 - 그러나, 출산에 있어서는 일부 소수민족 마을을 중심으로 전통적 산파에 의한 출산도 지속되고 있음을 확인함
- (아웃리치 및 VHSG의 효과) 소외지역의 아웃리치 서비스와 교육된 지역사회 VHSG를 통해 지역사회에 모자보건 서비스에 대한 인식과 행태가 개선됨
- 특히, VHSG는 사업지역 내 산전·산후관리 촉진, 안전한 분만 유도, 예방접종 장려, 응급 이송 시스템 활용 등 모자보건 서비스 개선에서 중요한 역할을 수행함
 - VHSG 등을 통해 방문진료를 하면 기존에 비해 보건소 이용의 대기시간을 고려하지 않을 수 있어 기존에 농사나 생계의 문제로 인해 보건소에 방문하는 시간을 맞추기 어려워했던 사람들이 더 많이 교육과 진료에 참여할 수 있게 됨
 - 특히, 설문조사 결과에 따르면 모자보건의 중요성에 대한 정보를 얻는 경로로 보건소 의료진(75.6%) 다음으로 VHSG로부터 정보를 얻는다는 응답이 많았음(50.7%, 복수 응답 허용). 즉, 산모들이 보건소를 방문하지 않고도 모자보건 정보를 얻는 경로로써 VHSG 시스템이 유용했다고 할 수 있음

- (개선 필요사항|서비스 제공 태도) 일부 치료진의 비우호적인 태도와 지지에 서비스 만족도가 떨어지는 모습을 보였으며, 이는 언어적, 문화적 장벽이 상대적으로 큰 소수민족일수록 경험할 확률이 높아지는 것을 확인함
 - 소수민족 산모의 경우 서비스 이용 의지에도 불구하고 보건소, 병원 의료진의 태도로 인해 향후 방문 의지를 상실하는 경우들을 확인할 수 있었으며 언어적 장벽은 수요자의 의료적 문해력 저해 등으로 인해 공급자들에게도 서비스 제공의 장애물로 작용하고 있음
 - 이러한 언어적 장벽은 소수민족 구성 비중에 따라 달랐음. 예를 들어, 크메르어를 잘하는 소수민족이 많은 지역(쿤뭉)과 그렇지 않은 지역(안동미아)에 따라 체감하는 정도에 차이가 있었음
- (개선 필요사항|영양 관련 교육 및 서비스) 산모와 자녀의 영양 관련 교육 및 서비스는 상대적으로 불만족스러운 것으로 나타남
 - 어머니들은 모자보건 교육 내용에 대체적으로 만족하였으나, 채소를 섭취할 것을 권장하는 등의 피상적이면서 단순한 교육 내용에 실망을 표시하거나 구체적이면서 자세한 정보가 있는 영양 관리 정보에 대한 요구가 있음. 자녀의 저체중 문제로 영양제를 받은 어머니는 그 영양제가 도움이 되지 않았다고 보고함
 - 이런 부분은 CNP 사업과의 중복성 배제하며 기획되었기 때문으로 판단되나 향후 상호보완할 필요가 있을 것으로 판단됨

3.1.2. 공급자 측면에서 역량강화 프로그램의 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가?

- JICA, GAVI와 UNICEF 등이 건축, 백신 현물 등 일부분을 단편적으로 지원해 주는 것에 비해 KOICA 사업의 특징은 기자재 지원과 함께 교육을 제공해 주는 것이 큰 장점이라고 보고함
 - 정부기관 혹은 타 원조기관에서 이미 제공된 교육일 경우 해당 교육을 선택할 수 있어 수요자들이 필요로 하는 내용에 맞춰 교육이 진행되었다고 보고함. 기자재의 경우 중복해서 지원받은 것들은 없다고 보고함
- (보건소장 및 PHD 직원) 대상 사업이 지역 모자보건 서비스 체계 개선에 기여했다고 평가함
 - 정부와 지역 의료시설 간 협력 체계가 강화되었으며 산모들의 정기적 방문도 권장되어 매달 검진을 받고 약을 받는 등 정부-지역 의료시설-지역사회와의 교류가 증가되었다고 판

단됨

□ 사업 이후, 환자 경험 및 대처역량이 증진하여 보건소 출산 비율이 증가하고 이를 데이터화하고 관리하는 등 행정적인 역량도 강화됨

- 예를 들어, 한 달에 오춤보건소의 경우 15명, 안동미아 보건소의 경우 10~20명, 끈몸 보건소의 경우 11월에 37명, 12월에 26명 정도를 진행하여 평균적으로 1개월에 20명의 출산을 하고 있었음
 - 라파나끼리 주립병원의 경우 의료진의 환자 경험 및 대처 역량이 증진되어 1달에 130명 정도 출산을 하며, 제왕절개 수술의 비중도 높고 보건소에서 제왕절개가 필요할 경우 추가 이송도 용이하며 마취교육 이후 수술을 다양하게 되면서 환자들의 이송이 크게 감소되었다고 판단됨
 - 각각의 병원들은 산파들이 사업을 진행한 뒤 출산하는 인원수를 파악하고 있었으며, 어떤 고위험 산모들이 이송되고 있는지에 대해서 파악하고 있었음. 또한, 사업 진행 후 출산하는 수가 늘었다고 답하였으며, 환자들 백신을 더 잘 접종하고, 보건소를 더 신뢰하여 방문한다고 답함.
 - VHSG는 사업을 통한 마을 주민들의 산전, 산후 및 신생아의 건강 관리 방식의 변화 및 효과를 인지함. 산전·산후 진찰 횟수, 분만 방식의 변화, 신생아 백신 접종률의 증가로 마을 산모와 아이들의 사망률이 줄었다고 언급함
 - 본 사업을 통해 지역사회 간호사들이 교육을 받고, 주민들이 나은 의료서비스를 이용할 수 있도록 도움을 받음. 프로그램을 통해 건강검진 및 건강 보호 능력이 향상되었으며, 건강관리 방식도 개선됨(예: 임신부의 노동 강도 조절, 산모 건강관리 방법 개선). 프로젝트 종료 후에도 보건소에서 지속적으로 사업을 유지하고자 하는 의지가 있음
- (의료진 역량 강화) 교육 및 시설 지원을 통해 의료서비스 제공 능력이 향상되었음을 강조함. 특히 교육수요가 반영된 역량강화 사업에 대해서 전반적으로 높게 평가하고 있었음
- 보건소 산파들의 경우 대부분 Basic Emergency Obstetric and Newborn Care (BEmONC) 교육을 받았으며, 이 교육에 대해서는 받고 싶은 교육이었다고 함
 - － 산모 관리 및 백신 접종에 대한 이해가 높아졌으며, 보건소 측면에서는 특히 출혈과 같은 산파적 응급상황, 고위험 분만에 따른 이송 파악 역량이 크게 증가하였다고 평가함. BEmONC를 받으며 모유수유, 캥거루케어, 주산기 관리 등에 대해서도 이해가 높아졌다고 보고함

- 라파나끼리 주립병원의 경우에는 CEmONC 교육과 BEmONC 교육이 어떤 교육인지 알고 있었고, 마취간호사 교육은 척추마취(spinal anesthesia)와 일반마취(general anesthesia)를 모두 포함하였으며 이러한 교육은 제왕절개 등의 수술을 위하여 실제 받고 싶었던 교육이었다고 함
- (의사 대상의 심화교육) 그러나, 의사 대상 및 CEmONC 단계의 심화 교육에 대해서는 수요를 충족하기에는 상대적으로 부족했다고 보고됨
 - 라파나끼리 병원의 CEmONC 교육 이수자들은 교육 시간이 상대적으로 짧고 프놈펜까지의 이동시간과 마취교육의 시간에 대하여는 부족함이 있다고 함. 특히 마취 시작(induction)에 대한 교육은 받았으나, 마취 시 응급상황과 마취 이후 회복 과정이 원활하지 않을 때 적절하게 대처하는 것이 어려움을 토로함
- (VHSG 대상 교육) VHSG들은 보건소에서 받은 교육의 내용을 주민들에게 전달하기에 부족하지는 않으나 더 높은 수준의 모자보건 관련 교육받기를 원하고 있었음

3.1.3. 공급자 측면에서 건축 및 기자재 지원에 대한 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가?

- 건축 및 기자재 제공으로 인하여 모자보건 서비스의 질 향상 및 만족도 향상을 가져올 수 있었음. 다만, 일부 기자재의 경우 활용 인력의 역량 부족 등으로 사용되지 않거나 기자재가 지급되지 않아 현장의 필요에 대응하지 못한 경우도 확인할 수 있었음
- 보건소들에게 지원된 시설 중 고압멸균기(Autoclave)의 경우 기존에 사용하기가 어려웠으나 KOICA 지원 이후 사용할 수 있게 되었다고 함. 안동미아 보건소의 경우 초음파 기기가 제공되었고 이를 유용하게 사용하고 있다고 함. 도플러의 경우 심박수 측정 등에 용이하게 사용하고 있다고 답하였으며, 다만 배터리가 빨리 닳고 이에 대한 공급이 원활하지 않거나 작동하지 않을 때가 있다고 함
- 오춤보건소와 꾸몄보건소 모두 코이카 프로그램으로 지원된 시설(분만대, 병실 침대 등)이 수요에 맞는 지원이었으며, 특히 꾸몄보건소의 경우 구급차를 지원받은 것이 가장 큰 도움이 되었다고 보고함
- (원조방식의 효과) GAVI와 UNICEF 등 타 해외원조기관의 자원 지원 방식에 비해 KOICA는 수요자들이 필요로 하는 시설과 교육을 병행하여 지원해주는 것이 큰 장점이라고 함
- (구급차) 지역의 특성상 필요성이 크며, 주정부에서 받은 구급차보다 KOICA에서 제공 받

- 은 구급차를 더 자주 사용하고 있으며, 다른 보건소에서도 함께 사용할 수 있다고 보고함
- 특히 한국산 자동차의 경우 상대적으로 지역 정비소에서 수리가 용이한 편이라고 보고함. KOICA의 수리 지원 후 해당 구급차로 3개 보건소(Ta Lav, Malik, Pak Nhai)가 협력하여 사용하고 있음. 이에 구급차가 더 지원된다면 더 많은 보건소를 도와줄 수 있다고 보고함
- 다만, 보건소 구급차들에 비치된 산소통 및 응급 약제, 소모품의 경우 관리 담당직원 지정이 안되어 있어 점검 및 유지 보수가 미흡한 것으로 파악됨

3.2. 사업의 효과성을 높이기 위해 향후 추가적으로 필요한 사업의 내용은 무엇인가?

- 임신 중 관리에 대해서는 많은 자원이 이뤄졌으나, 성병, 임신합병증 등 부인과적 질환에 대한 지원이 이뤄진다면 현재 H-EQIP 사업에서 추진 중인 만성질환 대상 중 자궁경부암 예방 및 치료 등에 추가적인 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단됨
- 라파나끼리 주립병원의 산부인과 의사의 의견에 따르면 20~30%의 산모가 자궁경부의 인간유두종바이러스(HPV) 감염이 의심된다고 함. 그러나, 자궁경부세포진검사(PAP smear) 등의 확인할 수 있는 조치를 할 수가 없다고 함
 - 육안 진단에 의존해야 하고 원뿔절제술(conization) 등의 치료가 불가능하여 프놈펜으로 이송을 하여야 하며, 암의 경우에도 치료받기 어렵다고 함. 생식기 사마귀의 경우에도 냉동치료나 이미퀴모드 등의 약을 이용한 치료가 어렵다고 함
 - 보건소에서도 동일하게 인간유두종바이러스(HPV) 백신이 지원되어 접종을 하고 있으나, 여전히 지역주민들의 경각심이 부족하며, 성관계 시에도 피임 교육 등이 잘 이뤄지지 않고 있다고 보고함. 성기 헤르페스 감염으로 의심되는 수포성 질환들도 많다고 보고함
- 후속 사업에서 CEmONC의 혈액 관리와 마취 분야에서 의료진의 역량 강화 및 기자재 지원을 통해 모자보건뿐만 아니라 보건의료체계 전반의 역량 강화를 꾀할 수 있을 것임
- 보건소의 경우 임신 검사를 하기 위한 혈액검사 장비가 부족하다고 함. 다른 혈액검사는 불가능하고 혈당 수치만 확인할 수 있는 기계가 있어 주산기 관리에 있어 적극적인 감시가 어렵다고 보고함
- 라파나끼리 주립병원의 경우 혈액을 보관하는 공간이 넉넉하지 않고, 성분분리를 하지 못하고 전혈로 보관 중임. 이러한 점들이 다량 출혈이 있는 산모의 관리에 어려움을 겪게 함. ABO와 Rh만을 확인하고 있으며 맞지 않는 경우에는 가족들이 수혈을 진행하여 해당 전혈을 보관소의 전혈과 교환하여 수혈을 진행하고 있음
 - 마취 약제의 경우, 현재 isoflurane등을 사용하고 있고 공급과 비용문제가 해결되어 마

- 취 이후 회복이 더 용이한 sevoflurane 등 약제도 사용할 수 있게 된다면 환자에게 더 좋을 것임
- 마취 기계가 오래되어 향후 인공호흡기(ventilator)와 마취 기계가 새로 제공되면 효과를 높일 수 있을 것으로 판단됨

4. 효율성

4.1. 예상치 못한 상황(코로나-19)이 발생했을 시 대내외 상황변화에 적합하고 현실적인 위기관리 대응이 마련되고 실현되었는가?

- ☐ 2020~2021년 코로나-19 팬데믹 발생 이후 지역사회 활동 등 대부분 사업 활동 수행이 어려워짐에 따라 대내외 상황변화에 적절히 사업계획을 코로나 긴급 대응 활동으로 기획 개편하여 현실에 맞게 비대면 방식으로 활동을 수행함
 - 대면 집단 활동 대신여 코로나-19 긴급 대응활동으로 오디오, TV 제공해 다양한 미디어를 활용해 코로나 비대면 캠페인을 진행하고 모자보건 캠페인에도 활용하여 코로나-19로 인한 비대면 활동 시기에도 지역주민의 모자보건 지식 수준이 향상됨 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 사업수행(PMC) 용역 최종 보고서
 - 라타나끼리 및 몬둘끼리의 코로나-19 검사 역량 강화를 제공해 사업 수혜자(임산부, 아동 등)의 감염경로를 관리하고 조속한 지역사회의 안정 및 보건의로 인력 업무 정상 복귀가 가능하게 하여 사업 지연을 최소화함
 - 코로나-19 신속진단키트, 격리시설 내 사용을 위한 간이 침상을 보급하여 사업 대상자들이 직접적인 응급 혜택을 받을 수 있게 함
- ☐ (설문조사 결과) 대부분 사업 대상자는 본사업에서 제공한 코로나 긴급 대응 활동의 혜택을 제공받았고(아무 지원을 받지 못한 응답자 2.9%), 해당 사업에 만족하였음(90.0%)을 확인함
 - 특히 절반 이상(57.8%)이 음성 콘텐츠를 통해서 기존에 계획한 모자보건 인식개선 서비스를 받았다고 응답함

- 이에 긴급 대응 활동을 기존 계획 사업과 연계하여 활용할 수 있는 TV 영상 및 음성 콘텐츠 송출로 기획해 운영한 점이 우수하다고 판단할 수 있음
- 그러나, 공급자 측면에서는 코로나-19 팬데믹 동안 온라인 교육 및 원격 모니터링이 도입되었으나, 대면 교육 부족으로 인해 일부 공급자의 역량 강화에 한계가 있었음

4.2. 필요한 자원이 적절한 시기에 제공되었는가? 적절한 시기에 제공되지 못하게 되었다면 주요 원인은 무엇인가?

- 본 사업의 아웃리치 활동을 통해 예방접종 및 교육에 대한 서비스 제공 시간의 효율성이 향상된 것에 대한 만족감을 확인함
 - VHGS를 중간 전달자로 하여 마을 주민들을 교육한 방식은 보건소와 멀리 떨어진 마을의 지리적 특성상 효율적인 방식임
 - 공급자들은 이전보다 서비스가 많이 빨라지고 개선된 것으로, PDM 상의 서비스 만족도가 97.1%로 기초선 대비 400%가 넘는 달성도를 보인 주요 원인 중의 하나로 판단할 수 있음
 - － 일부 수요자들은 보건소 및 병원 외래 서비스의 접근성 및 대기시간에 불만을 제기하기도 함
 - 시설 및 지원 대부분은 공급자의 필요를 충족하였고, 교육 시간과 장소도 적절하게 조정되었다고 보고함. 보건소에 제공된 응급약제들은 지침서가 구비되어 있어 사용할 수 있게 되어 있었으며, 그 외의 분만 도구들을 적절하게 멸균 후 사용하고 있었음을 확인함
- 응급 상황 시 이동 수단의 부족이 효율성을 낮추는 요인으로 작용함
 - 마을에서 보건소 또는 병원으로의 응급 수송 체계가 미비하며, 이웃에게 오토바이나 차량을 빌리기도 하나 이동 중 사망 시 처리에 대한 곤란으로 대여를 할 수 없는 경우도 있어 후속 사업에서의 보다 체계적인 응급의료 전원체계의 개선이 필요해 보임

4.3. 제공된 자원의 이용과 협력의 방식이 효율적인 방식으로 이루어졌는가? 더 효율적으로 변화하려면 어떤 것이 필요한가?

- 전반적으로 해당 지역에 근무하는 의료인들은 자신이 의사결정을 내릴 수 있는 기회가 많이 주어졌으며 이에 대해서 외부적인 간섭이나 의사결정과정의 복잡성으로 발생하는 불필요한 손실이 발생하고 있지는 않다고 보고함

- 기존에 교육을 받은 의료진이 받지 못한 동료 또는 전달체계의 하부로 교육을 전파하는 ToT(Training of Trainers) 형태로 교육함으로써 교육이 효과적으로 전파되고 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었음
 - 산파들이 서로 받은 교육들이 보완되도록 서로 모르는 부분에 대해서 가르쳐 주고 보건소에서 주립병원에 방문하여 소생술, 출혈 관리 위주로 교육을 받고 있다고 보고함
- 제공된 기자재의 경우, 효율적으로 활용을 하고 있으나 일부의 경우 제공 사실의 혼동 및 관리 부실이 있음
 - KOICA에서 받은 구급차 등을 이웃하는 보건소와 공동으로 운용하는 등 전반적인 시스템 향상을 도모하고 있는 것으로 확인함
 - 라파나끼리 주립병원의 소아청소년과의 경우 인큐베이터, 가온기, 초음파 등이 적절하게 사용되고 있으며, 신생아 황달에 대한 광선치료도 용이해졌다고 보고함. 또한, 소아청소년과에서는 프놈펜으로의 이송을 50% 정도 줄일 수 있었다고 함
- KOICA 건물로 신생아실을 옮긴 뒤 기존 산부인과 시설에서 다양한 수술을 할 수 있게 되었다고 보고하여 제공된 자원이 효율적으로 활용되고 있음을 확인함
 - 그러나, 병원에 현재 지원된 시설이 신생아 시설로만 사용되고 있어 산부인과에서 사용을 하지 못하여 산부인과 기자재에 대한 구체적인 파악을 산부인과에서 하지 못하는 사례도 발견됨
 - 산부인과는 분만 이후 양압환기기가 필요하다고 언급하였으나 실제 지원되어 있었음에도 산부인과에서 모르고 있었음
- 후속 사업을 통해 변화된 수요에 근거한 장비 및 기자재 자원의 재분배 및 재교육이 필요함
 - 보건소에 제공된 흡입분만기의 경우 교육을 받지 않아 사용을 못하고 있다고 답하였으며, 이는 라파나끼리 주립병원에서 흡입분만기가 새로 제공되지 않아 필요하다고 답한 것에 대조됨
 - 또한 보건소에서는 분만대가 새로 비치된 뒤 남는 분만대 등은 다른 보건소에 빌려주고 있었으나, 라파나끼리 주립병원에서는 직접적으로 분만대가 부족하다고 언급함
- (환류 과제) 기자재의 효율적인 활용을 위해, 활용할 수 있는 인력으로 관리 담당자 정, 부를 지정하고 정기적인 물품 점검이 체계적으로 이루어질 필요가 있음
 - 관리담당자 지정 등 관리에 대해서는 대상 사업의 심층기획조사 보고서에도 담겨 있으나 현장에서는 지속적으로 시행되지 않은 측면이 있음

- 이는 임상의가 아니면 이러한 기자재의 활용 및 관리체계 등에 대해 알기 어려우며 중저 개발국이 가지고 있는 원조의존성 행태에 일부 기인하는 것으로 판단됨
- 따라서, 후속 사업에서는 주립병원 중심의 기자재를 포함한 의료역량 강화를 꾀하고 있으므로 이러한 지점을 보완할 고려할 필요가 있음

4.4. KOICA-사업 주체-현지 이해관계자 간 파트너십 및 커뮤니케이션은 효율적으로 이루어졌는가?

- 코로나19로 인한 사업의 지체 및 몬둘끼리주에서의 사업 수행의 순연 등의 어려움 속에서도 단기간 내에 성과를 이룬 것의 가장 근본적인 작동 요인은 신뢰에 근거한 코이카-파트너 기관-현지 주보건국-지역사회와의 밀착된 협력관계임을 확인할 수 있었음
- 이는 로직모델 등 기존의 기계적인 사업평가 이론에는 잘 포착되지 않으며 사업성과 평가에서도 pre-condition으로 규정되나 실제 현장에서는 매우 중요한 작동 요인으로 볼 수 있으며 대상 사업의 효과적이고 효율적인 사업의 수행에 있어서 가장 근본이 되는 성공 요인으로 볼 수 있음
- 사업을 수행한 파트너 기관 간에도 캄보디아의 발전과 개발에 대한 애정과 의지를 가지고 오랫동안 활동을 해온 가운데 함께 대상 사업을 수행하게 되어 라포 형성이 수월하게 이루어짐
- 특히, 파트너 기관-라따나끼리 주보건국과의 관계는 매우 협력적이어서 중저개발국의 타 사업 수행 시 흔히 볼 수 있는 권위적 관계이거나 행정절차에 매몰되거나 사익 추구 등의 태도나 행태를 찾기 어려움
 - 실제 라따나끼리주 보건국 부지 내 굿네이버스 사무소가 자리하고 있어 사업기간 동안 빈번한 미팅과 협의가 이루어져 왔으며 이를 통해 보건국 내 기존의 사무적이고 관료주의적이던 업무수행이 상호협력적으로 바뀌는 계기가 된 것으로 보고됨
- 라따나끼리 주보건국 직원과 지역사회와의 관계도 매우 친밀하여 지역사회 내 산모와 아이를 일일이 알아볼 정도로 교류와 협력 관계가 잘 이루어지고 있음을 알 수 있음
- 결론적으로, 수혜자들의 건강 증진을 위해 대상 사업의 적극적인 수행을 통해 이해관계자들의 태도와 행태의 변화를 이끌어 낼 수 있었고, 코이카-파트너 기관-현지 주보건국-지역사회 간의 신뢰와 협력이라는 사회적 자본을 구축할 수 있었고 코로나19에 민첩하게 대응하고 단기간에 성공적인 사업의 성과를 올릴 수 있었음
- 이러한 사회적 자본 또한 후속 사업의 작동 요인이 될 수 있도록 지속하고 발전시켜 갈 필요가 있으므로 후속 사업의 수행 파트너 기관인 사업 초기에 사회적 자본 축적을 고려한 전

략을 수립할 필요가 있음

- 일부 국제개발협력 사업의 경우와 같이 코로나19로 인한 목표 하향 또는 사업 연장이 이뤄진 것에 비해 계획 변경 없이 소기의 목표를 달성한 점, 유사 사업의 전형적인 의료진의 연수사업 대신 보건부 산하 위탁교육 등을 통한 의료진 교육을 실시한 점 또한 효율성 측면에서 높이 평가될 지점임(KOICA, 2022)

5. 지속가능성

5.1. 수원국 제도가 사업을 지원하는가?

- ☐ (H-EQIP 사업의 ID Poor 카드를 통한 모자보건 서비스 비용 지불) 현재 캄보디아의 H-EQIP 사업으로 조성된 건강 형평성 기금(HEF)을 통해 빈곤층 및 저소득 가정을 상대로 의료비를 지불해주고 있어 이들의 모자보건 서비스 비용 지불에 일부 활용되고 있음
- 캄보디아는 H-EQIP 사업을 통해 빈곤층 및 저소득 가정의 의료비를 보장하는 건강 형평성 기금(HEF) 제도를 2000년에 도입하여 시행해 왔으며 이에 빈곤층으로 분류되어 ID Poor 카드를 발급받은 가구는 본 사업에 해당하는 모자보건 의료비뿐만 아니라 교통비, 식대 등 부대비용 일부를 지원받을 수 있음
- ☐ (설문조사) 설문조사 결과에 따르면, ID Poor 카드를 소지하고 있다고 대답한 가구는 38.99%였음. 또한 ID Poor 카드를 통해 주요 모자보건 서비스(ANC, 분만, PNC)를 제공받았다고 응답한 사람은 31.56%로 ID Poor 카드를 소지한 가구에서는 대부분 이를 이용하여 모자보건 서비스 비용을 충당하였음을 알 수 있음
- CDHS 2021-2022의 재산 5분위에서 라타나끼리 인구 중 75.4%가 최빈곤층(poorest)에 해당하며 몬톨끼리 인구 중 최빈곤층 비율은 51.5%임(DHS, 2023). 이를 통해 모자보건 서비스 이용 시 비용의 장애를 극복할 수 있는 제도적 뒷받침이 어느 정도 되고 있다고 볼 수 있고 이는 관련 사업의 지속가능성을 보장하는 하나의 요인으로 작용할 수 있음

5.2. 사업 대상 지역사회 주민의식이 사후에도 사업을 발전시킬 수 있을 만큼 충분한가?

- ☐ 사업의 주인의식은 사업이 끝난 이후에도 사업이 계속 발전해 나갈 수 있는 지속가능성을 만들어 내는 요소로 국가와 정부뿐 아니라 마을주민의 주인의식도 지속 가능한 발전의 핵심 원동력임. 이러한 심리적 주인 의식은 사업을 알아가는 대상 경험, 사업에 자신의 노력을 기울이는 자기 투자, 사업 의사 결정에 참여하는 대상 통제의 경로를 통해 유발됨(Ambuehl, 2021)
- ☐ 현지 보건부 주요 직원 면담에 따르면, 프로젝트 종료 이후에도 사업을 지속할 의지가 강하게 존재하나 안정적인 운영을 위해서는 지속적인 예산 지원이 필수적일 것으로 보임
 - 라파나끼리의 경우, 대상 사업이 해당 지역에서 거의 최초로 이루어진 대규모의 ODA 사업으로, 관련 경험이 부족할 수 있어 여전히 KOICA의 후속사업에 대한 기대를 가지고 있으며 특히 예산에 대해서는 아직은 의존적임을 판단할 수 있음
- ☐ 수요자의 경우, 여러 사회경제적 맥락에서 자원이 빈곤함에도 불구하고 특히, 산모 및 가족 등 KIRI Class 참여경험자의 경우, 후속 사업 참여 의향이 높고 일부 자조 모임은 사업 종료 후에도 지속되고 있어서 후속 사업의 요소로 반영하여 사업 수행 지역을 확대할 필요가 있음
 - 예를 들어, 어머니 교실은 사업대상지 총 200여 개의 마을 중 29곳에서 실시되었음에도 불구하고 이에 대한 사업의 확대 요청을 여러 곳에서 요구하는 것을 확인함
- ☐ VHSG들은 보건소에서 제공되던 교육이 사업 종료 후 더 이상 제공되지 않아 아쉬움을 느끼고 있었으며 일부 지역에서는 굿네이버스의 지원 하에 VHSG들의 교류나 회의를 지속하는 등 주인의식을 가지고 자체적인 활동을 하고 있음
 - VHSG와 소통하는 비중은 각 보건소마다 달랐으나 오춤보건소의 경우에는 매월 같이 회의를 하며 다양한 사안에 대해 논의하는 방식이었으며, 안동미아 보건소 같은 경우에는 환자가 방문하기 전에 서로 연락하는 등 필요에 따른 적극적인 소통이 자주 이뤄지고 있었음
 - 이를 통해 보건소와 VHSG들이 직접적으로 소통을 지속적으로 하고 있으며 이를 통해서 보건소가 지역주민들의 건강관리에 직접적으로 관여하고 방문 사업을 통해서 사업의 효과성을 지속할 수 있는 가능성을 확인함

5.3. 향후 프로그램이 지속적으로 운영되기 위한 사업의 요소는 무엇인가? 파악이 이뤄졌

다면 어떤 부분들이 개선되어야 하는가?

- (후속 사업의 연계성) 지역의 특성과 사업의 효과를 고려하여 VHSG 중심의 아웃리치 등 사업 요소를 연계하고 나아가 의료진 역량을 추가적으로 강화하는 것이 필요함
- 의료 공급자 중 자립도 및 주인의식에 있어서 매우 높은 수준의 의지를 보이며 사업 종료 이후에도 자체적인 교류나 회의를 가지고 있음
- 수요자들은 프로그램의 지속에 대해 긍정적으로 반응하였으며, 특히 VHSG에 의한 예방 접종과 건강관리 교육의 지속적인 제공에 대한 기대감이 높음
 - － 후속 사업에서 만일 외상외과 등을 다루게 된다면 지역사회에서는 VHSG를 활용한 손상 예방 교육 및 활동을 강화하는 등 사업의 효과성을 강화하기 위해 VHSG에 대한 역량 강화가 병행되어야 할 필요가 있음
- 이에, 대상 사업의 후속 활동이 굿네이버스를 중심으로 VHSG의 활동을 지원하고 있으나, 인력의 탈락 및 CNP 사업의 VHSG 등 보다 나은 혜택을 따라 이동하는 현상이 나타남
 - － 라타나끼리 및 몬둘끼리 지역 특성 상 계절에 따라 이동 인구가 발생하여 VHSG 탈락(Drop-out)이 발생하고 있으며 새로 선발되는 VHSG에 대하여 보건소를 통해 지속적인 관리와 교육이 필요함
- 또한, 월드뱅크에서 시행하는 캄보디아 영양 프로그램(CNP)의 경우 월별로 활동비(최대 약 150불)를 지원하고 있어 월드뱅크와 사업의 시너지효과를 위한 논의와 더불어 사업 자체적으로도 자발성을 해치지 않는 범위 내에서 추가적인 인센티브 방안에 대한 검토가 필요해 보임

5.4. 건축물의 관리는 잘 이뤄지고 있는가?

- (라타나끼리 주립병원 모자보건센터) 신축된 건물 상태는 깨끗했고, 보수가 필요한 부분은 없었으며 진찰실, 검사실, 분만실, 분만 후 병실 등 분만의 필수 과정에 따라 공간 구분이 되어 있었음
- 분만 후 병실에는 별도의 화장실과 샤워실이 구비되어 있어 출산한 산모들이 위생적이고 안전하게 사용 가능함
- 병원 규모와 진료 수준에 맞게 센터 내 분만실을 신생아 전용 병상(미숙아 등)으로 활용함

- (보건소 모자보건센터) 신축된 모자보건센터는 보건소에서 인접한 곳에 지어져 환자들이 적절하게 활용가능한 상태로, 전반적으로 시설 상태는 양호하여 보수가 필요한 부분은 없었음
- 진찰실, 검사실, 분만실, 분만 후 병실 등 공간 구분이 잘 되어 있었음. 화장실과 샤워실이 구비되어 있어 출산한 산모들이 위생적이고 안전하게 사용가능한 상태임
 - 일부 보건소의 경우, 대기 장소 또는 식사를 준비할 수 있는 공간 등이 없어 이러한 시설의 개선 필요성을 보고하기도 함

5.5. 기자재, 소모품의 관리 및 활용은 잘 이뤄지고 있는가?

- (기자재, 소모품의 관리) KOICA에서 지원한 기자재에 대해서는 지속적인 관리가 이뤄짐
- 기존 장비의 유지보수 및 기본 의료행위는 지속 가능하나, 검사 장비 및 수술 장비의 유지보수와 같은 추가 비용이 필요한 항목들은 예산 부족으로 인해 운영에 어려움을 겪고 있음
- 신생아 치료를 담당하는 의사의 장기 휴직으로 인해 인큐베이터 사용이 중단되는 경우가 발생한 바 있어 후속 사업을 통해 대체 의료진에 대한 교육을 통해 공백 최소화가 필요함
- (구급차) 기증받은 주립병원 구급차는 고위험 분만 시 상급 병원 이송, 외상 사고 발생 등 여러 가지 상황을 포함하여 월평균 10회 출동으로 지역 내 응급의료 서비스를 일정 수준 제공 중임
 - 야간 출동 시에 도로에서 개를 치는 경우가 많아 범퍼가 파손되었음에도 수리에 수일이 소요되어 그대로 운용 중임
 - 기증받은 구급차가 차체가 낮아 비포장도로를 갈 때 충격과 차량 손상이 발생하고, 2륜 구동이어서 우기 때 운영하기가 어려움
 - 구급차 내부에 휴대용 산소측정기와 혈압기 정도만 구비해 두고 있어서, 이송 중 환자 관찰 모니터가 필요함. 구급차 체크리스트에 장비 구성뿐만 아니라 관리 및 유지보수 지침을 추가할 필요가 있겠으며 출동 이후에도 장비 점검을 체계화하는 것이 필요함
- (모터보트) 일부의 경우, 소모품 등을 구할 수가 없어서 운용 필요시 다른 모터보트의 부품을 빼와서 운용하는 등 유지보수가 필요한 시기가 도래하고 있음을 확인함

6. 영향력

6.1. 수요자들이 건강관리 방식에 있어서 변화를 인식하고 실천하고 그 영향력을 인식하고 있는가? 영향력이 있다면 어떤 영향이 있었는가?

- ☐ (건강관리의 변화) 기존의 건강관리 방식의 지식, 태도, 실천의 변화를 통하여 건강한 모성건강을 유지할 수 있으며, 이러한 건강관리는 생활의 타 분야에도 적용되고 있음
 - 기존에 미신에 의지하여 집에서 출산한 후 밥과 소금만 산모에게 제공하였으나, 대부분이 출산 시 보건소를 이용하고 교육받은 대로 산후관리를 하게 됨
 - 임신 중 소량의 음주가 가능하다고 생각했으나, 왜 술을 먹으면 안되는지에 대해 자세히 교육받고 임신부와 태아에게 유해한 행동을 하지 못하도록 하는 사례가 발견됨
 - 유치원 교사이면서 5세 미만 아이를 키우는 어머니는 위생에 대한 교육 이후에 유치원 원생들의 청결도가 개선되었으며, 요리 전 식재료의 세척법도 교육 이후에 개선되어 음식을 먹은 다음 설사가 줄었다고 하였음

6.2. 프로그램이 공급자 간, 공급자와 수요자 관계에서 신뢰 관계 및 행동양식에 미친 영향이 있는가? 향후 유사 사업 추진 시에 신뢰 관계를 형성하기 위해서는 어떻게 반영할 것인가?

- ☐ KOICA 사업 이후 정부 및 지역사회 간 신뢰 관계 향상, 보건소와 VHSG 간 협력 체계 강화가 본 사업의 긍정적 영향으로 자주 언급된 바 있음
 - 정부와 지역 의료시설 간 협력 체계 강화뿐만 아니라 산모들의 정기적 방문으로 인해 정부-지역 의료시설-지역사회와의 교류가 활발해졌음
 - 보건소 및 OD의 데이터화 및 정책 관리 등 보건의료행정 역량도 강화되었다고 보고됨
- ☐ 특히, 보건소에 대한 지역사회의 신뢰 수준이 향상되었으며, 이러한 점들이 보건소의 이용행태에 대해 긍정적인 영향력을 행사한 것으로 보고함
 - 이전에는 주민들이 기도만 하는 등의 신념이나 보건소 직원들과 보건소가 질병을 옮긴다고 생각하여 피하는 경향이 있었으며, 백신을 맞으면 열이 나거나 할 때 다른 병을 준다고 생각했고, 특히 부정적인 소문 중에는 주사기를 재사용한다는 소문 등이 있었음
 - 현재는 보건소에 대한 인식이 좋아져서 의료진들이 방문에 호의적이며, 백신에 대해서도 두려움이 사라졌다고 보고함
 - 특히 VHSG 교육이 진행된 뒤 병원서비스를 받는 것을 선호하는 주민들이 증가하였다고

보고함. 또한, 보건소의 시설 개선 또한 보건소를 신뢰하게 되는 계기가 되었다고 보고함

7. 범분야 이슈

7.1. 인권주류화 및 젠더 주류화: 소수 민족, 원거리 마을주민, 여성 등 취약 계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요를 반영한 프로그램을 기획하였는가?

- ☐ (소수민족 필요 반영) 대상 사업 자체가 캄보디아 내 소외된 지역을 대상으로 이뤄진 사업으로 사업의 목적과 수행 자체로도 인권주류화에 기여하는 바가 있음
 - 라타나끼리주와 몬돌끼리주의 소수민족과 원거리 마을주민이 산간 지형의 지리적 특성과 타 지역 보다 긴 우기를 가진 환경적 특성으로 인해 의료시설 접근이 제한되므로 이에 직접 마을로 찾아가는 아웃리치 활동을 통해 소수민족, 원거리 마을주민 등에 의료서비스를 제공함
 - 원거리 마을 주민의 경우 응급상황 시 사용할 수 있는 임대 차량의 비용 부담이 큼. 예시로 톰팟 지역에서 인근 병원까지 25 USD 비용이 발생함. 보건소에서 병원까지 이동하는 구급차는 본 사업에서 지원하였으나, 마을에서 보건소까지의 접근성 문제는 여전히 개선이 필요한 것으로 파악됨
 - 설문 조사 결과도 일관되어, 산전, 출산, 산후서비스를 이용하지 못한 경우에 대한 질문에 물리적 거리, 교통수단 제한 등의 물리적 접근성의 어려움을 주요 원인으로 나타났음
 - 현지 종료 평가조사에서 확인한 바에 따르면 대부분 소수민족은 크메르어를 읽고 쓸 수는 없어도 일상적인 의사소통은 가능한 정도의 회화 능력을 구사하는 것으로 판단됨
 - 이에, 의료인력, 마을 보건 요원, 마을 지역주민들 등 사업 참여자들 사이에서 소수민족 언어로 또는 문자가 없는 경우 동영상 등을 통한 모자보건 교육 제공과 VHSG의 병원 입퇴원시 동행 등이 필요하다는 의견이 공통적으로 제시됨
 - 언어와 문화가 마을마다 상이하기 때문에 중간 연결자인 마을보건요원을 해당 마을 주민 중에서 선발한 것은 취약계층의 소외 문제에 적절히 대응했다고 보여짐.
 - 소수 민족어를 활용한 음성 미디어 교육 제공, 그림 시각 자료 활동 등을 통해 취약 계층 식별 및 차별적 수요 반영 프로그램 기획을 노력하였으나 일부 더 소외된 집단의 욕구가 잔존함
- ☐ (여성 인식 개선) 여성 건강에 대한 인식개선 및 접근성이 강화될 뿐만 아니라 여성 VHSG 활동으로 일방적 수혜자에서 주도자로 전환시키며 지역사회 여성의 참여율을 높임

- 과거에는 여성들이 임신과 출산 관련 의료서비스를 제대로 받지 못하는 경우가 많았음. 코이카 프로젝트를 통해 산모 및 여성건강 검진이 활성화되었으며 예방접종, 영양 지원, 철분제 및 비타민 공급 등의 모자보건 서비스 제공이 강화됨
- 여성을 VHSG으로 선발하여 지역 내 보건 교육과 출산 관리 지원 활동에 실질적인 역할을 수행하였고, 이를 통해 사업 진행 과정에서 여성이 주도적으로 참여할 수 있도록 하여 여성의 지역사회 기여 기회를 높임
- VHSG 스스로도 활동하면서 마을의 산모와 아이들의 건강이 향상되었음을 느끼고 있으며 이를 통해 마을에 큰 도움을 주고 있다고 느끼며 마을의 건강에 기여했다고 언급함
- 더불어 KIRI Class 자조 모임(SHG, Self-Help Group)을 통해 서로의 경험과 정보를 공유하며 자발적으로 건강관리 활동에 참여하였고, 이러한 참여는 여성이 단순히 서비스 수혜자가 아닌 지역 보건 개선의 주체자로서 역할을 할 수 있도록 함
- (성평등 의식 신장) 대상 사업의 KIRI Class의 경우 남편과 시어머니도 교육에 참여하도록 설계됨. 특히, 남성(아버지)도 교육하도록 설계된 점이 긍정적임. Father Class 운영을 통해 남성이 아내를 돕는 방법을 배우도록 유도하였으며 교육을 받은 후 남성들이 임신한 배우자를 도와주는 방식이 개선됨. 특히, 출산 후 여성의 신체 회복과 육아 부담 경감을 위한 남성의 역할이 강조됨
- 이를 통해, 임신부의 사업 참여를 직접적으로 방해하는 경우가 확인되지 않았으나, 남성의 경우에는 경제활동을 해야 하는 상황 때문에 사업에 참여할 수 없는 경우가 지속적으로 확인됨. 남성의 교육 참여도 촉진시킬 수 있는 체계 마련이 필요해 보임

제 V 장

결론

1. 평가 결과
2. 작동요인 및 비작동요인
3. 교훈
4. 후속사업 방향 제언
5. 환류과제 및 교훈



제 V 장 결 론

1. 평가 결과

1.1. 수원국 및 대상 지역의 모자보건 문제 원인 해결에 적합한 사업인가?

- ☐ 대상 사업은 공급자 측면에서의 건축 및 의료진 역량 강화를 통한 모자보건 서비스의 질 향상과 더불어 VHSG 및 아웃리치 활동을 포함한 지역사회 중심의 사업수행 결과, 코로나 19로 인한 모자보건 관련 서비스 이용률의 급감에도 불구하고 보건의료서비스에 대한 접근성 및 신뢰도 향상 및 모자보건 관련 인식과 태도, 행태의 근본적인 변화를 가져옴
 - 특히, 백신 예방접종에 대한 지역 내 사회적 기준의 변화로 인해 PNC2~4의 통계적으로 유의미한 서비스 이용률의 변화를 확인할 수 있었음
- ☐ 이를 가능하게 한 요인은 ① 물리적 접근성의 문제를 해결하기 위한 지역사회 중심, 수요자 중심의 사업 수행, ② 사업파트너 간의 신뢰와 협력 구축, ③ 수요에 맞춘 의료진 역량 강화, ④ 기자재 지원과 함께 교육을 제공해 주는 사업자원 제공 방식에 기인한다고 볼 수 있음
- ☐ 그러나, ① 문들끼리 지역 내 사업 수행의 어려움, ② 기자재 관리, 활용 역량의 부족, ③ 언어적, 문화적 장벽으로 인한 의료진 서비스 제공 태도의 불만족 ⑥ 전원 체계의 미흡은 추후 보완해야 할 사항으로 판단됨

2. 작동요인 및 비작동요인

(1) 수요자 측 작동요인

- ☐ (지역사회 중심의 사업수행) VHSG 및 보건소의 아웃리치 활동 등을 통한 교육과 홍보, 모자보건 서비스 제공 등을 통하여 현대적 모자보건 서비스에 대한 인식개선을 이룬 것

이 사업의 핵심적인 작동요인으로 판단됨

- 물리적 접근성의 문제를 해결하기 위해 지역사회 중심, 수요자 중심의 사업 수행을 통해 사업지역 전반에 걸쳐 지역사회의 모자보건 관련 인식과 행태의 기준(social norm)의 변화를 가져온 것으로 볼 수 있음
 - 교육과 홍보가 산모뿐만 아니라 남편, 시어머니 등을 대상으로 산전, 임신, 산후 관리, 백신 접종 등의 건강 인식개선과 행태의 변화를 가속화할 수 있었고 특히, 본 사업을 통해 가정 내 권력관계에 있는 남편, 시어머니 집단의 모자보건에 대한 관심과 이해가 증가한 것을 확인할 수 있었으며 추가적인 교육 등에 대한 요구도 확인됨
- 모자보건 및 건강 증진에 대한 현대적 서비스를 경험하면서 임신과 출산, 질병에 대한 전통적인 신념과 행태를 벗어나 현대적 의료서비스에 대한 신뢰를 갖게 됨
 - 시어머니 집단은 임신부터 출산 후 관리까지 포괄적인 서비스가 제공된 것과 예방접종 서비스 및 건강검진 등에 대한 만족감을 보였으며 대체로 수요자들의 필요 요구를 충족시킴
- 시어머니 집단은 자녀의 위생에 대하여 신경을 더 쓰게 되었고 가정에서 분만을 하던 것에서 병원이나 보건소에서 출산하는 것으로 선호하는 것으로 변화하게 되었음

(2) 공급자 측 작동요인

- (사업파트너 간의 신뢰와 협력) 코로나19로 인한 사업의 지체 및 몬둘끼리주에서의 사업 수행의 미진 등의 어려움 속에서도 단기간 내에 성과를 이룬 것의 가장 근본적인 작동요인은 신뢰에 근거한 코이카-파트너 기관-현지 후보건국-지역사회와의 밀착된 협력 관계임
- KOICA 현지사무소의 관리와 협조, 사업 수행주체의 사업지역 내 모자보건 개선에 대한 사명감과 애정, 후보건국 직원들의 협조적 태도를 바탕으로 신뢰와 협력이라는 사회적 자본을 구축한 것이 사업의 효과성과 효율성을 높이는 결정적인 요인으로 판단됨
- (의료진 역량 강화) 교육 및 시설 지원을 통해 의료 서비스 제공 능력이 향상되었음을 강조함. 특히 교육수요가 반영된 역량강화 사업에 대해서 전반적으로 높게 평가하고 있었음
- (사업의 자원 제공방식) JICA, GAVI와 UNICEF 등이 건축, 백신 현물 등 일부분을 단편적으로 지원해주는 것에 비해 KOICA 사업의 특징은 기자재 지원과 함께 교육을 제공해 주는 것이 사업의 효과성과 효율성을 높인 것으로 평가할 수 있음

(3) 수요자 측 비작동요인

- ☐ (언어적, 문화적 장벽으로 인한 의료진 서비스 제공 태도의 불만족) 일부의 경우, 언어적, 문화적 장벽이 상대적으로 큰 소수민족일수록 치료진의 비우호적인 태도와 지지로 인해 서비스 만족도 및 서비스 이용률이 떨어지는 모습을 볼 수 있음
- ☐ 주립병원 등 공급자 입장에서는 문화적, 언어적 장벽이 있는 소수민족에 대한 서비스 제공이 큰 부담인 것으로 확인되기 때문에 필요시 VHSG의 동행 지원 등을 고려해 볼 수 있을 것임
- ☐ (전원체계 추가 강화 필요) 구급차 공급 등으로 보건소-주립병원 간의 전원체계가 획기적으로 강화되었으나 여전히 원거리 마을에서 보건소까지의 접근성 문제는 여전히 개선이 필요한 것으로 파악됨

(4) 공급자 측 비작동요인

- ☐ (현지 리더십의 비협조) 문들끼리 주 대상의 사업의 경우 주보건국의 리더십 문제로 계획대로의 사업 진행이 불가능하게 되면서 일부 공급자에 대한 교육과 기자재 지원만 제한적으로 이뤄짐
- ☐ (기자재 관리, 활용 역량의 부족) 건축 및 기자재 제공으로 인하여 모자보건 서비스의 질 향상 및 만족도를 향상시켰으나, 일부 기자재의 경우 활용 인력의 역량 부족 또는 관리 부실 등으로 사용되지 않은 사례도 발견할 수 있었음

(5) 작동 및 비작동 요인 분석 결과

- ☐ VHSG 및 아웃리치 활동이 지역사회 인식 및 행태 변화에 결정적이며 주인의식을 기반으로 한 자율적 활동이 지속되고 있음. 따라서 후속 사업에서도 VHSG 주도 지역사회 보건 인식 개선을 지속할 수 있도록 주보건국-보건소를 통한 VHSG 역량 강화를 지원할 필요가 있음
- ☐ (의료서비스 제공에 있어서의 언어적, 문화적 장벽 해소) 다양한 언어로 된 교육 자료 제공이 강화될 필요가 있으며 소수민족 비율이 높은 지역의 경우, 소수민족 언어 사용이 가능한 VSHG를 채용하여 의료서비스로의 접근성과 만족도를 높이는 방안이 필요함
- ☐ (기자재 추가지원 및 관리와 활용을 위한 역량 강화) 기증한 시설, 장비 운용 등은 전반

적인 활용 수준은 양호하나, 일부 관리부실 및 미활용 사례가 보고됨. 현장 수요에 기초한 추가적인 기자재 지원 및 장비 관리 및 활용을 위한 추가적인 역량 강화 기회 마련이 요구됨

3. 교훈

- (보건의료체계 내의 서비스 전달의 연속성 고려) 사업요소에 있어서 의료시설-지역사회, 공급자-수요자, 치료-예방을 고려한 보건의료체계 내에서 서비스의 연속성을 동시에 확보해야 산출물(output) 단위가 아닌 성과(outcome) 단위에서의 의미 있는 변화를 가져올 수 있음
- 따라서, 사업 기획에 있어서 보건의료체계 내의 서비스 전달의 연속성을 고려해야 하며, 아울러 사업수행 주체 선정 시 지역사회 전문기관과 의료 분야 전문기관 간의 공동 사업수행 주체 선정을 긍정적으로 검토할 필요가 있음
- (사업 파트너의 수용성 판단) 몬둘끼리 주보건국과의 리더십 문제가 지속될 것으로 예상되기 때문에 후속사업은 라따나끼리주에 국한하여 진행하는 것이 바람직하다고 판단됨
- 중저개발국 대상의 사업에서 의사결정자의 교체 또는 변심 등으로 사업 진행에 차질을 빚는 것은 드문 일이 아님을 감안할 때 이에 대한 현장 중심의 정치적 변동 가능성 및 주요 인물의 성향 등을 체계적으로 진단, 예측하고 대안 등을 추가로 마련할 필요가 있음
- (기자재의 관리 부실 및 미활용 사례) 효율성 있고 지속가능성 있는 기자재의 활용을 위해서는 수요에 따른 기자재 및 소모품 지원-운용 가이드라인-모니터링 체계-운용담당자의 역량이 모두 갖추어질 필요가 있음

4. 후속사업 방향 제언

- (후속사업 방향의 적절성) 라따나끼리주에서 수행될 예정인 “포괄적 공공 보건의료체계 역량강화사업”의 경우, 대상 사업의 한계점인 의료체계 강화를 목표로 추진되는 것은 매우 적절하다고 판단됨
- 다만, 대상 사업과의 연계성과 지속성을 확보해야 의료체계의 강화 또한 성과를 예상할 수 있기 때문에 기존 사업의 성과를 지속시키고 사업 요소를 고도화하는 것을 핵심적인 사업 요소로 포함시킬 필요가 있음

- (의료체계 강화를 위한 사업 요소 제안) 후속 사업을 통해 ① 전원체계 수립 및 의료시설 내 감염 예방, ② 외과수술을 위한 혈액 관리와 마취 분야 의료진 역량 고도화, ③ 부인과 질환 진단 및 치료, ④ 장비 및 기자재 관리 및 운용 역량 강화 ⑤ 문화적·민족적 특성을 고려한 서비스 제공 등에 우선순위를 두고 추진할 필요가 있음
 - 효율성과 지속가능성을 고려하여 본 종료평가를 통해 제안된 환류 과제를 포함하는 동시에 후속 사업을 통해 전반적인 의료서비스의 질을 향상 시킬 수 있는 분야를 우선적으로 고려함
 - 기존의 교육 수요를 반영한 의료진 역량 강화 사업의 효과를 바탕으로 교육받은 인력에 대해서 심화된 역량강화 사업이 연계될 필요가 있음
 - 성병, 임신합병증 등 부인과적 질환 진단 및 치료에 대한 지원이 이뤄진다면 현재 H-EQIP 사업에서 추진 중인 만성질환 대상 중 자궁경부암 예방 및 치료 등에 추가적인 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단됨
 - 혈액 관리와 마취 분야 등에서 의료진의 역량 강화와 더불어 기자재 등의 지원을 통해 모자보건 뿐만 아니라 병원 전체의 역량 강화를 꾀할 수 있을 것임
- (건축 등의 요소 적정 배분 필요) 병원 건축 등의 사업 요소는 지역 내 최상위 의료기관으로써 의료 품질 향상에 필수적인 부분 위주로 고려될 필요가 있는 반면, 전원체계 강화 및 병원 내 감염 예방, 의료진 수급 및 역량 강화 등에 보다 중점을 두고 추진할 필요가 있음

5. 환류과제 및 교훈

(1) 환류 과제

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	후속사업/사후지원 관련 환류과제(안) (필요성/조치사항 위주)	환류과제 이행부서	선정 사유 (이행시 기대효과/미이행시 파급효과)	유관부서 의견 반영 사항 (기존 계획과의 상충관계, 예상되는 위험요인 등)
VHSG 및 아웃리치 활동이 지역사회의 인식 및 행태 변화에 결정적이며 주인의식을 기반으로 한 자율적 활동이 지속되고 있음	후속사업에서도 VHSG 주도 지역사회 보건인식 개선을 지속할 수 있도록 주보건국-보건소를 통한 VHSG 역량강화를 지원할 것		- 역량 있는 VHSG의 탈락 및 역량 저하 방지 - 주보건국의 오너십 및 리더십 강화 - 사업의 효율성 및 지속가능성 확보	
일부 소수민족의 경우, 의료서비스 이용에 있어서 언어적, 문화적 장벽으로 인한 해소불만족을 경험	VHSG 선발시 지역 내 소수민족의 비율을 고려하여 선발		- 의료서비스 만족도 향상 - 소수민족주류화 - 건강형평성 추가 개선	
일부 기자재의 관리부실 및 미활용 사례	현장 수요에 기초한 추가적인 기자재 지원 및 장비 관리 및 활용을 위한 추가적인 역량 강화 기회 마련이 요구됨		사업 효과의 지속성 및 효율성 증대	

(2) 교훈

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	평가 교훈 분석			
	분야/일반 구분	이전년도 교훈 중복 여부	교훈 내용	M&E 체크리스트 질문
객관적 의료서비스 이용 관련 outcome 지표의 목표 미달성	분야		1. 사업 기획 시, 의료시설-지역사회, 공급자-수 요자, 치료-예방을 고려한 보건의료서비스의 연속성을 고려한 사업요소 설계 및 필요시 컨 소사업 형태의 사업수행 기관 선정	1. 사업 기획 시, 의료시설-지역사회, 공급자-수 요자, 치료-예방을 고려한 보건의료서비스의 연속성을 고려하여 사업요소가 설계되었는 가?
파트너국가(지역) 주요 의사결정자의 신뢰관계 구축 또는 비협조	일반		1. 심층기획 조사시, 파트너국 또는 지역 주요의 사결정자별로 대한 협력의지에 대한 진단, 인 적 변동 등의 가능성 등 협력관계 구축에 우려 될 만한 내용을 파악하고 대안을 구체적으로 고려할 필요가 있음 2. 사업수행 중에도 주요의사결정자들과의 협력 및 신뢰관계를 주기적으로 점검하고 개선사항 을 반영하여 신뢰자본을 구축해 갈 필요가 있 음	1. 심층기획 조사시, 협력관계를 위한 주요의사 결정자들을 파악하고 협력의지를 진단하였는 가? 2. 심층기획 조사시, 주요의사결정자들의 교체 가능성 등 협력관계의 인적 변동을 예측하고 대안을 제시하였는가? 3. 사업 수행 중 주요의사결정자들과의 협력 및 신뢰관계를 주기적으로 점검하고 개선사항 을 도출하고 반영하였는가?
기자재의 관리부실 및 미활용 사례	일반		1. 기자재 및 소모품 지원-운용 가이드라인-모니 터링 체계-운용담당자의 역량이 모두 갖추어 질 필요가 있음	1. 기자재 발주 전 기자재 운용담당자 지정, 운 용 가이드라인 및 모니터링 체계 마련, 담당 자의 관리 및 충분한 활용역량 여부를 점검 하였는가? 또는 이를 지원할 계획이 있는가?

첨부

1. 현지(원격)조사 개요(출장자·출장일정·출장지)
2. 일별활동내역
(주요 협의내용 및 평가활동 정리 서술)
3. 평가단계별 세부 계획
4. 면담자 목록 및 주요 면담 질문
5. 설문조사지 및 설문조사 결과
6. 참고문헌
7. 건축, 기자재, 소모품 점검 결과
(라따나끼리 주 국한)
8. 준실험적 방법을 적용한 통계 분석
: 라따나끼리 행정데이터 분석
9. 세부 평가매트릭스

첨부 1 현지(원격)조사 개요(출장자·출장일정·출장지)

1. 예비 현장조사 개요

가. 조사국가/지역 : 캄보디아 몬둘끼리주, 라타나끼리주

나. 조사기간 : 2024.06.01.(토) ~ 2024.06.06.(목)

다. 조사목적 : 종료평가를 위한 예비 현장검증 및 추후 종료평가를 위한 사전 현지조사

라. 조사인원 : 총 6명

연번	구분	성명	소속
1	평가전문가	허종호	서울대학교 의과대학 휴먼시스템의학
2	인솔자 (평가보조원)	김윤진	이종육글로벌의학센터
3	수강생 (평가보조원)	이석희	서울대학교 간호대학 간호학과
4		오세욱	서울대학교 보건대학원 보건학과
5		이운영	서울대학교 보건대학원 보건학과
6		박선우	서울대학교 사회과학대학 정치외교학부

□ 활동 상세내용

- 기존 캄보디아 모자보건 사업을 알기위한 현지조사 진행
- 주 사업지인 몬둘끼리주, 나타나끼리주 방문하여 지역 보건소 조사
 - － 기존 사업에서 모자보건센터 지은 병원 및 보건소 위주로 조사
 - － 지역 보건소 및 병원 현황 파악 및 기존 사업에 관한 조사 및 인터뷰 진행
- 그 외 주변지역 중 대조군으로 끄라체 방문하여 현지 현황 파악
- 현지 KOICA 본부 방문 및 활동 관련 논의 진행

□ 활동 상세내용

일시	내용
2024.06.01.(토)	18:40 인천 출발 ~ 22:10 프놈펜 도착 후 숙소이동
2024.06.02.(일)	현지 이동(8-10시간) 후 내부 회의
2024.06.03.(월)	Day1. 현지 조사 진행(지역 보건소 및 병원 방문) *오전 : 라타나끼리 주립병원, 라타나끼리 오츨 보건소 *오후 : 안동미아 보건소

2024.06.04.(화)	Day2. 현지 조사 진행(지역 보건소 및 병원 방문, 보건국 미팅 진행) *오전 : 콘뎀 보건소 (보건소 방문, 아웃리치 활동 확인) *오후 : 주보건국, MCH팀 미팅 (OD (2팀))
2024.06.05.(수)	새벽 프놈펜으로 출발(8-10시간) *오전 : 끄라체 주보건국 미팅 및 주립병원 방문(사업지 대조군) *오후 : 코이카 캄보디아 사무소 방문 공항으로 이동 후 23:40 프놈펜 출발
2024.06.06.(목)	~07:00 인천 도착

2. 종료평가 현장조사 개요

가. 조사국가/지역 : 캄보디아 몬둘끼리주, 라타나끼리주

나. 조사기간 : 2025.01.18.(토) ~ 2025.01.24.(금)

다. 조사목적 : 예비 현장조사 및 국내 조사 내용 바탕으로 실제 종료평가 진행

라. 조사인원 : 총 20명

연번	구분	성명	소속
1	평가전문가	허종호	서울대학교 의과대학 휴먼시스템의학
2	인솔자(평가보조원)	김윤진	이중욱글로벌의학센터
3	수강생(평가보조원)	이석희	서울대학교 간호대학 간호학과
4		오세욱	서울대학교 보건대학원 보건학과
5		이운영	서울대학교 보건대학원 보건학과
6		박선우	서울대학교 사회과학대학 정치외교학부
7		정다은	서울대학교 휴먼시스템의학과
8		하나영	서울대학교 보건학과
9		김소예	서울대학교 식품영양학과
10		윤예진	서울대학교 보건학과
11		김지영	서울대학교 휴먼시스템의학과
12		이민찬	서울대학교 보건학과
13		오홍상	서울대학교 휴먼시스템의학과
14		김지민	서울대학교 보건학과
15		신채린	서울대학교 보건학과
16		이호연	서울대학교 휴먼시스템의학과
17		김수희	서울대학교 휴먼시스템의학과
18		김민	서울대학교 휴먼시스템의학과

□ 활동 상세내용

- 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램에 대한 종료평가를 수행하여 사업 과정 및 성과 목표 달성 확인, 이를 통해, 평가 대상 사업의 산출물 및 성과를 종합 분석해 향후 지역사회 기반 모자보건 사업 추진을 위한 교육 도출, 제언
- 활동
 - 2인 1조로 활동하고 1개조 당 통역 1-2인 함께 진행 예정
 - 질적팀과 양적팀으로 구분하여 라따나끼리 내에서 설문 조사 및 인터뷰 진행할 예정
- 현실적인 제약으로 실사 기간 내에는 라따나끼리 및 몬둘끼리 지역 모두 설문 불가한 상황으로, 몬둘끼리 설문은 50명 안팎 수혜 대상으로 현지 컨설팅업체 통하여 진행할 예정
 - 컨설팅 활용 방안 (현지 실사 참여 및 사전·사후 조사 진행)
 - (1) 설문지, 인터뷰지 사전 검토 및 크메르어 번역 (설문지 사전 테스트 진행)
 - (2) 현지 실사 참여하여 데이터 수집, 분석 참여 및 보조
 - (3) 실사 기간 중, 그 이후 포함하여 몬둘끼리 지역 내 50명 안팎 수혜 대상 설문 진행
- 현지 KOICA 본부 방문 및 활동 관련 논의 진행

□ 활동 세부 일정

일시	방문지역	시간	내용	
			양적연구팀	질적연구팀
2025. 1.18.(토)	인천- 프놈펜	-	18:40 인천 출발 ~ 22:10 프놈펜 도착 및 숙소이동	
2025. 1.19.(일)	프놈펜- 라따나끼리	08:30~ 18:30	- 현지 이동(10시간) 이동 중 간단히 사업 목표, 일정과 평가내용 브리핑 및 논의	
		18:30~	- 출장 오리엔테이션: 캄보디아 보건의료체계 브리핑, 통역사 미팅, 라따나끼리 평가계획 논의 및 점검, 우발 상황 대비 점검 일정 검토 및 이동 수단 등 세부 일정 논의	
2025. 1.20.(월)~1 .21.(화)	라따나끼리, 몬둘끼리 (팀마다 개별 이동)	09:00~ 11:00	지역 보건소 방문 후 설문 대상 마을로 이동	임산부/어머니 1그룹, 보건인력 1명, 1명 시어머니 1그룹, 1명
		13:00~ 15:00	산모 대상 설문 진행	임산부/어머니 1그룹, 남편 1그룹, 보건인력 2명
		15:00~ 17:00		임산부/어머니 1그룹, 의료시설 기자재 관리 검토 주보건부 2명
		18:00~	각 팀별 당일 조사 결과 브리핑 및 코딩 작업 진행	
2025.		09:00~	지역 보건소 방문 후 설문 대상	임산부/어머니 1그룹,

1.22.(수)		11:00	마을로 이동	보건인력 1명, 1명 시어머니 1그룹, 1명
		13:00~ 15:00	산모 대상 설문 진행	임산부/어머니 1그룹, 남편 1그룹, 보건인력 2명
		15:00~ 17:00		임산부/어머니 1그룹, 의료시설 기자재 관리 검토 주보건부 2명
		18:00~	당일 조사 결과 브리핑 및 코딩 작업 진행, 평가 정리 및 총평	
2025. 1.23.(목)	라따나끼리- 프놈펜	06:00~ 16:00	프놈펜으로 출발(10시간)	
		16:00~ 18:00	코이카 캄보디아 사무소 출장 결과 공유	
		18:00~	공항으로 이동 후 23:40 프놈펜 출발	
2025. 1.24.(금)	인천	-	~07:00 인천 도착	

□ 활동 참여 인원 세부사항

○ 양적팀

양적팀	성명	역할
1조	정다은	양적 조사 설문 진행 및 취합
	하나영	조사 진행 보조 및 설문 자료 코딩&분석
2조	오세옥	양적 조사 설문 진행 및 취합
	이운영	조사 진행 보조 및 설문 자료 코딩&분석
3조	김소예	양적 조사 설문 진행 및 취합 (소수민족 대상)
	윤예진	조사 진행 보조 및 설문 자료 코딩&분석 (소수민족 대상)

○ 질적팀

질적팀	성명	역할
1조	김지영	질적조사 인터뷰 진행(임산부 및 5세 미만 아동의 어머니)
	이민찬	질적조사 인터뷰 이후 코딩 및 분석 진행
2조	오홍상	질적조사 인터뷰 진행(남편/시어머니) 의료시설 및 기자재 관리 실태 평가 진행
	김지민	질적조사 인터뷰 이후 코딩 및 분석 진행
3조	신채린	질적조사 인터뷰 진행(주보건부/보건인력/마을보건요원)
	이석희	조사 진행 보조 및 내용 취합, 코딩 및 분석 진행
4조	박선우	질적조사 인터뷰 진행(임산부 및 5세 미만 아동의 어머니)
	이호연	조사 진행 보조 및 내용 취합, 코딩 및 분석 진행 의료시설 및 기자재 관리 실태 평가 진행
5조	김수희	질적조사 인터뷰 진행(소수민족 대상)
	김민	질적조사 인터뷰 이후 코딩 및 분석 진행(소수민족 대상)

첨부 2 일별활동내역(주요 협의내용 및 평가활동 정리 서술)

1. 예비 현장조사 일별 활동 내역(6.1~6.6)

□ 활동 세부일정

일시	방문 지역	시간	내용
2024. 06.01.(토)	인천- 프놈펜	-	18:40 인천 출발 ~ 22:10 프놈펜 도착 후 숙소이동
2024. 06.02.(일)	프놈펜- 라타나끼리	08:30~ 18:30	현지 이동(8-10시간) 후 내부 회의
2024. 06.03.(월)	라타나끼리	09:00~ 11:30	라타나끼리 주립병원, 오츄 보건소 방문하여 현지 현황 파악
		13:00~ 17:00	안동미아 보건소 방문하여 현지 현황 파악, 의료진 인터뷰 진행
2024. 06.04.(화)		09:00~ 11:30	콘몸 보건소 방문하여 현지 현황 파악, 의료 기자재 점검, 마을로 이동하여 아웃리치 활동 확인
		13:00~ 17:00	주보건국, MCH팀 미팅 (OD (2팀))
2024. 06.05.(수)	라타나끼리- 끄라체, 프놈펜	09:00~ 11:30	새벽 프놈펜으로 출발(8-10시간) 끄라체 주보건국 미팅 및 주립병원 방문(사업지 대조군)
		13:00~ 17:00	코이카 캄보디아 사무소 방문 공항으로 이동 후 23:40 프놈펜 출발
2024. 06.06.(목)	인천	-	~07:00 인천 도착

□ 일별 주요 협의 내용

1. 6월 3일(월)

1-1. 라타나끼리 주립병원 방문 및 응급차 확인

- 병원 시설 확인 후 의료 환경 확인, 의료진 인터뷰
- 응급차 시설 확인 및 이용 현황 조사

1-2. 오츄보건소 방문

- 신축 모자보건센터 확인 및 의료진 인터뷰 진행

1-3. 안동미아 보건소 방문

- 오춤 보건소와 동일한 구성의 신축 모자보건센터 확인
- 응급차 2대 시설 확인

2. 6월 4일(화)

2-1. 콘몸 보건소

- 응급차 점검 및 보건소 현황 파악

2-2. 콘몸 지역 방문

- 콘몸 지역 아웃리치 활동 참여 및 인터뷰 진행(활동 기간, 규모 등)
- 아웃리치 활동하면서 쓰이는약품, 검사 등 확인

2-3. 현지 보건국 미팅

- 현지 보건 현황 관련 인터뷰 진행
- 보건 사업 관련 프로그램 현황 여부 파악

3. 6월 5일(수)

3-1. 프라체 주보건국 미팅

- 평가 조사 준비에 앞서 대조군으로 활용 가능할지 조사차 방문
- 프라체 지역 보건 현황 파악

3-2. 프라체 주립병원 방문

- 병원 시설 및 응급차 등 현황 파악

2. 종료평가 조사 일별 활동 내역

□ 활동 세부 일정

○ 일별 주요 협의 내용(조사1일차)

시간 / 팀구성	양적조사팀(설문조사)			질적조사팀(인터뷰)					몬돌끼리						
	O chum / sameakki / Andon mea		Ka choun / phum kok	O chum HC / Andong meas				Ka choun HC	Ka choun / Andong meas						
	1조	2조	3조 (소수민족 조)	1조	2조	3조	4조	5조 (소수민족 조)	지도교수/ 컨설팅팀 리더						
08:30~09:00	O chum 이동 및 설문 시작	O chum 이동 및 설문 시작	Ka choun 이동	O chum 보건소이동 및 컨택				Ka choun 이동	Ka choun 이동						
09:00~09:30	O chum 설문	O chum 설문		시어머니 인터뷰	의료진 인터뷰	PHD 인터뷰	시어머니 인터뷰								
09:30~10:30			Ka choun 설문					임산부, 어머니 인터뷰	소수민족 설문조사/ 인터뷰 모니터링						
10:30~11:00	sameakki 이동 및 설문	sameakki 이동 및 설문													
13:00~13:30	sameakki 설문	sameakki 설문	Ka choun 설문	Andong meas 이동					Andong meas 이동						
13:30~14:00			phnum kok 이동	남편	의료진	PHD	VHSGs	임산부, 어머니	소수민족 설문조사/ 인터뷰 모니터링						
14:00~14:30															
14:30~15:00	Andong meas 이동 및 설문 시작	Andong meas 이동 및 설문 시작	phnum kok 설문												
15:00~16:30	Andong meas 설문	Andong meas 설문													
16:30~18:30	복귀 및 저녁식사														
18:30~21:30	팀별 자료 정리 후 조별 브리핑하여 내용 공유&정리														

○ 일별 주요 협의 내용(조사 2일차)

시간 / 팀구성	양적조사팀(설문조사)			질적조사팀(인터뷰)					모니터링 / 몬돌끼리				
	teun / kaun mom		Lumphat / Sre Ankrong	Koun mom HC				Lumphat HC	Kaoh Nheaek / Mondulkiri				
	1조	3조	2조	1조	2조	3조	4조	5조	지도교수/컨설팅팀 리더				
08:30~09:00	teun 이동	teun 이동	Lumphat 이동	koun mom 보건소 이동				Lumphat 이동	Kaoh Nheaek 이동(07:30출발)				
09:00~09:30	teun 설문	teun 설문		Lumphat 설문	임산부, 어머니	의료진	PHD		남편	시어머니	Kaoh Nheaek Referral Hospital 방문 모자보건센터 및 구급차 확인, 병원장 등 인터뷰		
09:30~10:30													
10:30~11:00													
13:00~13:30	kaun mom 이동	kaun mom 이동	Lumphat 설문	임산부, 어머니	의료진	PHD	VHSGs	남편	Lumphat 면담 모니터링				
13:30~14:00													
14:00~14:30	Sre Ankrong 이동												
14:30~15:00	Sre Ankrong 설문												
15:00~15:30													
15:30~16:30		복귀	복귀										
16:30~18:30	복귀 및 저녁식사												
18:30~21:30	팀별 자료 정리 후 조별 브리핑하여 내용 공유&정리												

○ 일별 주요 협의 내용(조사 3일차)

시간 / 팀구성	양적조사팀(설문조사)			질적조사팀(인터뷰)				모니터링 / 문돌끼리
	Kachanh / bar kaev / O yadav		Taveng	Kachanh HC			Taveng HC	Mondulkiri
	1조	3조	2조 (소수민족조)	1조	2조	3조	4조 (소수민족조)	지도교수/컨설팅팀 리더
08:30~09:00	kachanh 이동	kachanh 이동	taveng 이동	kachanh 이동			taveng 이동	문돌끼리 설문조사 모니터링
09:00~09:30	kachanh 이동 및 설문 시작	kachanh 이동 및 설문 시작		시어머니	의료진	OD		
09:30~10:00	kachanh 설문	kachanh 설문	taveng 설문					
10:00~10:30								
10:30~11:00								
13:00~13:30	bar kaev 이동	O yadav 이동	taveng 설문	임산부, 엄마	의료진	OD	남편	Department of Health of Ratanakiri 인터뷰
13:30~14:00	bar kaev 설문	O yadav 설문						
14:00~14:30								
14:30~15:00								
16:30~18:30	복귀 및 저녁식사							
18:30~21:30	팀별 자료 정리 후 조별 브리핑하여 내용 공유 & 정리							

1. 1단계 기초조사

(1) 문헌조사

- 사업 관련 자료(사업계획서, 연차보고서, 이행결과보고서, 기초선 및 종료선조사 결과보고서 등)를 분석하고 결과보고서 등을 참고하여 사업 전반에 대한 이해도를 높이고, 평가의 범위를 명확히 설정하여 평가항목 및 평가지표를 정교화함
- 국내외 유사 사업 관련 문헌과 정책 자료, 통계 자료 및 유사 사업의 평가 논문 등에 대한 기초 문헌조사를 실시하여 유사사례를 분석하고 국내외 모자보건 분야 ODA의 현황, 정책 방향, 트렌드를 파악하여 종합적 분석을 위한 기초조사를 진행함
- 관련 논문의 사례의 예는 아래와 같음

저자	연도	국가	사업명 및 연구 주제	사업 및 연구 성과	제언 사항
Yanagisawa et al.	2014	캄보디아	산모와 모자보건 관련 정보를 담은 핸드북("maternal and child health handbook(MCHH)")을 활용한 산모 지식 및 행동 개선 연구	MCHH의 활용이 산모들의 건강 관련 지식과 행동의 개선을 야기함.	• MCHH의 보급 확대와 이해를 돕기 위한 교육 프로그램 필요 • 농촌 지역을 대상으로 한 접근성 강화와 문화적 배경 고려한 맞춤형 보건 서비스 설계 • 지역 사회 보건 인력의 적극적 참여와 지원 체계 강화 필요
강용규	2020	캄보디아	수원마을 조성사업	사회적으로 학교 건축 등을 통한 교실수, 학생수 증가가 나타남.	• 장기적인 성과를 위해서는 ODA 전담인력의 확보 • 수요에 따른 상품의 개발 • 지역주민의 조직화, 인프라 확충이 필요
Suzuki et al.	2021	캄보디아	보호자(caregiver)의 관점에서 신생아의 사망 원인 탐구	건강 관리 전문가의 부재 의뢰체계(referral system)에서의 장애, 지식과 기술의 부재가 주요 원인으로 밝혀짐.	• 산전 관리 서비스 강화 및 의료 서비스 접근성 개선 • 지역 사회의 의료 교육 확대 및 전통적 신념과의 조화로운 접근 필요 • 경제적 부담 완화를 위한 보건 정책 지원 • 응급 의료 체계 개선 등이 필요

Chham et al.	2021	캄보디아	Cambodia Demographic and Health Survey(CDHS) 데이터를 활용한 캄보디아 산모 건강관리 연속성의 결정 요인 분석	산모 건강 관리 연속성(산전 관리, 출산, 산후 관리)에 영향을 미치는 주요 요인으로 교육 수준, 경제적 상태, 지역(도시/농촌), 의료 서비스 접근성 등이 확인됨.	• 소득과 건강 보험 적용 범위의 확대 • 여성의 교육 확대와 가정 내 의사결정에서 자율성 강화 조치가 필요
--------------	------	------	--	--	---

□ 코이카에서 시행한 주요 모자보건 사업에 대한 평가의 예는 아래와 같음

사업명	사업연도	사업국가 및 지역	사업목적	평가 내용	주요 제언사항
파라과이 산빠블로 모자병원 역량강화 사업	2013-2019 (7년)	파라과이 아순시온시	고위험 환자 후송병원 및 전문인력 교육 병원의 역할을 수행하도록 지원함으로써 의료서비스 개선, 지역 보건의료 시스템 확립	• 성공요인: 수원국의 주인의식, 높은 사업 의지, 병원장의 역량 및 리더십, 이해관계자 간의 의사소통 • 개선요인: 사업 기간이 짧게 계획됨	• 지역사업 연계 방안 구축: 수원국의 적극적인 의지와 지속적인 협업을 바탕으로 후속사업 및 타지역 확산이 이루어지도록 성과를 연계해나가는 방안 필요 • 사업운영관리: 통합적 성과관리와 일괄적인 사업수행을 위해 PMC 활용 및 지역 CM(Construction Management, 건설사업관리)에 의한 일정 관리 등이 보완될 필요 있음
탄자니아 차니카 모자보건 서비스 개선사업	2014-2019 (6년)	탄자니아 다레살람 일탈라구 차니카	탄자니아 다레살람 일탈라구 차니카 및 주변 지역의 산모 및 신생아 보건의료 수준 향상, 수혜자 증대, 기초진단을 통한 질병 예방에 기여	• 성공요인: 모자보건 개선을 위한 종합적 지원 체계 마련, 높은 수원국 주인의식 • 개선요인: PIU(Project Implementation Unit, 사업수행 운영체) 운영 및 일정 관리 미흡, ICU 인력 미확보, 수혈체계 사업수행 결여, 병원운영 관련 지원 미흡, 일부 시설관리 필요	• 우수사업 모델화: 수원국의 적극적 의지와 지속적인 협업을 바탕으로 후속사업 및 타지역 확산이 이루어지도록 성과를 연계해나가는 방안 필요 • 사업설계 및 운영관리: 통합적 성과관리와 일괄적인 사업수행을 위해 PMC 활용 및 지역 CM에 의한 일정 관리 등이 보완될 필요 있음 • 사후관리: 기차재 및 시설보수, 탄력적인 병동운영, 의료진 재교육, 지역사회 교육 보완이 이루어질 필요 있음

필리핀 WHO 다바오 지역보건 체계강화 모자보건 사업	2015- 2018 (4년)	필리핀 다바오 지역 4개 주 10개 시	다바오 지역 보건의료체계 강화, 모자보건 관련 보건의료 형평성 및 서비스 접근성 제고	- 성공요인: 지역보건체계 강화와 모자보건 프로그램의 유기적 작동, 자국 보건 체계를 근간으로 하여 이해관계자들의 적극적 참여 도출 - 개선요인: 역량 있는 보건인력의 원활한 수급과 활동 뒷받침이 필요함	- 기초선, 중간선, 종료선 연구조사 활동을 포함할 것 - 사업지역 내 보건인력의 지속적 확보 및 보수교육 방안을 고안할 것 - 인식개선 활동에 대한 주요 이해관계자 확대 및 대상별 보건 커뮤니케이션 전략을 마련할 것 - 사업보고 시 변경 PDM과 모니터링 프레임워크, 수혜자 수 공유를 통한 성과관리를 실시할 것
과테말라 웨웨페낭고 주 국립병원 모자보건 역량강화 사업	2011- 2018 (8년)	과테말라 웨웨페낭고 주	웨웨페낭고주 국립병원 모자보건 의료시설 확충 및 개선, 해당 지역 모자보건 지표 개선	- 계획 수립 시 인프라 부족, 업체 도산 등의 위험요소에 대한 기술적 관리 필요 - 인프라 사업의 경우 현지 상황 및 법규에 영향을 많이 받으므로 현지 전문가 및 업체를 활용할 것 - 해당 지역과 같이 보건의료 시스템의 분절화 및 인사이동, 제도변화가 잦은 지역은 다자기구를 활용한 사업 추진 시 성과가 높을 것으로 예상함 - 모자보건센터의 하자보수 및 지속적인 유지관리가 필요함	

(2) 이해관계자 및 면담 대상자 파악

- ☐ 평가 대상 사업의 의사결정자 및 사업수행자, 수혜자 등 이해관계자를 파악함
- ☐ 문헌조사에서 파악한 내용에 대한 교차 검증 및 문헌에서 파악할 수 없는 내용 확인을 위한 사전 면담조사 대상을 선정함

수원국 측	한국 측
■ 수원기관: 캄보디아 라따나끼리 주정부, 문둘끼리 주정부 ■ 사업수행기관: 주 보건국 및 산하 기관 ■ 수혜자: 주민(임산부 및 모자), 의료인력 ■ 기타 이해관계자: 남편, 시부모	■ 관리감독: KOICA 캄보디아 사무소 ■ 사업기획관리(PM): 굿네이버스 / 순천향대학교 산학협력단 ■ 사업수행기관(PC): 굿네이버스 / 순천향대학교 산학협력단

2. 현지조사 방법 및 계획 (2단계 과정평가, 3단계 성과평가)

(1) 2단계 과정평가

□ 문헌조사

- 기초조사에서 파악된 캄보디아 전략문서 및 통계자료를 비롯하여 추가로 수집된 문헌 자료를 기반으로 중앙부처 및 지역정부의 개발목표와 정책을 파악하여 평가대상 사업의 적절성과 일관성 등에 대한 평가 기준을 설정함
- 사전조사 및 정기조사 자료 등 각 사업 수행기관에서 사업의 수행기간 동안 사업 품질관리 및 평가를 위해 수집한 통계 자료, 면담 자료, 설문 자료 등에 대한 분석을 진행함
- 양적 설문조사 설문지 설계 참고자료로 본 사업의 기초선, 중간선, 종료선 평가에서 수행한 설문 문항 및 유사 사업 설문지 등을 참고함
- 질적 인터뷰 질문지 설계 참고 자료로 KOICA의 보건의료 분야 종료평가 결과보고서 중에서 질적연구 질문이 자세히 소개된 다음의 경우를 참고함
 - 탄자니아 차니카 모자보건 서비스 개선사업(2014-2019/425만불) 종료평가 결과보고서
 - 에티오피아 아르시 내게레 지역 7개 마을 식수 및 위생환경 개선을 통한 수인성 질환 감소 사업(2020-2022/1,698백만원) 종료평가 결과보고서
 - WHO 항생제 내성(AMR) 감염병 대응을 위한 국가대응능력 향상사업 등 신규('17-'23/975만불) 종료평가 결과보고서

□ 면담조사

- 문헌조사에서 파악한 내용에 대한 교차 검증 및 문헌에서 파악할 수 없는 내용 확인을 위한 이해관계자들에 대한 사전 면담을 국내외에서 진행함

(2) 3단계 성과평가

□ 준실험적 방법을 적용한 통계 분석: 라따나끼리 행정 데이터 분석

- (목적) 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근 개선과 관련된 성과지표에 대해서 사업이 시행된 기간(2019~2022년) 전후의 시간에 따른 변화를 정량적으로 분석하여 엄밀한 사업의 효과성을 검증함
- (평가 성과지표) 구체적인 성과지표는 PDM 성과 달성도를 기반으로 미달성 항목에 해당하는 ① 의료전문가에 의한 분만비율, ② 산후 48시간 이내 산후관리 받은 비율, ③ 4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율에 대해서 평가함

성과목표	SDGs 세부목표 및 영향지표	프로그램 성과지표	기초선 (2021)	중간선 (2022)	종료선 (2023)	목표치	달성도
사업지역의 모성, 신생아 보건의료 서비스의 질이 향상된다.	산모사망률 감소	모자보건 서비스 미충족 욕구	20.7%	1.2%	0.2%	10.7%	198.1% ⁸⁾
		서비스 만족도	36.5%	91.1%	97.1%	51.5%	188.5%
소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근성이 개선된다.		전문가에 의한 분만비율	77.4%	77.9%	82.1%	87.4%	93.9%
		산후 48시간 이내 산후관리 받은 비율	77.4%	86.4%	86.7%	87.4%	99.2%
		4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율	51.3%	52.1%	63.7%	71.3%	89.3%
		모성, 신생아 보건에 대한 지역주민의 인식이 개선된다.	모성, 신생아 보건관련 지역주민 지식, 태도, 실천율	22.3%	13.1%	50.6%	42.3%

- (데이터 수집) 2018-2024년 Cambodia HIS 월별 행정 데이터를 라따나끼리 주 보건당국으로부터 제공받음. 이 데이터는 사업 시행 전, 중, 후 라따나끼리 지역(바르케오구, 반룽구) 보건소 및 병원을 이용한 산모를 대상으로 수집함.
- (분석 방법) 해당 사업 이외의 변수가 관심 성과지표에 영향을 주는 것을 통제하고, 시간에 따른 사업의 효과를 평가하기 위해서 준실험설계 (quasi-experimental design)의 단절적 시계열 분석(Interrupted time series)을 적용하여 사업이 시행되기 전의 시간에 따른 경향을 파악하고, 사업이 시행됨에 따른 변화를 비교함으로써 그 효과를 분석함
- (분석 모델) 데이터의 자기상관성, 계절성, 비정상성 가정을 만족하는지 검토 후에 다음과 같이 구간별 회귀모델(segmented regression model)을 적합하여 분석을 진행함

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_t + \beta_3 TX_t$$

- T 는 연구가 시작된 이후 경과된 시간(월 단위), Y_t 는 t 시점의 성과지표, X_t 는 사업 시행 여부 (시행 전=0, 시행 후=1), β_1 는 시행 전 추세를 나타내고, β_2 는 시행 직후의 수준 변화, β_3 는 시행 후의 기울기 변화로, 사업 시행의 장기효과를 의미함
- (분석 소프트웨어) 전반적인 분석은 R 분석 프로그램(version 4.3.3)을 활용함

□ 설문조사

- (목적) 사업 PDM에 제시된 성과지표를 반영한 사업의 평가, 사업 중재로 인한 지역 사회 모자보건 서비스 질 및 접근성 향상, 사업 수혜 모성의 모자보건 인식개선 확인, 수혜자의 만족도 분석, 산모와 신생아 건강에 미친 영향 조사, 미달성 항목에 대한 원인 등에 대한 설문을 수행함
- (대상) 라따나끼리 주 사업 수혜 대상이었던 사업 기간(2021.01-2023.12) 내 임신부였거나 출산 경험이 있는 모성
- (표본 선정 방법) 해당 사업이 모집단 내에서 일어난 변화에 대한 개연성의 수준을 계산할 수 있도록 체계적으로 사례를 추출하는 확률표본 추출(Probability sampling)을 적용하는 것이 이상적임. 그러나, 본 과정이 ODA 전문가 과정생을 활용한 평가인 점, 조사 예산 및 시간적 제약 사항을 고려하여 평가단 방문일에 접촉이 가능한 조사 대상자들을 표본으로 선정하는 편의 표본(Convenience Sampling) 추출로 수행함
- (표본 크기 결정) 신뢰구간접근법을 활용하여 종료선 조사에서 라따나끼리 표본 1,109 가구를 모집단으로 할 때 사업의 효과성 및 영향력의 크기를 일정 유의수준(Significance Level)과 검정력(Power)을 확보하면서 통계 분석을 통해 유의미하게 파악할 수 있는 최소크기인 최소감지효과크기(Minimum Detectable Effect Size; MDE)는 95%(오차 범위 ±5%)에서 285가구를 표본 크기로 결정함

$$S = \frac{X^2 \cdot N \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2 \cdot (N - 1) + X^2 \cdot P \cdot (1 - P)}$$

- S 는 필요한 표본 크기, X^2 는 카이제곱 값(신뢰 수준 95%일 때 3.841), N 은 모집단 크기(1,109가구), P 는 모집단 비율(일반적으로 0.5로 가정)이고, d 는 허용 오차를 의미함
- (표본 크기 결정) 지역 사회의 인구 및 사회학적 특성과 모자 보건 서비스 이용 및 인식, 서비스 욕구 및 만족도, 모자보건 관련 지식·태도·실천(KAP) 수준을 측정할 수 있는 문항으로 구성함(별첨 참고)
- (조사 방법) 조사원에 의한 대면 설문 응답 방식으로 태블릿 PC 및 모바일 기반 CAPI(Computer Assisted Personal Interviewing) 방식 또는 설문 인쇄물을 지역 상황 및 응답자 문해 수준에 맞춰 활용할 예정임. CAPI는 오프라인에서 사용 가능한 설문 KoboCollect App으로 설계함
- (설문지 Pilot Test) 평가팀이 작성한 설문지 프로그램화하여 현지 전문 조사 기관에서 번역 및 시험 평가(Pilot Test) 수행 후 오류 사항 검토 및 설문지 수정을 거쳐 설문지 상의 문화적, 언어적 오류를 최소화

- (자료 분석 방법) 설문지 응답 수집 후 코딩 작업 후 오류 검증 등을 통해 데이터 클리닝을 수행함. 수혜지 산모의 인구사회학적 변수(연령, 가족 구성원 수, 자녀 연령, 가구 소득, 교육수준, 직업, 결혼 상태), 모자보건(MCH) 사업의 직/간접 경험 및 지식/태도/실천(KAP) 영역에 대해 통계적으로 유의한 차이가 있는지 분석할 예정임. 모든 통계 분석은 R 분석 프로그램(version 4.3.3)을 사용함
- (문돌끼리 지역의 설문조사) 현실적인 제약으로 인해 문돌끼리 지역의 설문은 실사 기간 내에 불가능할 것으로 판단하여 50명 안팎의 수혜 대상 설문을 현지 컨설팅 업체를 통해 진행할 예정

□ 면담조사

- (목적) 사업의 이해당사자 및 직·간접 수혜자를 대상으로 사업의 효과성 등을 평가하여 사후관리 및 유사 사업 진행 시 교훈으로 삼고자 하며 행정자료 분석 결과 및 설문조사 등 양적분석과의 비교 분석을 통해 사업의 성과에 대한 근거 및 사유 등에 대해 심층적인 파악을 함
- (조사대상 및 조사방법) 라파나끼리 주 내 ① 임신부 및 5세 미만 아동의 어머니, ② 프로그램 참여자들의 가족(남편 및 시어머니), ③ 후보건국, 보건사업 운영지역(OD) 관계자, ④ 보건소 인력, ⑤ 마을 보건 요원을 대상으로 Focus Group Interview와 개인에 대한 In-Depth-Interview 실시함
- (조사 기준) OECD DAC 6대 평가 범주를 반영하여 제공된 모자보건사업 사업의 1) 적절성, 2) 일관성, 3) 효과성, 4) 효율성, 5) 영향력, 6) 지속가능성이 조사 대상을 통하여 평가될 수 있도록 각 집단에 따른 평가 범주별 질문지를 구성함
- (질문 주제) 집단에 따른 주요 질문 주제는 아래와 같음:
 - 임신부 및 5세 미만 아동의 어머니 : 모자보건 프로그램에 대한 효과성 및 효율성, 프로그램 제공받은 후 변화된 건강관리에 대한 인식 변화
 - 프로그램 참여자들의 가족(남편) : 모자보건에 대한 인식의 변화, 가정 내 자신의 역할변화 및 프로그램 유지를 위한 방법, 사업 홍보 미디어(오디오 및 TV 메시지 등)의 접근성과 이해도
 - 프로그램 참여자들의 가족(시어머니) : 모자보건에 대한 인식의 변화, 프로그램 영향력
 - 후보건국, OD 직원 : 모자보건 프로그램의 주요 지역사회 건강정책 및 지역사회 보건정책 목표 달성 및 조화 여부, 실질적 기여 여부
 - 보건소 인력 : TOT 교육 프로그램에서 제공된 교육의 효과성 및 지속성, 지원된 시설의 실질적 활용 여부 및 주민 반응

- 마을 보건 요원 : 아웃리치 교육 프로그램에서 제공된 교육의 효과성, 프로그램이 주민들의 인식 변화 및 건강 증진에 실질적으로 기여했는지 여부

- (문돌끼리 지역의 면담조사) 문돌끼리 지역의 이해관계자 면담은 평가전문가 중심으로 진행할 예정
- (분석방법) thematic analysis를 적용하여 질적 데이터를 분석하여 결과를 도출함
 - ① 인터뷰를 통해 자료를 수집하며, 인터뷰 현장에서 필드 노트를 작성
 - ② 인터뷰 내용을 전사하고, 분석할 자료를 정리
 - ③ 자료를 반복해서 읽으면서 의미 있는 단위로 묶고, 자료를 조직하여 범주에 이름을 붙이는 자료 코딩 작업 (이 과정에서 필드 노트도 활용하며, 코딩 및 재코딩을 반복하여 진행하여 신뢰도를 높일 예정)
 - ④ 도출된 범주 사이의 관계를 분석하고, 핵심이 되는 주제를 찾음
 - ⑤ 이 분석 절차를 거쳐 도출된 결과를 기술

□ 시설 및 기자재 관리 실태 평가

- (방문 대상) 라파나끼리와 문돌끼리 지역의 보건소, 모자보건센터
- (평가 전문가) 전문가 과정생 중 의료진 3인(의사 및 간호사)
- (조사 항목) 조사항목은 다음과 같음
 - 시설 관리 : 보건소 및 병원의 감염관리, 위생 상태, 모자보건센터 운영 여건
 - 기자재 상태 및 활용도 : 기자재 목록과 가동률 자료, 초음파 진단기, 인큐베이터, 분만대 등의 유지관리 상태
 - 소모품 관리 : 산소통 및 기타 소모품의 유지관리

구분	기자재 확인사항
적절성	• 도입된 기자재가 실제 의료진의 요구와 현지 보건서비스 제공 상황에 부합하며, 효율적으로 사용되고 있는가? • 자주 사용하지 못하는 기자재가 있다면, 그 이유는 무엇이며 이를 해결하기 위해 어떤 지원이 필요한가?
효과성	• 도입된 기자재가 문제없이 작동하며, 가동률이 적절한 수준(예: 90% 이상)을 유지하고 있는가? • 사용하지 못하거나 가동률이 낮은 기자재가 있다면, 문제의 원인은 무엇이며 이를 해결하기 위해 어떤 지원이 필요한가?
효율성	• 기자재 운용을 위한 사용자 교육 및 기술 지원이 효율적이고 신속히 이루어졌는가?
지속가능성	• 도입된 기자재에 대한 유지보수 서비스가 정기적으로 이루어지고 있으며, 필요한 소모품이나 예비 부품의 공급이 원활한가? • 기자재를 장기적으로 사용하지 못하게 할 수 있는 문제(예: 유지보수 비용, 기술 부족)가 있다면, 이를 해결하기 위해 어떤 지원이 필요한가? • 현지 보건소나 병원이 도입된 기자재를 장기적으로 관리하고 활용할 수 있도록 적절한 기술 및 재정 지원이 마련되어 있는가?

첨부 4 면담자 목록 및 주요 면담 질문

○ 면담자 목록

구분	지역	면담 대상	방식	일시
수요자 -임산부 및 5세 미만 아동의 어머니 (38명)	O Chum	어머니1, 어머니2, 어머니3, 어머니4, 어머니5, 어머니6, 어머니7, 어머니8	FGD	25.01.20
	O chum	어머니9	IDI	25.01.20
	Ka choun	어머니10, 어머니11, 어머니12	FGD	25.01.20
	Ka choun	어머니13, 어머니14, 어머니15	FGD	25.01.20
	Koun mom	어머니16, 어머니17, 어머니18, 어머니19, 어머니20, 어머니21, 어머니22, 어머니23, 어머니24, 어머니25, 어머니26, 어머니27, 어머니28, 어머니29	FGD	25.01.21
	Kachanh	어머니30, 어머니31, 어머니32, 어머니33, 어머니34, 어머니35, 어머니36, 어머니37	FGD	25.01.22
	Taveng	어머니38	IDI	25.01.22
수요자 -남편 (7명)	Andong meas	남편1, 남편2, 남편3, 남편4	FGD	25.01.20
	O chum	남편5	IDI	25.01.20
	Koun mom	남편6	IDI	25.01.21
	Taveng	남편7	IDI	25.01.22
수요자 -시어머니 (7명)	O chum	시어머니1	IDI	25.01.20
	Koun mom	친정어머니2	IDI	25.01.21
	Lumphat	시어머니3, 시어머니4, 시어머니5, 시어머니6, 시어머니7	FGD	25.01.21
공급자 -보건행정책 임자 (주정부관계자 및 OD) (9명)	O chum	OOO(O chum 보건소장)	IDI	25.01.20
	Andong meas	OOO(Andong meas 보건소 담당자)	IDI	25.01.20
	Koun mom	OOO(Koun mom PHD)	IDI	25.01.21
	Koun mom	OOO(Koun mom OD)	IDI	25.01.21
	Koun mom	OOO(Koun mom 보건소장)	IDI	25.01.21
	Lumphat	OOO(Lumphat 보건소장)	IDI	25.01.21
	Banlung	OOO(Ratanakiri State Health Department PHD)	IDI	25.01.22
	Banlung	OOO(Ratanakiri State Health Department PHD)	IDI	25.01.22
	Banlung	OOO(Ratanakiri Provincial Hospital Director)	IDI	25.01.22
공급자 -보건의료 인력 (11명)	O chum	OOO(O chum province 보건소 산파)	IDI	25.01.20
	Andong meas	OOO(Andong meas 보건소 산파)	IDI	25.01.20
	Andong meas	OOO(Andong meas 보건소 산파)	IDI	25.01.20
	Koun mom	OOO(Koun mom 조산사)	IDI	25.01.21
	Koun mom	OOO(Koun mom 보건소 산파)	IDI	25.01.21
	Koun mom	OOO(Koun mom 보건소 산파)	IDI	25.01.21
	Banlung	OOO(Provincial Referral Hospital of Ratanakiri 병원 산파 과장)	IDI	25.01.22
	Banlung	OOO(Provincial Referral Hospital of Ratanakiri 산파)	IDI	25.01.22
	Banlung	OOO(Provincial Referral Hospital of Ratanakiri 산파)	IDI	25.01.22
	Banlung	OOO(Provincial Referral Hospital of Ratanakiri 마취간호사)	IDI	25.01.22
공급자 -마을보건 요원 (8명)	Banlung	OOO(Ratanakiri Provincial Hospital 의사)	IDI	25.01.22
	O chum	마을보건요원1, 마을보건요원2,	FGD	25.01.20
	Andong meas	마을보건요원3, 마을보건요원4,	FGD	25.01.20
	Ka choun	마을보건요원5, 마을보건요원6	FGD	25.01.20
	Ka choun	마을보건요원7, 마을보건요원8	FGD	25.01.21

○ 주요 면담 질문

집단	평가 항목	질문
임산부 및 5세 미만 아동의 어머니	적절성	- 모자 보건 서비스를 받을 때, 지원받은 서비스가 실제로 본인과 가족에게 필요한 내용이었나요? - 필요했다면 어떤 것이 가장 필요하고 도움이 되었나요? - 필요하지 않았다면 어떤 서비스를 받고 싶으셨나요? - 임산부 또는 어머니로서 꼭 필요했지만, 이 사업에서 미흡했다고 느끼는 것은 무엇입니까?
	일관성	- 기존에 유사한 프로그램에 대해 알고 계셨습니까? 만약 알고 계신 프로그램이 있다면 말씀해 주세요. - 사업 수혜 시 기존에 제공받던 보건 서비스와 충돌은 없었나요?
	효과성	- 사업 시작 이후, 본인의 건강 상태에 어떤 변화가 있었나요? - 사업 시작 이후, 아동의 건강 상태에 어떤 변화가 있었나요? - 본인의 건강을 위해 제공된 보건 서비스 중 가장 도움이 된 것은 무엇인가요? - 아동의 건강을 위해 제공된 보건 서비스 중 가장 도움이 된 것은 무엇인가요? - 서비스를 받은 이후 건강 인식에 어떤 변화가 있었나요?
	효율성	- 이 프로그램을 통해 어떤 지원을 받으셨나요? - 계획된 프로그램에 모두 참여하는 것은 어떠셨나요?
	영향력	- 프로그램이 임산부와 아동의 건강에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 임산부나 어머니들의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 남편의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 시어머니의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요?
	지속 가능성	- 향후 이 사업에 다시 참여하거나 주변인들에게 소개하고 싶은 의향이 있습니까? - 어떤 점 때문에 그런 생각을 하셨나요? - 본 프로그램 참여에 어려웠던 적이 있었나요? - 그런 경험이 있었다면 무엇 때문에 그런가요? - 향후 이러한 사업에 본인의 남편, 시어머니, 자녀가 참여하는 것은 어떻게 생각하시나요? - 본인, 가족, 지인의 건강 증진을 위해 필요한 영역이나 사업 및 정책이 있나요?
	성주류화 원조소의 계층포용	- 가족 중에 당신의 프로그램 참여를 반대하는 사람이 있었나요? - 사업 참여 과정에서 지역적, 문화적 이유로 참여를 제한받거나 어려움을 겪은 적이 있었나요?
남편	적절성	- 모자 보건 서비스를 받을 때, 지원받은 서비스가 실제로 본인과 가족에게 필요한 내용이었나요? - 필요했다면 어떤 것이 가장 필요하고 도움이 되었나요? - 필요하지 않았다면 어떤 서비스를 받고 싶으셨나요? - 남편으로서 꼭 필요했지만, 이 사업에서 미흡했다고 느끼는 것은 무엇입니까?
	일관성	- 기존에 유사한 프로그램에 대해 알고 계셨습니까? 만약 알고 계신 프로그램이 있다면 말씀해 주세요. - 사업 수혜 시 기존에 제공받던 보건 서비스와 충돌은 없었나요?
	효과성	- 사업 시작 이후, 임산부와 아동의 건강 상태에 어떤 변화가 있었나요? - 임산부와 아동의 건강을 위해 제공된 보건 서비스 중 가장 도움이 된 것은 무엇인가요? - 서비스를 받은 이후 건강 인식에 어떤 변화가 있었나요?

	효율성	- 이 프로그램을 통해 어떤 지원을 받으셨나요? - 계획된 프로그램에 모두 참여하는 것은 어떠셨나요?
	영향력	- 프로그램이 임산부와 아동의 건강에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 남편들의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 임산부나 어머니의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 시어머니의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요?
	지속 가능성	- 향후 이 사업에 다시 참여하거나 주변인들에게 소개하고 싶은 의향이 있습니까? - 어떤 점 때문에 그런 생각을 하셨나요? - 본 프로그램 참여에 어려웠던 적이 있었나요? - 있었다면 무엇 때문에 그런가요? - 향후 이러한 사업에 본인의 아내, 어머니, 자녀가 참여하는 것은 어떻게 생각하시나요? - 본인, 가족, 지인의 건강 증진을 위해 필요한 영역이나 사업 및 정책이 있나요?
	성주류화	- 프로그램에 참여한 뒤 가족 내 역할이 달라진 점이 있었나요? - 아내와 (시)어머니, 그리고 본인으로서의 역할을 각자 어떻게 이해하게 되었나요?
	원조소의 계층포용	사업 참여 과정에서 지역적, 문화적 이유로 참여를 제한받거나 어려움을 겪은 적이 있었나요?
(시) 어머니	적절성	- 모자 보건 서비스를 받을 때, 지원받은 서비스가 실제로 본인과 가족에게 필요한 내용이었나요? - 필요했다면 어떤 것이 가장 필요하고 도움이 되었나요? - 필요하지 않았다면 어떤 서비스를 받고 싶으셨나요? - 시어머니로서 꼭 필요했지만, 이 사업에서 미흡했다고 느끼는 것은 무엇입니까?
	일관성	- 기존에 유사한 프로그램에 대해 알고 계셨습니까? 만약 알고 계신 프로그램이 있다면 말씀해 주세요. - 사업 수혜 시 기존에 제공받던 보건 서비스와 충돌은 없었나요?
	효과성	- 사업 시작 이후, 임산부와 아동의 건강 상태에 어떤 변화가 있었나요? - 임산부와 아동의 건강을 위해 제공된 보건 서비스 중 가장 도움이 된 것은 무엇인가요? - 서비스를 받은 이후 건강 인식에 어떤 변화가 있었나요?
	효율성	- 이 프로그램을 통해 어떤 지원을 받으셨나요? - 계획된 프로그램에 모두 참여하는 것은 어떠셨나요?
	영향력	- 프로그램이 임산부와 아동의 건강에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 시어머니들의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 임산부나 어머니의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요? - 프로그램이 임산부와 아이의 건강에 대한 남편의 인식에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하시나요?
	지속 가능성	- 향후 이 사업에 다시 참여하거나 주변인들에게 소개하고 싶은 의향이 있습니까? - 어떤 점 때문에 그런 생각을 하셨나요? - 본 프로그램 참여에 어려웠던 적이 있었나요? - 있었다면 무엇 때문에 그런가요? - 향후 이러한 사업에 본인의 아들, 며느리, 손주가 참여하는 것은 어떻게 생각하시나요?

	성주류화	- 프로그램에 참여한 뒤 가족 내 역할이 달라진 점이 있었나요? - 며느리와 아들, 그리고 본인(시어머니)로서의 역할을 각자 어떻게 이해하게 되었나요?
	원조소의 계층포용	사업 참여 과정에서 지역적, 문화적 이유로 참여를 제한받거나 어려움을 겪은 적이 있었나요?
보건 행정 책임자 (주정부 관계자 및 OD)	적절성	- 프로그램이 지역사회 건강정책 및 지역사회 보건 주요 정책 목표 달성에 맞게 설계되었나요? - 프로그램에서 제공된 방식(시간, 자원) 등이 적절한 수준이었나요?
	일관성	- 코이카 프로그램이 기존의 정부정책과 충돌하지 않고 이뤄졌나요? - 코이카 외 다른 기관의 지원 사업과 조화를 이루고 있다고 생각하시나요? - 본 프로그램을 통해 약속받은 지원과 계약이 종료 시까지 잘 유지되었나요? - 주정부 차원에서 지역사회건강증진을 위한 약속했던 지원과 계약이 종료 시까지 잘 유지 되었나요?
	효과성	- 프로그램이 지역사회구성원들의 건강 증진에 실질적으로 기여하고 있다고 생각하시나요? 왜 그렇다고 생각하나요? - 지원을 받은 뒤 보건 정책 수립 및 실행역량이 이전보다 향상되었다고 생각하시나요? - 정부에게 가장 효과적이었다고 생각하는 프로그램이 있나요?
	효율성	- 보건소와 마을주민들 사이의 연계가 효율적으로 개선되었다고 생각하나요? - 보건소와 마을보건요원들에게 필요한 권한을 충분하게 위임하고 있다고 생각하나요? - 주보건국 정책 실현 과정에서 주정부 내, 보건소, 마을보건요원, 마을주민들에게서 발생한 불만사항이 있나요?
	영향력	- 프로그램이 지역사회 주민들의 건강관리 방식에 어떤 변화를 주었다고 생각하나요? - 프로그램이 정부와 지역사회 간의 신뢰관계에 미친 영향은 무엇이라고 생각하나요? - 지원을 받은 뒤 보건 정책 수립 및 실행역량이 이전보다 향상되었다고 생각하시나요?
	지속 가능성	- 프로그램이 종료된 다음에도 주정부 차원에서 사업을 계속하겠다는 의지가 있나요? - 프로그램이 종료된 이후에도 사업을 유지할 수 있는 예산을 확보했나요? - 국가 및 지역의 건강 증진을 위해 필요한 영역이나 사업 및 정책이 있나요?
	성주류화	지역사회 성별 불평등을 해소하기 위해 프로그램이 적절히 설계되었다고 생각하시나요?
	원조소의 계층포용	- 프로그램이 소수민족, 소수언어 사용자들에게도 유용했나요? - 취약계층을 위한 문화적 민감성 교육을 받은 적이 있나요?
보건 의료 인력	적절성	- 시설 지원과 TOT(Training of Trainers) 교육이 기존 보건소의 실제 업무의 필요에 맞게 설계되었다고 생각하나요? - 프로그램에서 제공된 방식(시간, 장소) 등이 교육받기에 적절한 수준이었나요?
	일관성	- 보건소가 제공받은 코이카의 지원 및 교육들이 서로 충돌하지 않고 이뤄졌나요? - 코이카 외 다른 기관의 지원 사업과 조화를 이루고 있다고 생각하시나요? - 프로그램을 통한 지원과 계약이 프로그램이 종료될 때 까지 잘 유지되었나요?
	효과성	- 코이카의 프로그램이 지역사회구성원들의 건강 증진에 실질적으로 기여하고 있다고 생각하시나요? 왜 그렇다고 생각하나요? - 교육을 받은 보건의료인력들의 역량이 이전보다 향상되었다고 생각하나요? - 코이카의 보건소 시설 지원(의료 기기 등)이 지역 주민들의 건강 증진에 효과적이었다고 생각하시나요?

		• 그렇다면 어떤 점에서 그렇게 생각하시나요? • 보건소에게 가장 효과적이었던 프로그램은 무엇인가요?
	효율성	• 지역주민의 건강증진을 위한 방법이 시간적, 금전적으로 효율적으로 개선되었다고 생각하시나요? • 지역사회 건강증진을 위해 필요한 권한을 충분하게 위임받고 있다고 생각하시나요? • 보건소 서비스 제공 시에 보건의료인력 내, 마을보건요원, 마을주민, 주정부에서 발생한 불만 사항이 있나요?
	영향력	• 프로그램이 지역사회 주민들의 건강관리 방식에 어떤 변화를 주었다고 생각하시나요? • 프로그램이 보건소와 지역사회 간의 신뢰관계에 미친 영향은 무엇인가요?
	지속 가능성	• 프로그램이 종료된 다음에도 정부나 단체의 지원이 이뤄지고 있다고 생각하시나요? • 보건소들이 다른 보건소들의 시설개선을 돕거나 시스템 개선을 확산시키고 있다고 생각하시나요? • 국가 및 지역의 건강 증진을 위해 필요한 영역이나 사업 및 정책이 있나요?
	성주류화	• 프로그램 제공 과정에서 여성과 남성의 접근성 격차를 인지하고 해결하기 위한 노력을 기울였나요?
	원조소의 계층포용	• 보건소 내 소수민족 또는 소수언어 사용자에게 프로그램이 적절히 설계되고 제공되었다고 생각하시나요?
마을 보건 요원	적절성	• 아웃리치 교육 프로그램에서 제공된 교육이 지역주민들의 필요에 맞게 설계되었나요? • 프로그램에서 제공된 방식(시간, 장소) 등이 교육받기에 적절한 수준이었나요?
	일관성	• 코이카 프로그램은 마을보건요원들이 받은 교육 사이에서 충돌하지 않고 이뤄졌나요? • 마을보건요원 활동 시 처음 약속한 지원과 계약이 계속 유지 되었었나요?
	효과성	• 본 프로그램을 통한 본인의 활동이 마을주민들의 건강 증진에 실질적으로 기여하고 있다고 생각하시나요? 왜 그렇다고 생각하시나요? • 본 프로그램을 통해 마을보건요원들의 역량이 점차 향상되었다고 생각하시나요? • 마을보건요원으로서 마을주민의 건강을 증진하는 데 가장 효과적이었던 프로그램은 무엇인가요?
	효율성	• 보건소와 마을주민 간 연계가 기존방식보다 시간적, 금전적으로 효율적으로 개선됐는가? • 마을보건요원의 업무를 수행하기 위해 필요한 권한을 주보건국과 보건소가 충분히 부여하고 있다고 생각하시나요? • 모자보건 서비스 제공 시에 발생한 마을보건요원의 불만사항이 있었나요? • 모자보건 서비스 제공 시에 발생한 마을주민의 불만사항이 있었나요?
	영향력	• 프로그램이 지역사회 주민들의 건강관리 방식에 어떤 변화를 주었다고 생각하시나요? • 프로그램이 보건소와 마을주민 간의 신뢰관계에 미친 영향은 무엇인가요?
	지속 가능성	• 프로그램이 종료된 다음에 정부의 지원이 계속 이뤄지고 있나요? • 마을보건요원들이 마을보건요원들을 재교육시키거나, 교육받은 것을 확산시키고 있나요? • 국가 및 지역의 건강 증진을 위해 필요한 영역이나 사업 및 정책이 있나요?
	성주류화	• 프로그램을 통해 지역 내 여성과 남성 간 보건서비스 접근성의 차이가 개선되었다고 생각하시나요?
	원조소의 계층포용	• 취약계층의 사업 참여를 방해하는 요소를 해결하기 위해 어떤 노력을 기울였나요?

Survey Questionnaire

Hello! This survey has been designed to evaluate a maternal and child health project conducted in the northeastern region of Cambodia. Your valuable responses will help improve our understanding of maternal and child health initiatives and contribute significantly to the development of future projects.

The survey consists of 40 questions and is expected to take approximately 30 minutes to complete.

Participation in this survey is voluntary, and you may withdraw at any time without any consequences. Responses are collected anonymously, and all data will be used solely for research purposes. All information will be kept strictly confidential, and the research findings will only be presented in a form that does not identify individual participants.

We kindly ask you to respond to each question sincerely.

There are no specific restrictions, and your honest answers will greatly contribute to this research.

Thank you sincerely for taking the time to participate in this survey despite your busy schedule.

***Note:** This questionnaire shall be administered to women who were pregnant or had childbirth experience during the project period (January 2021 - December 2023) in Ratanakiri.

* I would like you to read this sentence to me.

1. Cannot read at all
2. Able to read only part of the sentence
3. Able to read whole sentence
4. No card with required language, Specify language: _____
5. Blind/Visually impaired

Section 1. Screening Information

This section is designed to verify if you are eligible to participate in this survey.

1. What emergency response services have you received during COVID-19? (Multiple answers)

- ☐ Isolation facility
- ☐ Covid-19 screening test
- ☐ Watching COVID-19 campaign videos on the TV in the health center waiting room
- ☐ Listening to audio content on COVID-19 Prevention Guidelines through loudspeaker of village or health center
- ☐ I didn't receive any services. (☞ go to question 2)

1-1. How much are you satisfied with emergency response services during covid-19?

- 1. Very dissatisfied
- 2. Dissatisfied
- 3. Neutral
- 4. Satisfied
- 5. Very satisfied

2. What awareness improvement services have you received from January 2021 to October 2023? (Multiple answers)

- ☐ KIRI class (☞ go to question 2-1)
- ☐ Health campaign (Walking together, health Campaign Slogan Contest, one-day KIRI class)
- ☐ Outreach service
- ☐ Watching maternal child health care campaign videos on the TV in the health center waiting room
- ☐ Listening to audio content on prenatal and postnatal care improvement, and nutrition management through loudspeaker of village or health care center
- ☐ I didn't receive any services.

2-1. Have you ever participated in a 'Mother's Self-Help Group (SHG)' as part of the KIRI class?

1. Yes (☞ go to question 2-2)
2. No (☞ go to question 3)

2-2. Do you participate in a 'Mother's Self-Help Group (SHG)' as part of the KIRI class now?

1. Yes
2. No

3. What maternal and child health (MCH) services have you received from January 2021 to October 2023? (Multiple answers)

- ☐ Antenatal care (ANC)
- ☐ Delivery services
- ☐ Postpartum care/post-natal care (PNC)
- ☐ No, I didn't receive any services. (☞ go to question 3-1)

3-1. If no, what were the reasons that you did not receive the MCH services? (Multiple answers)

1. Payment is very high
2. Didn't know the MCH service
3. Family member didn't want it
4. Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)
5. Didn't think the services were necessary
6. Didn't trust the quality of the health facility
7. Have disabilities
8. Have difficulty communicating
9. The COVID-19 pandemic
10. Tradition/cultural reasons
11. Other(Please specify:)

4. Where did you learn that you have to get the maternal and child health (MCH) services? (Multiple answers)

1. KIRI Class
2. Health campaigns (e.g., Walking together, health Campaign Slogan Contest, one-day KIRI class)
3. Educational materials (e.g., Poster, Banner, Billboard, Flipchart)
4. Audio content through loudspeaker of village or public health center
5. campaign videos on the TV in the health center waiting room
6. Village Health Support Group(VHSG)
7. Outreach service
8. Private Medical Center staff
9. Public Health Center staff
10. Mother-in-law
11. Mother
12. Friends
13. Community meetings
14. Other (please specify):

Section 2. Demographic and Socioeconomic Information

This section collects basic demographic and socioeconomic information about you and your family.

* I would like you to answer about yourself.

1. What is your highest level of education?

1. No education experience
2. Primary school
3. Secondary school
4. High school
5. University or higher

2. What is your ethnicity?

- ☐ Khmer
- ☐ Thompoun
- ☐ Charay
- ☐ Kreung
- ☐ Other ethnic groups (Please specify:)

3. What is your religion?

- ☐ Buddhism
- ☐ Christianity
- ☐ Islam
- ☐ Hinduism
- ☐ Other(Please specify:)

4. What is your current marital status?

- ☐ Married (☞ go to question 10~12)
- ☐ Divorced (☞ go to question 13)
- ☐ Widowed (☞ go to question 13)

5. How old were you when you got married? (years)

* I would like you to answer about your household.

6. What is your household's employment status?

- 1. Regular employee
- 2. Part-time employee, Day laborer
- 3. Self-employed/own account worker
- 4. Employer
- 5. Unpaid family worker/Unemployed
- 6. Don't know
- 7. Other(Please specify:)

7. What is the approximate monthly income(cash and kind) of your household?

_____ In KHR per month

3-1. Is your household paid in cash or kind for this work or are you not paid at all?

- 1. Cash only
- 2. Cash and kind
- 3. In kind only
- 4. Not paid

8. Does your household have an ID Poor card (Health equity card)?

1. Yes
2. No
3. Don't know

9. How did you pay for MCH services (ANC, Delivery, PNC) (Multiple answers)?

1. ID Poor card (Health Equity card), Health Equity Fund (HEF)
2. National social security card, National Social Security Fund (NSSF), Social Health Insurance (SHI)
3. Self-financed (e.g. wages, pocket money, savings, Sale of assets...)
4. Borrowed money or loan (e.g. microfinance, bank loan, Informal finance, Payday loan...)
5. Village (Community) Health Fund, gift from friends of relatives
6. Support or assistance from NGOs, UN agencies, or other institutions
7. Didn't pay
8. Other (please specify):

* I would like you to answer about your children.

10. How many children do you have? _____

11. Please fill the needed information below in each of your most recently born child.

Birth order	Gender (M/F)	Birth weight (kg)	Birth date YYMMDD	Child had health problem within 6 weeks after birth		Length of gestation (weeks)			Type of delivery		
				YES	NO	Full term 37-42 wk	Premature <37wk	Overdue >42wk	Natural	Caesarian	Other Please specify
1				①	②	①	②	③	①	②	

Section 3. MCH services

In this section, we would like to ask you questions about your experience on ANC , Delivery and PNC after you gave birth. Please answer according to your experience with your last pregnancy and/or any child under five years old.

ANC: Antenatal care is provided to you during pregnancy to help improve your maternal wellbeing, and ensure you can prepare for a safe birth. By detecting and managing any health issues during pregnancy, antenatal care can improve the health of your unborn baby and reduce the risk of low birth weight and other more serious issues.



1. How many times did you attend ANC (Antenatal Care)? ____ (times)
2. If you answered fewer than four times, what is the reason you received the service less than four times?
 1. Payment is very high
 2. Didn't know the ANC service
 3. Family member didn't want it
 4. Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)
 5. Didn't think the services were necessary
 6. Didn't trust the quality of the health facility
 7. Have disabilities
 8. Have difficulty communicating
 9. The COVID-19 pandemic
 10. Tradition/cultural reasons
 11. Other(Please specify:)

3. Where did you receive your most recent ANC?
 1. Health post
 2. Health center
 3. Operational district referral hospital
 4. Provincial referral hospital
 5. Private health facility
 6. Outreach service
 7. Other(Please specify:)

4. How did you pay for ANC services (Multiple answers)?
 1. ID Poor card(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
 2. National social security card, National Social Security Fund(NSSF), Social Health Insurance(SHI)
 3. Self-financed(e.g. wages, pocket money, savings, Sale of assets...)
 4. Borrowed money or loan(e.g. microfinance, bank loan, Informal finance, Payday loan...)
 5. Village(Community) Health Fund, gift from friends of relatives
 6. Support or assistance from NGOs, UN agencies, or other institutions
 7. Didn't pay
 8. Other(please specify):

5. What types of services did you receive during your last ANC visits? (Multiple answers)
 1. Check weight
 2. Check syphilis
 3. Check for HIV
 4. Check for pre-eclampsia
 5. Get tetanus vaccine
 6. Check blood pressure
 7. Provide iron tablet
 8. Provide folic acid tablet
 9. Check fetal movement
 10. Other(Please specify:)

11. Don't know
6. Are you satisfied with the ANC services you received?
1. Yes (☞ go to question 6-1)
 2. No (☞ go to question 6-2)
- 6-1. What were the main reasons for your satisfaction? (Multiple answers)
5. They take care of me well
 6. HF staff are friendly and considerable
 7. Does not have to spend a lot of money
 8. HF staff have skill and can be trusted
 9. Other: (Please specify:)
- 6-2. What were the main reasons for your dissatisfaction? (Multiple answers)
1. Impolite/unresponsive health staff
 2. Unhygienic building
 3. Old equipment/tools
 4. Expensive
 5. Other(Please specify:)
7. Where did you deliver your baby?
1. Health post
 2. Health center
 3. Operational district referral hospital
 4. Provincial referral hospital
 5. Private health facility
 6. Home
 7. Other(Please specify:)
8. How did you pay for delivery services (Multiple answers)?

1. ID Poor card(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
 2. National social security card, National Social Security Fund(NSSF), Social Health Insurance(SHI)
 3. Self-financed(e.g. wages, pocket money, savings, Sale of assets...)
 4. Borrowed money or loan(e.g. microfinance, bank loan, Informal finance, Payday loan...)
 5. Village(Community) Health Fund, gift from friends of relatives
 6. Support or assistance from NGOs, UN agencies, or other institutions
 7. Didn't pay
 8. Other(please specify):
9. Who assisted your delivery?
- [HEALTH PERSONNEL] (☞ go to question 8)
1. Doctor
 2. Nurse/Midwife
 3. Auxiliary midwife
- [OTHER PERSON or NO] (☞ go to question 7-1)
4. Traditional birth attendant
 5. Relative/Family/Friend
 6. Other(Specify)
 7. No one assisted
- 9-1. If you chose 4~7, what were the main reasons for not receiving assistance from a skilled birth attendant?
1. Payment is very high
 2. Didn't know the delivery service
 3. Family member didn't want it
 4. Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)
 5. Didn't think the services were necessary
 6. Didn't trust the quality of the health facility
 7. Have disabilities
 8. Have difficulty communicating

- 9. The COVID-19 pandemic
- 10. Tradition/cultural reasons
- 11. Other(Please specify:)

10. Are you satisfied with the delivery services you received?

- 1. Yes (☞ go to question 9-1)
- 2. No (☞ go to question 9-2)

10-1. What were the main reasons for your satisfaction? (Multiple answers)

- 1. They take care of me well
- 2. HF staff are friendly and considerable
- 3. Does not have to spend a lot of money
- 4. HF staff have skill and can be trusted
- 5. Other(Please specify:)

10-2. What were the main reasons for your dissatisfaction? (Multiple answers)

- 1. Impolite/unresponsive health staff
- 2. Unhygienic building
- 3 Old equipment/tools
- 4 Expensive
- 5 Other(Please specify:_____)

PNC: Postnatal care is the care provided to mothers and newborns after the baby's birth. It is very important for the health and well-being of you and your newborn baby that you receive postnatal care. Postnatal care can help identify common life-threatening complications, reduce infection after childbirth, and reduce deaths from prematurity or low birth weight.

11. Did you receive postpartum care/postnatal care after delivering your last child?

1. Yes(☞ go to question 11)
2. No(☞ go to question 9-1)

11-1. If no, what were the main reasons for not receiving PNC service?

1. Payment is very high
2. Didn't know the PNC service
3. Family member didn't want it
4. Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)
5. Didn't think the services were necessary
6. Didn't trust the quality of the health facility
7. Have disabilities
8. Have difficulty communicating
9. The COVID-19 pandemic
10. Tradition/cultural reasons
11. Other(Please specify:)

12. Did you receive postpartum care/post-natal care from a trained health worker?

1. Yes
2. No

13. Did you receive postpartum care/post-natal care within 48 hours after birth?
1. Yes
 2. No
14. How did you pay for PNC services (Multiple answers)?
1. ID Poor card(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
 2. National social security card, National Social Security Fund(NSSF), Social Health Insurance(SHI)
 3. Self-financed(e.g. wages, pocket money, savings, Sale of assets...)
 4. Borrowed money or loan(e.g. microfinance, bank loan, Informal finance, Payday loan...)
 5. Village(Community) Health Fund, gift from friends of relatives
 6. Support or assistance from NGOs, UN agencies, or other institutions
 7. Didn't pay
 8. Other(please specify):
15. Are you satisfied with the PNC services you received?
1. Yes (☞ go to question 12-1)
 2. No (☞ go to question 12-2)
- 15-1. What were the main reasons for your satisfaction? (Multiple answers)
1. They take care of me well
 2. HF staff are friendly and considerable
 3. Does not have to spend a lot of money
 4. HF staff have skill and can be trusted
 5. Other: (Please specify:)
- 15-2. What were the main reasons for your dissatisfaction? (Multiple answers)
1. Impolite/unresponsive health staff
 2. Unhygienic building
 3. Old equipment/tools
 4. Expensive
 5. Other(Please specify:)

Section 4. Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) of MCH

Next, I would like to ask you about your level of awareness, attitudes, and practices related to maternal and child health. Please answer according to your experience with your last pregnancy and/or any child under five years old.

1. What is the minimum number of antenatal care visits that should be received during pregnancy? _____ (visits)

2. What complications can occur during pregnancy? (Multiple answers)
 1. Vaginal bleeding
 2. Dizziness or fainting
 3. Severe headache
 4. Blurring vision
 5. Severe abdominal pain
 6. Extreme swelling of hands and/or face
 7. Fluid discharge from vagina
 8. Fever
 9. Reduced or no fetal movement
 10. Don't know
 11. Other(please specify):

3. What complications can occur during delivery? (Multiple answers)
 1. Labor does not progress
 2. Excessive bleeding
 3. Water breaking early
 4. Problems with umbilical cord
 5. Fetus not breathing
 6. Malposition
 7. Don't know
 8. Other (please specify):

4. How many postpartum care visits should be received after delivery?

_____ (visits)

5. Do you think ANC (Antenatal Care) is necessary for pregnant women?

1. Yes

2. No

6. Would you recommend ANC to other pregnant women?

1. Yes

2. No

7. Do you think it is necessary to deliver at a medical facility?

1. Yes

2. No

8. Would you recommend that other pregnant women deliver at a medical facility?

1. Yes

2. No

9. Do you wash your hands every time before breastfeeding?

1. Yes (☞ go to question 10)

2. No (☞ go to question 9-1)

9-1. If no, what are the reasons that you don't wash your hands every time before breastfeeding? (Multiple answers)

1. Lack of sanitation facilities

2. Lack of hygiene education

3. Cultural factors

4. Burden of time and labor

5. Climate and living environment

6. Economic burden of hygiene supplies

Section 5. Your thoughts and opinions on the MCH program

Finally, This section aims to gather your thoughts and opinions on the MCH services and MCH community programs. Your responses will help us understand your experience and make necessary adjustments to better meet your needs. Please answer the following questions to the best of your ability.

1. Is there anything else you would like to share about the Maternal and Child Health (MCH) community program(e.g. Kiri class, outreach, health campaign)? Please use this space to provide any additional feedback or comments.

Thank you so much for
your help!

កម្រងសំណួរស្ទង់មតិ

ជម្រាបសួរ! ការស្ទង់មតិ នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយតម្លៃគម្រោងផ្នែកគាំពារមាតា និងទារក នៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។ ការឆ្លើយតបដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកនឹងជួយកែលម្អការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមលើសុខភាពមាតា និងទារក និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនាពេលអនាគត។

ការស្ទង់មតិនេះមានសំណួរចំនួន 40 ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចចំណាយពេលប្រហែល 30 នាទីដើម្បីបញ្ចប់។

ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត ហើយអ្នកអាចដកខ្លួនបានគ្រប់ពេលដោយគ្មានផលវិបាកអ្វីទាំងអស់។

ការឆ្លើយតបត្រូវបានប្រមូលដោយអនាមិក ហើយទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែគោលបំណងស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់យ៉ាងតឹងរឹង ហើយការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវនឹងត្រូវបានបង្ហាញតែក្នុងទម្រង់មួយដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។

យើងសុំឱ្យអ្នកឆ្លើយសំណួរនីមួយៗដោយភាពស្មោះត្រង់។

មិនមានការរឹតបន្តឹងជាក់លាក់ណាមួយទេ ហើយចម្លើយដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នកនឹងរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការស្រាវជ្រាវនេះ។ សូមអរគុណដោយស្មោះចំពោះការចំណាយពេលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះ ទោះបីជាអ្នកមានកាលវិភាគមាញឹកក៏ដោយ។

*ចំណាំ៖ កម្រងសំណួរនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬមានបទពិសោធន៍សម្រាលកូនក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង (ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣) នៅខេត្តរតនគិរី។

ជំងឺគ្រុន-១៩?

1. មិនពេញចិត្តណាស់
2. មិនពេញចិត្ត
3. ធម្មតា
4. ពេញចិត្ត
5. ពេញចិត្តណាស់

2. តើសេវាគ្រួសារមួយណាដែលអ្នកបានទទួលពីនិមនករ ឆ្នាំ 2021 ដល់និមនករ ឆ្នាំ 2023?

(បង្ហាញអាចមានច្រើន)

- ☐ ថ្នាក់សិក្សា KIRI (ឧទាហរណ៍: សូមមើលទៅសំណួរ 2-1)
- ☐ យុទ្ធនាការសុខភាព (ការដើរជាមួយគ្នា, ការប្រកួតប្រជែងពាក្យស្លោកនៃយុទ្ធនាការសុខភាព, ចំនាយពេលវេលាថ្ងៃនៃការសិក្សាថ្នាក់ KIRI)
- ☐ សេវាផ្សព្វផ្សាយ (Outreach service)
- ☐ មើលវីដេអូយុទ្ធនាការ ការថែទាំសុខភាពមាតានៅលើទូរទស្សន៍ដែលដាក់នៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំរបស់មណ្ឌលសុខភាព
- ☐ ការស្តាប់ខ្លឹមសារសំឡេងស្តីពីការគ្រួសារ ការថែទាំមុនពេលសម្រាល និងក្រោយពេលសម្រាល និងការគ្រប់គ្រងអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈឧបករណ៍បំពង់សំឡេងប្រចាំភូមិ ឬមណ្ឌលថែទាំសុខភាព
- ☐ ខ្ញុំមិនបានទទួលសេវាណាមួយទេ

2-1. តើអ្នកធ្លាប់ចូលរួមក្នុង 'ក្រុមម្តាយចេះជួយខ្លួនឯង (SHG)' ដែលជាផ្នែកមួយនៃថ្នាក់ KIRI ដែរឬទេ?

1. បាទ/ចាស (ឧទាហរណ៍: សូមមើលទៅសំណួរ 2-2)
2. ទេ (ឧទាហរណ៍: សូមមើលទៅសំណួរ 3)

2-2. តើអ្នកចូលរួមក្នុង 'ក្រុមម្តាយចេះជួយខ្លួនឯង (SHG)' ដែលជាផ្នែកមួយនៃថ្នាក់ KIRI ដែរឬទេ ឥឡូវនេះ?

1. បាទ/ចាស
2. ទេ

3. តើសេវាផ្នែកសុខភាពមាតា និងទារក (MCH) អ្វីខ្លះដែលអ្នកបានទទួលពីនិមនករ ឆ្នាំ 2021 ដល់និមនករ ឆ្នាំ 2023? (បង្ហាញអាចមានច្រើន)

- ☐ ការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាល (ANC)
- ☐ សេវាសម្រាលកូន
- ☐ ការថែទាំក្រោយសម្រាល (PNC)
- ☐ ទេ, ខ្ញុំពុំបានទទួលសេវាអ្វីណាមួយទេ. (ឧទាហរណ៍: សូមមើលទៅសំណួរ 3-1)

3-1. ប្រសិនបើទេ តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនបានទទួលសេវាផ្នែកសុខភាពមាតា និងទារក MCH? (បង្ហាញអាចមានច្រើន)

1. ការចំណាយថ្លៃពេក (Payment is very high)

ផ្នែកទី២. ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ផ្នែកនេះ ជាផ្នែកដែលប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមូលដ្ឋានអំពីម្នាក់ និងគ្រួសាររបស់ម្នាក់។

* ខ្ញុំចង់ឱ្យម្នាក់ឆ្លើយចូលរួមចំណែកក្រោមអំពី ព័ត៌មានរបស់ម្នាក់.

1. តើម្នាក់រៀនបាន ឬសំបុត្រគ្រឹមកម្រិតណាដែរ?
 - 1 មិនបានរៀនទេ
 - 2 បឋមសិក្សា
 - 3 អនុវិទ្យាល័យ
 - 4 វិទ្យាល័យ
 - 5 សកលវិទ្យាល័យ ឬខ្ពស់ជាងនឹង

2. តើម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារជាតិអ្វី?
 - ☐ ខ្មែរ
 - ☐ ទំពួន
 - ☐ បារាយ
 - ☐ គ្រីង
 - ☐ គ្រួសារជាតិភាគតិចផ្សេងទៀត (សូមរៀបរាប់: _____)

3. តើម្នាក់កាន់សាសនាអ្វី?
 - ☐ សាសនាព្រះពុទ្ធ
 - ☐ សាសនាគ្រិស្ត
 - ☐ សាសនាអ៊ីស្លាម
 - ☐ សាសនាហិណ្ឌូ
 - ☐ ផ្សេងទៀត(សូមរៀបរាប់: _____)

4. ស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ម្នាក់៖
 - ☐ រៀបការ (៖សូមរំលងទៅសំណួរ 10-12)
 - ☐ លែងលះ (៖សូមរំលងទៅសំណួរ 13)
 - ☐ មេម៉ាយ/ ពោះម៉ាយ (៖សូមរំលងទៅសំណួរ 13)

5. តើម្នាក់រៀបការនៅអាយុប៉ុន្មាន? _____ (ឆ្នាំ)

* ខ្ញុំចង់សួរម្នាក់អំពីស្ថានភាពម្នាក់ផ្ទះម្នាក់. I would like you to answer about your household.

6. តើស្ថានភាពការងាររបស់ម្នាក់ផ្ទះរបស់ម្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ?
 - 1 Regular employee បុគ្គលិកធ្វើការជាម្នាក់
 - 2 បុគ្គលិកការងារក្រៅម៉ោង, កម្មករពេលប្រចាំថ្ងៃ (Day laborer)
 - 3 គេស៊ីខ្លួនឯង
 - 4 ធិរិយោជក
 - 5 គ្មានការងារធ្វើ
 - 6 មិនដឹង

7 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

7. ចំណូលរបស់អ្នកផ្ទះរបស់អ្នក ក្នុងមួយខែអាចរកបានប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរ (គិតជាលុយសុទ្ធ) ?

_____ គិតជាលុយរៀល ក្នុងមួយខែ

3-1. តើការងាររបស់អ្នកផ្ទះរបស់អ្នក បានទទួលជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬ ប្រភេទនៃការងារនេះមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃអ្វីនោះទេ?

- 1 ប្រាក់សុទ្ធ
- 2 ប្រាក់ និង អំណោយ
- 3 មានតែអំណោយ
- 4 មិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃ

8. តើអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកមានប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌ ដែរឬទេ?

1. បាទ/ចាស មាន
2. ទេ មិនមានទេ
3. មិនដឹងទេ

9. តើអ្នកបានបង់ថ្លៃសេវាផ្នែកសុខភាពម្តាយ និងទារកដោយរបៀបណា?

(ថែទាំថ្លៃពោះមុនសម្រាល, សម្រាលកូន, ថែទាំក្រោយសម្រាល) (ចម្លើយអាចមានច្រើន)

1. ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណគ្រឹក្រ ប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
2. ប័ណ្ណ ប ស ស (NSSF) ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម (SHI)
3. ប្រើលុយខ្លួនឯងSelf-financed(ឧ. លុយប្រាក់ខែ, ប្រាក់ហោប៉ៅ, ប្រាក់សន្សំ, លុយបានមកពីការលក់ដូរទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន...)
4. ខ្ចីលុយអ្នកដទៃ ឬ កម្ចីផ្សេងៗ (ឧ. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, កម្ចីពិធនាគារ, លុយក្រៅផ្លូវការ, លុយរាប់ប្រចាំថ្ងៃ...)
5. កញ្ចប់លុយមូលនិធិក្នុងសហគមន៍Village(Community) Health Fund, លុយបានពីមិត្តភក្តិ ឬ សាច់ញាតិឱ្យ(gift from friends of relatives)
6. ទទួលបានជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល, ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ, ឬស្ថាប័នដទៃផ្សេងទៀត
7. មិនបង់លុយ
8. ផ្សេងទៀត(សូមបញ្ជាក់): _____

* ផ្តល់ឱ្យអ្នកឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមអំពី កូនៗរបស់អ្នក៖

10. តើអ្នកមានកូនប៉ុន្មាននាក់? _____

11. សូមបំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការខាងក្រោម

ទៅតាមកូនរបស់អ្នកដែលទើបនឹងសម្រាលក្រោយគេបំផុត។

ជាតិ នីមួយៗ នៅក្នុង តារាង	ភេទ (ប/ស)	ទីពេល កើត (ខែ)	ថ្ងៃនៃម្ចាស់ លើក ទី ១ នៃ ថ្ងៃ	ទារកមានបញ្ហាសុខភាព ក្រោយពីសម្រាលបាន៦ សប្តាហ៍%		អាយុត្រី (គិតជាសប្តាហ៍)			ប្រភេទនៃការសម្រាល		
				បា	ទេ	ត្រង់ នៃ 37- 42wk	មិនត្រង់ នៃ <37wk	លើសនៃ >42wk	ធម្មតា ជាតិ	វេជ្ជសាស្ត្រ	ផ្សេងៗ ស្រប បញ្ជាក់
1				①	②	①	②	③	①	②	

ផ្នែកទី ៣. សេវាផ្នែកសុខភាពមាតា និងទារក

ក្នុងផ្នែកនេះ ពួកយើងចង់សួរម្ចាស់អំពីបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់ លើផ្នែក ថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាល, ផ្នែកសម្រាល និងថែទាំក្រោយសម្រាល។ សូមឆ្លើយតាមបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់ដែលមានមានផ្ទៃពោះចុងក្រោយ/ឬបទពិសោធន៍ដែលម្ចាស់មានកូនអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ។

ការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាល៖ ជាភារកិច្ចសេវាថែទាំសុខភាពដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យស្ត្រីជាម្តាយមានសុខុមាលភាពល្អ និងប្រាកដថាស្ត្រីអាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីគ្រូមសម្រាលបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ តាមរយៈការរកឃើញ និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពពេញមួយអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ការថែទាំមុនពេលសម្រាលអាចធ្វើអោយសុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ចាស់ប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតទារកដែលមានទម្ងន់ទាប និងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀត។



1. តើម្ចាស់បានទៅទទួលសេវាថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលបាន ប៉ុន្មានដង? _____ (ដង)
2. ប្រសិនបើម្ចាស់ឆ្លើយថា បានទៅទទួលសេវា តើជាដងបួនដង តើអ្វីជាហេតុផលដែលម្ចាស់បានទទួលសេវាតិចជាងបួនដង?
 1. ការចំណាយថ្លៃពេក (Payment is very high)
 2. មិនបានដឹងពីសេវាថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាល
 3. សមាជិកគ្រួសារមិនចង់ឱ្យទៅទទួលសេវានេះ

- 8 ថ្កាស់ថ្កាស់អាស៊ីកហ្សូលីក
- 9 ពិនិត្យមើលភាគច្រើនរបស់ទារក
- 10 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)
- 11 មិនដឹង

6. តើអ្នកពេញចិត្តនឹងសេវាថែទាំផ្ទះពោះមុនសម្រាលដែលអ្នកបានទទួលឬទេ?

- 1 បាទ (សូមបន្តទៅសំណួរ 6-1)
- 2 ទេ (សូមបន្តទៅសំណួរ 6-2)

6-1. តើអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកពេញចិត្ត សេវានោះ?

(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- 1 គ្រូពេទ្យមើលថែអ្នកបានល្អ
- 2 បុគ្គលិកនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានភាពរស់រវើកទាក់ទាក់
- 3 មិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ច្រើន
- 4 ជឿជាក់លើជំនាញបច្ចេកទេសរបស់បុគ្គលិកនៅមូលដ្ឋានសាធារណៈ
- 5 ផ្សេងៗ: _____ (សូមបញ្ជាក់: _____)

6-2. តើមូលហេតុផ្សេងៗ អ្វីខ្លះ ដែលអ្នកមិនពេញចិត្តអំពីការទទួលសេវានៅទីនោះ?

(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- 1 បុគ្គលិកសុខាភិបាលមានភាពមិនគួរសម/ពេលខ្លះស្លេកចង់ឆ្លើយ
- 2 អគារគ្មានអនាម័យ
- 3 សម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាស់ៗ
- 4 គម្លែងនៃការផ្តល់សេវាថ្លៃ
- 5 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

7. តើអ្នកសម្រាលកូននៅឯណា?

- 1 ប៉ុស្តិ៍សុខភាព
- 2 មណ្ឌលសុខភាព
- 3 មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក
- 4 មន្ទីរពេទ្យខេត្ត
- 5 ពេទ្យឯកជន
- 6 ផ្ទះ
- 7 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

5. តើអ្នកបង់ថ្លៃសេវាសម្រាលកូនដោយរបៀបណា (អាចមានចម្លើយច្រើន)?

1. ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
2. National social security card, National Social Security Fund(NSSF), Social Health Insurance(SHI)

3. ប្រើលុយខ្លួនឯងSelf-financed(ឧ. លុយប្រាក់ខែ, ប្រាក់ហោប៉ៅ, ប្រាក់សន្សំ, លុយបានមកពីការលក់ដូរទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន...)
4. ខ្ចីលុយអ្នកដទៃ ឬ កម្ចីផ្សេងៗ (ឧ. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, កម្ចីពីធនាគារ, លុយក្រៅផ្លូវការ, លុយរាប់ប្រចាំថ្ងៃ...)
5. កញ្ចប់លុយមូលនិធិក្នុងសហគមន៍Village(Community) Health Fund, លុយបានពីមិត្តភក្តិ ឬ សាច់ញាតិឱ្យ(gift from friends of relatives)
6. ទទួលបានជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល, គ្នាភ័ង្គអង្គការសហប្រជាជាតិ, ឬស្ថាប័នដទៃផ្សេងទៀត
7. មិនបង់លុយ
8. ផ្សេងទៀត(សូមបញ្ជាក់): _____

7. នរណាបានជួយអ្នកពេលសម្រាលកូន?

- [មន្ត្រីសុខាភិបាល] (☞សូមបន្តទៅសំណួរទី 8)
1. វេជ្ជបណ្ឌិត
 2. គិលានុបដ្ឋាក/ឆ្មប
 3. Auxiliary midwife
 - [អ្នកដទៃទៀត ឬ គ្មាន] (☞សូមបន្តទៅសំណួរទី 7-1)
 4. ឆ្មបបូរាណ(Traditional birth attendant)
 5. សាច់ញាតិ/ក្រុមគ្រួសារ/មិត្តភក្តិ
 6. ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់ _____)
 7. គ្មាននរណាម្នាក់ជួយទេ

7-1. ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស ចម្លើយពី4-7

តើមូលហេតុចម្បងពីខ្លួនដែលមិនទទួលបានជំនួយផ្នែកសម្រាលពីអ្នកសម្រាលកូនដែលមានជំនាញ?

1. ការចំណាយថ្លៃពេក (Payment is very high)
2. មិនបានដឹងពីសេវាសម្រាលកូន
3. សមាជិកគ្រួសារមិនចង់ឱ្យទៅទទួលសេវានេះ
4. ពិបាកក្នុងការទៅទទួលសេវា (ទីកន្លែងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ, ពិបាកទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ, កន្លែងផ្តល់សេវា មិនបានបើក)
5. ពុំបានគិតថាសេវាដឹង មានសារៈសំខាន់
6. មិនជឿជាក់លើគុណភាពនៃការផ្តល់សេវា នៅមូលដ្ឋានសាធារណៈ
7. ខ្លួនមានពិការភាព
8. មានការពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង
9. មានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-១៩
10. ហេតុផល ប្រពៃណី/ប្លែកៗ
11. ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

8. តើអ្នកពេញចិត្តនឹងសេវាសម្រាល ដែលអ្នកបានទទួលដែរឬទេ?

- 1 បាទ (☞សូមទៅសំណួរទី 9-1)
- 2 ទេ (☞សូមទៅសំណួរទី 9-2)

8-1. តើអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកពេញចិត្តសេវាសម្រាល?
(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- 1 មន្ត្រីសុខាភិបាលមើលថែអ្នកបានល្អ
- 2 មន្ត្រីសុខាភិបាលមានភាពរស់រវើកទាក់ទាក់
- 3 មិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើន
- 4 ជឿជាក់លើជំនាញរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល
- 5 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

8-2. តើអ្វីជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនពេញចិត្តសេវាសម្រាលនៅទីនោះ?
(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- 1 បុគ្គលិកសុខាភិបាលមានភាពមិនគួរសម/ពេលខ្លះសួរមិនចង់ឆ្លើយ
- 2 អគារគ្មានអនាម័យ
- 3 សម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាស់ៗ
- 4 គម្លែងនៃការផ្តល់សេវាថ្លៃ
- 5 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

ការថែទាំក្រោយសម្រាល: ការថែទាំក្រោយសម្រាល គឺជាការថែទាំដែលផ្តល់ដល់ម្តាយ និងទារកទើបនឹងកើតក្រោយពេលសម្រាល។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក និងទារកទើបនឹងកើតរបស់អ្នក ដែលអ្នកត្រូវទទួលបានការថែទាំក្រោយសម្រាល។
ការថែទាំក្រោយសម្រាលអាចជួយកំណត់ពីផលវិបាកដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទូទៅ គាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគក្រោយពេលសម្រាលកូន និងគាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារការសម្រាលមិនគ្រប់រយ ឬទារកកើតមកទម្ងន់ទាប។ (48 시간 병원에서 결과를 지켜보는 것)

9. បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនចុងក្រោយរបស់អ្នក តើអ្នកមានបានទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលឬទេ?

- 1 បាទ(ៗសូមបន្តទៅសំណួរទី 11)
- 2 ទេ(ៗសូមបន្តទៅសំណួរទី 9-1)

9-1. ប្រសិនបើទេ,

តើអ្វីជាមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកមិនបានទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាល?

1. ការចំណាយថ្លៃពេក (Payment is very high)
2. មិនបានដឹងពីសេវាថែទាំក្រោយ
3. សមាជិកគ្រួសារមិនចង់ឱ្យទៅទទួលសេវានេះ
4. ពិបាកក្នុងការទៅទទួលសេវា (ទីកន្លែងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ, ពិបាកទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ, កន្លែងផ្តល់សេវា មិនបានបើក)
5. ពុំបានគិតថាសេវានឹង មានសារៈសំខាន់
6. មិនជឿជាក់លើគុណភាពនៃការផ្តល់សេវា នៅមូលដ្ឋានសាធារណៈ
7. ខ្លួនមានពិការភាព
8. មានការពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង

9. មានការផ្ទេរដល់ដីកូរ៉េខ្មែរ
10. ហេតុផល ប្រពៃណី/ឃ្លៀងឃ្លា
11. ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

10. តើអ្នកបានទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលពីមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលដែរទេ?

1. បាទ
2. ទេ

11. តើអ្នកបានទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាល បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនបាន៤៨ម៉ោង ដែរឬទេ?

1. បា បានទទួល
2. ទេ មិនបានទទួលទេ

6. តើអ្នកបង់លុយថ្លៃសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលដោយរបៀបណា (ចម្លើយអាចមានច្រើន)?

1. ប្រើប្រាស់បណ្ណាមូលនិធិសមធម៌(Health Equity card), Health Equity Fund(HEF)
2. National social security card, National Social Security Fund(NSSF), Social Health Insurance(SHI)
3. ប្រើលុយខ្លួនឯងSelf-financed(ឧ. លុយប្រាក់ខែ, ប្រាក់ហោប៉ៅ, ប្រាក់សន្សំ, លុយបានមកពីការលក់ដូរទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន...)
4. ខ្ចីលុយអ្នកដទៃ ឬ កម្ចីផ្សេងៗ (ឧ. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, កម្ចីពិធនាគារ, លុយក្រៅផ្លូវការ, លុយរាប់ប្រចាំថ្ងៃ...)
5. កញ្ចប់លុយមូលនិធិក្នុងសហគមន៍Village(Community) Health Fund, លុយបានពីមិត្តភក្តិ ឬ សាច់ញាតិឱ្យ(gift from friends of relatives)
6. ទទួលបានជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល, គ្នាភ័ង្គអង្គការសហប្រជាជាតិ, ឬស្ថាប័នដទៃផ្សេងទៀត
7. មិនបង់លុយ
8. ផ្សេងទៀត(សូមបញ្ជាក់: _____)

12. តើអ្នកពេញចិត្ត នឹងសេវាថែទាំក្រោយសម្រាល ដែលអ្នកបានទទួលឬទេ?

- 1 បាទ (សូមទៅសំណួរទី 12-1)
- 2 ទេ (សូមទៅសំណួរទី 12-2)

12-1.

តើអ្វីជាមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកពេញចិត្តការទទួលសេវាក្រោយសម្រាលនៅទីនោះ?
(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- 1 មន្ត្រីសុខាភិបាលមើលថែអ្នកបានល្អ
- 2 មន្ត្រីសុខាភិបាលមានភាពស្រឡាត់ស្រាវ
- 3 មិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើន
- 4 ឆ្លើយតបលើជំនាញរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល
- 5 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

12-2.

តើអ្វីជាមូលហេតុចម្បងដែលម្តងម្កាលពេញចិត្តនឹងការទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលនៅទីនោះ? (ចម្លើយអាចមានច្រើន)

1

បុគ្គលិកសុខាភិបាលមានភាពមិនគួរសម/ពេលខ្លះស្ត្រីមិនចង់ឆ្លើយ

2 អគារគ្មានអនាម័យ

3 សម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាស់ៗ

4 គម្លែងនៃការផ្តល់សេវាថ្លៃ

5 ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)

ផ្នែកទី 4. ចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្ត (KAP) របស់ មន្ត្រីផ្នែកសុខភាពមាតា និងទារក(MCH)
បន្ទាប់មកទៀត ខ្ញុំចង់សួរម្នាក់ពីកម្រិតនៃការយល់ដឹង អាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្តរបស់ម្នាក់ទាក់ទងនឹងសុខភាពមាតា និងទារក។ សូមឆ្លើយតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការមានផ្ទៃពោះចុងក្រោយរបស់ម្តង និង/ឬបទពិសោធន៍ដែលម្តងមានកូនអាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ។

- តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវទទួលបានការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលអប្បបរមា ចំនួនប៉ុន្មានដង? _____ (ដង)
- តើផលវិបាកអ្វីខ្លះអាចកើតឡើងនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ? (ចម្លើយអាចមានច្រើន)
 - ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស
 - វិលមុខ ឬអស់កម្លាំង
 - ឈឺក្បាលខ្លាំង
 - ស្រវាំងភ្នែក
 - ចុកពោះខ្លាំង
 - ហឺមខ្លាំង នៅដៃ ឬនៅមុខ
 - មានធ្លាក់វិសាលភាពពេញពីទ្វារមាស
 - ក្តៅខ្លួន
 - ទារកកម្រើកតិចៗ ឬមិនកម្រើក
 - មិនដឹង
 - ផ្សេងៗ(សូមបញ្ជាក់: _____)
- តើផលវិបាកអ្វីខ្លះអាចកើតឡើងអំឡុងពេលសម្រាល? (ចម្លើយអាចមានច្រើន)
 - ការឈឺពោះមិនទៅមុខ/ស្បូនឈប់បើកបង្គុំ (Labor does not progress)
 - ធ្លាក់ឈាមច្រើន Excessive bleeding
 - បែកលឿនមុនសម្រាល Water breaking early
 - បញ្ហាទងស្កកកែវទារក Problems with umbilical cord
 - ទារកមិនដកដង្ហើម Fetus not breathing
 - ទារកបង្ហាញទម្រង់មិនធម្មតា Malposition

7. មិនដឹង

8. ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់): _____

4. តើស្ត្រីកូនទទួលបានការថែទាំក្រោយសម្រាលប៉ុន្មានដង? _____ (ដង)

5. តើអ្នកគិតថាការថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ?

1. បាទ
2. ទេ

6. តើអ្នកនឹងណែនាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផ្សេងទៀត
ឱ្យទៅទទួលសេវាថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាលដែរឬទេ?

1. បាទ
2. ទេ

7. តើអ្នកគិតថា វាចាំបាច់ដែរឬទេ ដែលស្ត្រី គួរតែទៅសម្រាលកូននៅ មូលដ្ឋានសុខាភិបាល?

1. បា
2. ទេ

8. តើអ្នកនឹងប្រាប់ទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៃទីទៀត
ឱ្យទៅសម្រាលកូននៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែរឬទេ?

1. បា
2. ទេ

9. តើអ្នកលាងដៃ រាល់ពេល មុនអ្នកបំបៅកូនដោយទឹកដោះដែរឬទេ?

1. បា (សូមបន្តទៅសំណួរទី 10)
2. ទេ (សូមបន្តទៅសំណួរទី 9-1)

9-1. បើអត់ទេ តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនលាងដៃរាល់ពេល
មុនពេលអ្នកបំបៅកូនដោយទឹកដោះ? (ចម្លើយអាចមានច្រើន)

1. កង្វះគ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យ
2. កង្វះការអប់រំអំពីអនាម័យ
3. គ្មានប្លង់
4. សម្ពាធពីកន្លែងការងារ
5. បរិយាកាសក្នុងការរស់នៅ
6. បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៃការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកអនាម័យ

ផ្នែកទី 5. គំនិត និងទស្សនៈរបស់អ្នកចំពោះកម្មវិធីគាំពារមាតា និងទារក (MCH)

ជាចុងក្រោយ ផ្នែកនេះមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំគំនិត និងយោបល់របស់អ្នកលើសេវា MCH និងកម្មវិធីសហគមន៍របស់ MCH ។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នក នឹងជួយយើងឱ្យយល់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក

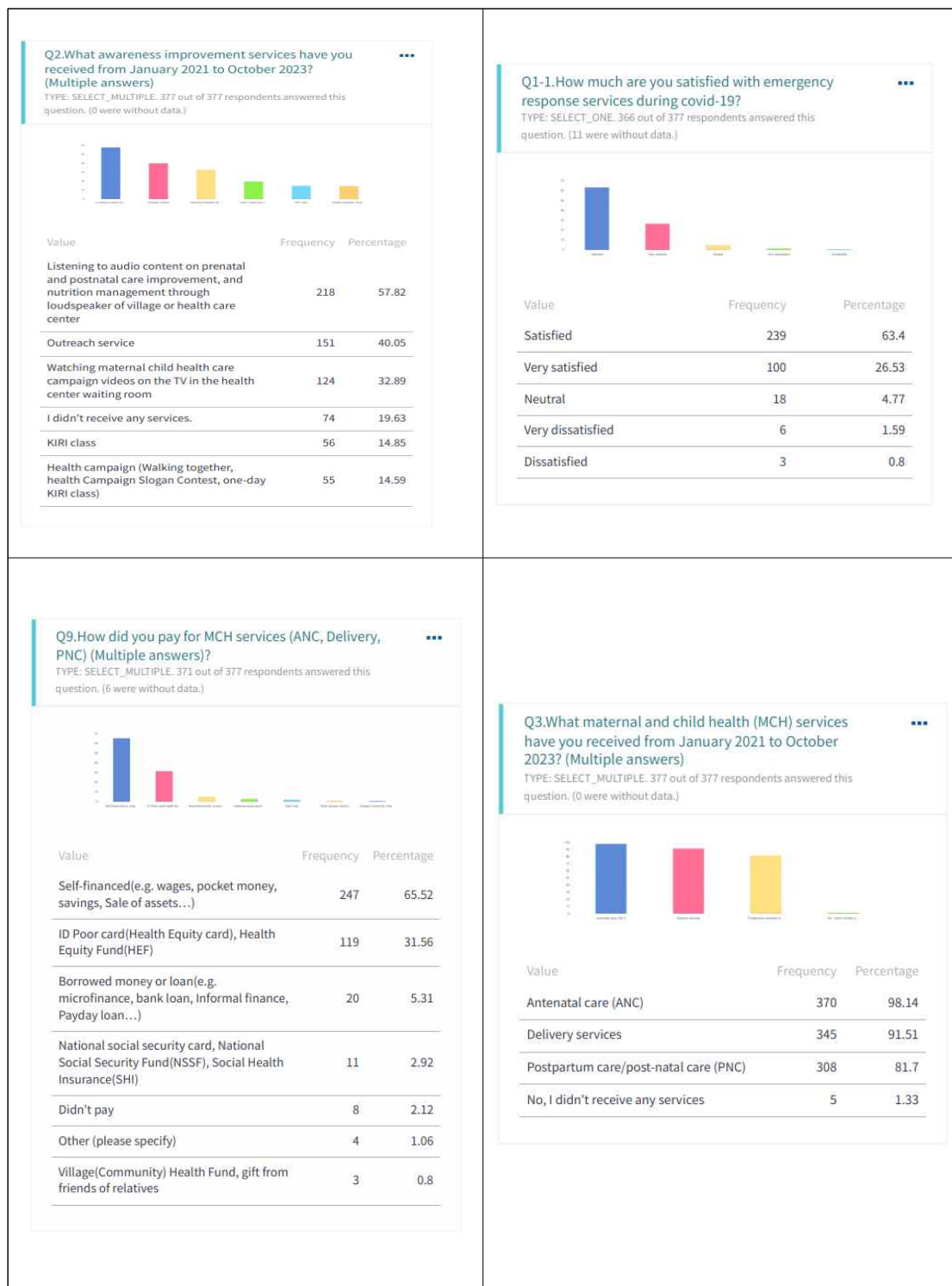
នឹងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ។
សូមឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក។

4. តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ ដែលអ្នកចង់ចែករំលែកអំពីកម្មវិធីសហគមន៍
របស់កម្មវិធីសុខភាពមាតា និងទារក (ឧ. ថ្នាក់គីរី ការផ្សព្វផ្សាយ យុទ្ធនាការសុខភាព)?
សូមផ្តល់មតិកែលម្អ ឬមតិយោបល់បន្ថែម ដែលអ្នកមាន ដាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នក!

□ 설문 주요 결과

1. 전반적인 모자보건 의료 이용 및 인식 개선 관련



2. ANC 관련 문항

Q1.How many times did you attend ANC (Antenatal Care)?(times)

TYPE: INTEGER. 371 out of 377 respondents answered this question. (6 were without data.)

Mean	Median	Mode	Standard deviation
4.95	5.00	4.00	2.02

Q2.If you answered fewer than four times, what is the reason you received the service less than four times?

TYPE: SELECT_ONE. 81 out of 377 respondents answered this question. (296 were without data.)

Value	Frequency	Percentage
Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)	27	7.16
Other (please specify)	21	5.57
Didn't know the ANC service	14	3.71
Didn't think the services were necessary	11	2.92
The COVID-19 pandemic	4	1.06
Payment is very high	2	0.53
Didn't trust the quality of the health facility	1	0.27
Have disabilities	1	0.27

Value	Frequency	Percentage
Difficult to access medical facilities (distance, transportation, not open)	27	7.16
Other (please specify)	21	5.57
Didn't know the ANC service	14	3.71
Didn't think the services were necessary	11	2.92
The COVID-19 pandemic	4	1.06
Payment is very high	2	0.53
Didn't trust the quality of the health facility	1	0.27
Have disabilities	1	0.27

Q6.Are you satisfied with the ANC services you received?

TYPE: SELECT_ONE. 371 out of 377 respondents answered this question. (6 were without data.)

Value	Frequency	Percentage
Yes	365	96.82
No	6	1.59

Value	Frequency	Percentage
Yes	365	96.82
No	6	1.59

Q6-1.What were the main reasons for your satisfaction? (Multiple answers)

TYPE: SELECT_MULTIPLE. 365 out of 377 respondents answered this question. (12 were without data.)

Value	Frequency	Percentage
They take care of me well	350	92.84
HF staff are friendly and considerable	281	74.54
HF staff have skill and can be trusted	161	42.71
Does not have to spend a lot of money	123	32.63
Other (please specify)	6	1.59

Value	Frequency	Percentage
They take care of me well	350	92.84
HF staff are friendly and considerable	281	74.54
HF staff have skill and can be trusted	161	42.71
Does not have to spend a lot of money	123	32.63
Other (please specify)	6	1.59

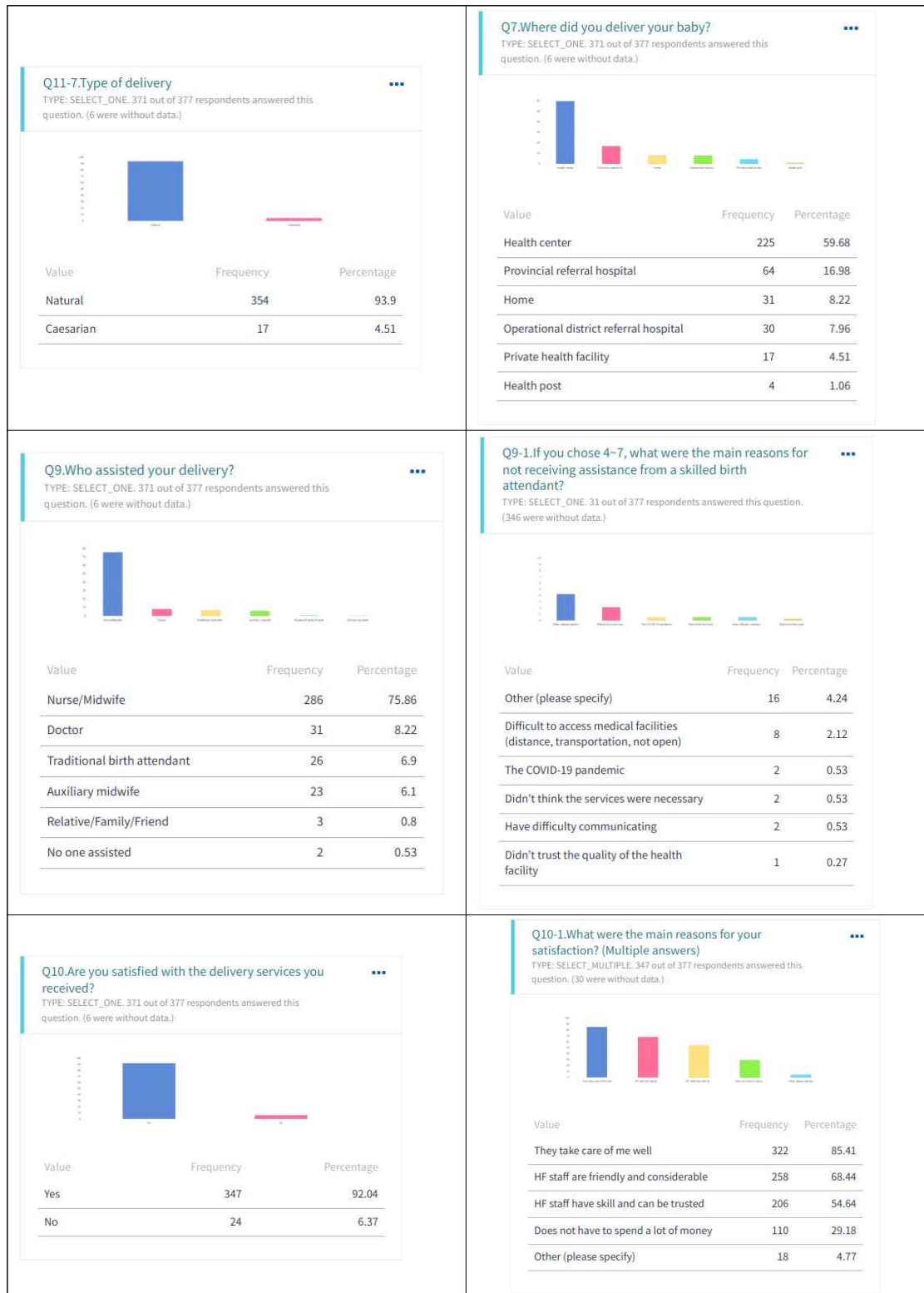
Q5.Do you think ANC (Antenatal Care) is necessary for pregnant women?

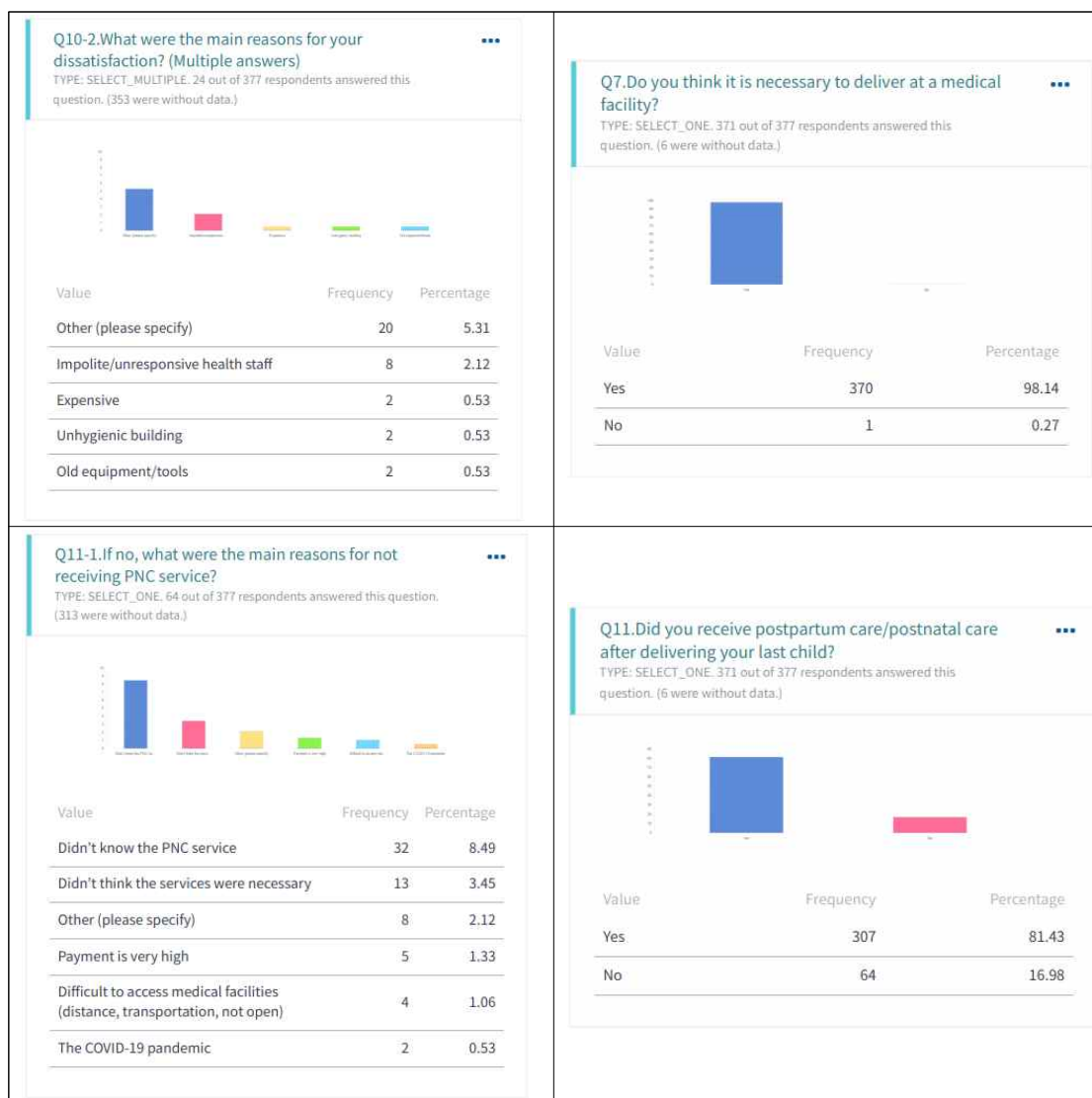
TYPE: SELECT_ONE. 371 out of 377 respondents answered this question. (6 were without data.)

Value	Frequency	Percentage
Yes	371	98.41

Value	Frequency	Percentage
Yes	371	98.41

3. Delivery와 PNC 관련





- 강용규. (2020) 캄보디아 ODA 수원마을 조성사업에 관한 사례 연구. 한국산학기술학회 논문지, 21(9), 548-558.
- 관계부처 합동 (2019) 캄보디아 국가협력전략
- 굿네이버스캄보디아, (2025) Retrieved from <https://gncambodia.org/>
- 메디포뉴스, (2022) 순천향대의료원 캄보디아 사업팀, 캄보디아 국왕 훈장 수훈 Retrieved from <https://www.medifonews.com/news/article.html?no=169334>
- Ambuehl, B., Tomberge, V. M. J., Kunwar, B. M., Schertenleib, A., Marks, S. J., & Inauen, J. (2021). The role of psychological ownership in safe water management: A mixed-methods study in Nepal. *Water*, 13(5), 589.
- Cambodia Development Committee, CDC (2013) Cambodia municipality and province investment information 2013
- Chham, S., Buffel, V., Van Olmen, J., Chhim, S., Ir, P., & Wouters, E. (2022) The cascade of hypertension care in Cambodia: evidence from a cross-sectional population-based survey. *BMC Health Services Research*, 22(1), 838.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- DHS (2015) Cambodia Demographic and Health Survey 2014
- DHS(2023) Cambodia Demographic and Health Survey 2021-2022
- MoH, Cambodia (2019) Guideline for implementation the service package of Antenatal Care Delivery and Post natal Care
- MoH, Cambodia (2019) National Safe Motherhood Clinical Management Protocols For Referral Hospitals
- Fresh News, (2025) “의사 팀의 도움으로 라타나키리 주, 베른 사이 지역의 한 여성이 보트 위에서 아기를 성공적으로 출산했습니다.” Retrieved from <https://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/373381-2025-01-16-08-10-15.html>
- Kingdom of Cambodia (2014) National Strategic Development Plan 2014-2018
- Kingdom of Cambodia (2016) HEALTH STRATEGIC PLAN 2016-2020
- KOICA (2017) KOICA 분야별 중기전략 2016-2020
- KOICA (2018a) 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 예비조사 결과보고서

KOICA (2018b) 캄보디아 동북부 소외지역 산모와 신생아 보건의료서비스 품질강화사업 심층기
 획조사 결과보고서

KOICA (2018) 파테말라 웨웨떼낭고주 국립병원 모자보건 역량강화 사업, 종료평가 보고서

KOICA (2020a) 탄자니아 차니카 모자보건 서비스 개선사업, 종료평가 보고서

KOICA (2020b) 2020년 캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 (2019-2023/700만불) 연
 차점검 결과 보고

KOICA (2021) 파라과이 산빠블로 모자병원 역량강화 사업, 종료평가 보고서

KOICA (2021) 필리핀 WHO 다바오 지역보건 체계강화 모자보건 사업

KOICA (2022) 기초 모자보건 분야 종합분석보고서

*MOH of Cambodia (2016) Fast Track Initiative Road Map for Reducing Maternal and
 Newborn Mortality 2016-2020*

National Institute of Statistics, NIS (2018) Cambodia Socio-Economic Survey 2017

*National Institute of Statistics, NIS (2020) General Population Census of the Kingdom
 of Cambodia 2019*

*Suzuki, A., Matsui, M., Tung, R., & Iwamoto, A. (2021) "Why did our baby die soon
 after birth?"—Lessons on neonatal death in rural Cambodia from the
 perspective of caregivers. Plos one, 16(6), e0252663.*

UN (2025) Sustainable Development Retrieved from <https://sdgs.un.org/goals>

*UNFPA (2017) In Cambodia, push to end maternal deaths in remote areas, Retrieved
 f r o m
[https://www.unfpa.org/news/cambodia-push-end-maternal-deaths-remote-are
 as](https://www.unfpa.org/news/cambodia-push-end-maternal-deaths-remote-areas)*

*World Bank (2025) Cambodia Nutrition Project, Retrieved from
<https://bankinformationcenter.org/en-us/project/cambodia-nutrition-project/>*

*WHO (2014) Success Factors for Women's and Children's Health, World Health
 Organization.*

*Yanagisawa, S., Soyano, A., Igarashi, H., Ura, M., & Nakamura, Y. (2015) Effect of a
 maternal and child health handbook on maternal knowledge and behaviour: a
 community-based controlled trial in rural Cambodia. Health policy and
 planning, 30(9), 1184-1192.*

1. 건축

□ 라따나끼리 주립병원

- 신축된 건물 상태는 깨끗했고, 보수가 필요한 부분은 없었으며 진찰실, 검사실, 분만실, 분만 후 병실 등 분만의 필수 과정에 따라 공간 구분이 되어 있었음
- 분만 후 병실에는 별도의 화장실과 샤워실이 구비되어 있어 출산한 산모들이 위생적이고 안전하게 사용 가능함
- 병원 규모와 진료 수준에 맞게 센터 내 분만실을 신생아 전용 병상(미숙아 등)으로 활용하고 있었음. 다만, 이에 따라 성인 시설에 대한 공간이 비효율적으로 이용되는 현상이 있었음

□ 보건소

- 신축된 모자보건센터는 보건소에서 인접한 곳에 지어져 환자들이 적절하게 활용가능할 수 있도록 함. 전반적으로 시설 상태는 양호하여, 보수가 필요한 부분은 없었음. 진찰실, 검사실, 분만실, 분만 후 병실 등 공간 구분이 잘 되어 있었음. 화장실과 샤워실이 구비되어 있어 출산한 산모들이 위생적이고 안전하게 사용가능한 상태임
- 오춤 보건소에서는 식사를 준비할 수 있는 공간이 없어 이러한 시설의 개선 필요성을 제시함

2. 기자재 및 소모품

□ 공통사항

- 제공받은 환자 감시 장치를 효과적으로 사용하여 환자의 활력징후를 측정하고 있었음
- 카테터들의 소모품들은 개별 포장된 상태로 보관되어 있었으며, 충분히 공급받고 있다고 함
- 옥시토신과 리도카인 등의 약제들에 대해서 충분히 공급받고 있다고 보고함
- 백신은 해외 원조와 주정부 모두에서 공급받고 있다고 보고함

□ 라따나끼리 주립병원

- 양압환기기 등 일부 기자재들의 경우 해당 병동이 신생아실로만 활용되면서 적극적으로 활용되지 못하고 있었음
- 지원받은 초음파 기계는 고장 없이 안정적으로 사용하고 있었으며, 태아 심음 측정기, 도플러(Doppler), 워머(Warmer) 등 기증 장비가 임상 현장에서 실질적으로 유용하게 사용 중임

- 기증받은 구급차는 고위험 분만 시 상급 병원 이송, 외상 사고 발생 등 여러 가지 상황을 포함하여 월 10회 출동으로 지역 내 응급의료 서비스를 일정 수준 제공 중임. 야간 출동 시에 도로에서 개를 치는 경우가 많아 범퍼가 파손되었음에도 수리에 수일이 소요되어 그대로 운용 중임
- 기증받은 구급차가 차체가 낮아 비포장도로를 갈 때 충격과 차량 손상이 발생하고, 2륜 구동 이어서 우기 때 운행하기가 어려움.
- 구급차 내부에 휴대용 산소측정기와 혈압기 정도만 구비해두고 있어서, 이송 중 환자 관찰 모니터링이 필요함. 구급차 체크리스트에 장비 구성뿐만 아니라 관리 및 유지보수 지침을 추가할 필요가 있겠으며 출동 이후에도 장비 점검을 체계화하는 것이 필요함

□ 오츄م 보건소

- 분만대 한 개는 사용하지 않고 있었음
- KOICA에서 제공받은 응급키트가 준비되어 있었으며, 이에는 MgSO₄ 투약시의 매뉴얼 등 자간증 등 응급상황에서 필요한 내용들이 준비되어 있었음
- 옥시토신을 냉장고에 보관하며, 냉장고의 온도에 대해서 안에 온도계를 비치하였으나, 온도대장을 작성하고 있지는 않음
- 백신 냉장고의 경우 적절한 범위의 온도가 유지되는 상태로 사용하고 있었고 온도 대장이 있음
- 도플러의 배터리가 쉽게 닳고 배터리를 교체하기가 어려워서 도플러 한 개를 사용하지 못하고 있었음

□ 안동미아 보건소

- 안동미아 보건소의 경우에는 지원받은 분만대를 모두 사용하고 있었음
- KOICA에서 제공받은 응급키트가 준비되어 있었으며, 그에 대한 매뉴얼 등이 준비되어 있었음
- 옥시토신을 냉장고에 보관하고 있었으며, 냉장고의 온도에 대해 온도계로 측정하고 있지는 않았음
- 도플러 기기가 고장이 나서 한 개를 사용하지 못하고 있었음
- 산소의 경우 충전상태를 유지하고 있었음
- 일본에서 받은 구급차와 중국에서 받은 구급차 2대가 있었으며, 그 중 중국에서 받은 구급차는 고장나서 사용하지 못하는 상태였고, KOICA가 수리비용을 지원한 일본에서 받은 구급차 한 대로 주변 보건소 3개소를 지원하고 있었음

○ 초음파 기계가 지원되어 있어 유용하게 활용하며 환자들의 경험을 증진시키고 있었음

□ 낚땡 보건소

○ 시설 지원은 받지 못하였고, 기자재 지원만 받은 상태임

○ 지원받은 새 분만대를 사용하고 있었고 기존에 사용하던 분만대는 다른 지소에 대여하였다고 보고함

○ 냉장고 한 개가 고장나서 백신과 옥시토신을 냉장고에 혼합보관하고 있었으며, 온도대장은 없음

○ 도플러 기기를 효과적으로 사용하고 있었음

○ KOICA에서 지원받은 물품은 아닌 portable 초음파를 사용하고 있었음

○ 구급차를 코이카에서 지원받아 하나를 사용하고 있고, 주정부에서 지원받은 구급차는 사용하지 못하고 있었다. 구급차의 경우 산소가 충전되어 있었으며, 응급약품들의 경우에는 KOICA에서 더이상 지원받지는 않고 자체적으로 충족하고 있었음

○ 구급차에 함께 있는 약품으로 Diazepam, propacetamol등의 약제들이 비치되어 있었으나 사용 메뉴얼은 함께 제공되어 있지는 않았음

1. 연구 목적

- 소외지역 주민의 필수 모성, 신생아 서비스 접근 개선과 관련된 성과지표에 대해서 사업이 시행된 기간(2019~2022년) 전후의 시간에 따른 변화를 정량적으로 분석하여 엄밀한 사업의 효과성을 검증함

2. 데이터 수집

- 라파나끼리 주 보건당국과 협의하여 사업 시행 전, 사업 기간 내, 사업 종료 후의 분기별 성과 지표 데이터(National Health 를 확보하고 데이터 전처리를 수행함. 평가 대상 성과지표는 다음과 같음
- ① 분기별 4회 이상 산전 관리율: 매년 인구 총조사에서 추정된 임신 가능 여성 대비 4회 이상 산전관리 받은 임산부 비율
- ② 분기별 전문가에 의한 분만율: 분기별 출산 수 대비 의료전문가에 의한 분만 비율
- ③ 분기별 산후관리 받은 비율: PNC1(48시간 이내), PNC2(48시간-7일 이내), PNC3(6주), PNC4(8주)

3. 분석 방법

- 해당 사업 외 다른 변수가 평가 대상 성과지표에 미치는 영향을 통제하고, 시간에 따른 사업의 효과를 평가하기 위해서 준실험설계(quasi-experimental design) 중 하나인 단절적 시계열 분석 (Interrupted time series)을 적용하였음
- 사업 시행 전의 시간에 따른 경향을 파악하고, 사업이 시행됨에 따른 변화를 비교하여 사업의 효과를 검토함. 모든 분석은 R 분석 프로그램(version 4.3.3)을 활용함
- 데이터의 자기상관성, 계절성, 비정상성 가정을 만족하는지 검토한 후, 구간별 회귀모델(segmented regression model)을 적합하여 분석을 진행함. 해당 모델은 다음과 같이 정의함

$$\hat{Y}_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 TX_1 + \beta_5 TX_2$$

- T 는 연구가 시작된 이후 경과된 시간 (분기별 단위), 는 t 시점의 성과지표, 는 사업 시행 여부 (: 사업 시행 전, : 사업 기간 중, : 사업 종료 후), 는 사업 시행 전 기준선에서의 성과 지표 수준, 는 시행 전 추세(기울기)를 나타내고, 는 사업 시행 직후 수준 변화, 는 사업 종료 직후 수준 변화, 는 사업 기간 중 추세(기울기) 변화, 는 사업 종료 후의 추세(기울기) 변화를 의미함

4. 분석 결과

- PNC2~4에서 사업 수행 전의 하향 기울기를 통계적으로 유의미하게 역전시킨 효과가 나타남
- (사업시행 시점) 전반적으로, 2020년 초 발생한 코로나19로 인해 본격적인 사업 시행시점인 2021년에는 전문가에 의한 분만 비율을 제외하고 모두 사업 시행 시점에 통계적으로 유의미한 서비스 이용률의 단절적인 급락을 보였으며, 특히 산후 PNC1과 PNC2 지표는 상대적으로 큰 폭의 하락을 보임
- 본격적인 사업 수행시기인 21년~24년에는 산전관리 및 분만 관련 서비스 이용률을 상승시키는 성과를 보이거나 추세적으로 통계적 유의성이 있는 변화는 아님. 산전관리의 경우 24년에 가서야 코로나19 이전 수준으로 회복하였고 나머지 지표는 회복하지 못함
- 오히려 사업의 성과지표로 설정하지 않은 PNC2~4에서 통계적으로 유의미한 추세의 변화를 확인할 수 있음
- (사업 종료 시점) 사업 종료 후 통계적으로 유의미한 단절적인 변화나 추세의 변화는 없어 사업의 효과는 지속되고 있는 것으로 확인됨.
- 다만, 전문가에 의한 분만률과 PNC1의 경우, 유의하지 않지만 기울기가 음수 방향으로 나타나 추후 지속적인 데이터의 관찰이 필요해 보임
- 종료 이후의 시점이 4분기밖에 되지 않기 때문에 추후 데이터가 축적되면 추세의 경우 유의미한 변화로 바뀔 가능성도 있음

<표> 단절적 시계열 분석 결과

	사업 시행 시점				사업 종료 시점			
	수준변화		추세변화		수준변화		추세변화	
	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI	Coeff	95% CI
ANC 4	-10.7	[-19.7, -1.8]	0.5	[-0.2, 1.1]	-10.0	[-107.6, 87.6]	0.3	[-3.5, 4.1]
Delivery by prof	0.4	[-1.2, 2.0]	-0.1	[-0.2, 0.1]	13.6	[-3.9, 31.1]	-0.6	[-1.3, 0.1]
PNC 1	-12.5	[-24.4, -0.7]	-0.2	[-1.0, 0.7]	-5.2	[-134.4, 124.1]	-0.6	[-5.6, 4.5]
PNC 2	-61.0	[-93.0, -29.1]	3.1	[0.9, 5.3]	-97.6	[-445.4, 250.2]	4.9	[-8.6, 18.3]
PNC 3	-18.2	[-27.5, -9.0]	1.2	[0.6, 1.9]	19.6	[-81.3, 120.6]	0.1	[-3.8, 4.0]
PNC 4	-5.6	[-10.6, -0.5]	0.3	[-0.1, 0.6]	-5.2	[-60.1, 49.8]	0.4	[-1.7, 2.5]

평가 기준	평가질문	측정지표	자료출처	분석방법
적절성	*핵심 평가 질문 1.1. 수원국 및 대상지역의 모자보건 문제 원인 해결에 적합한 사업인가? 1.2. 사업 수행 주체는 해당 사업을 추진하기에 적합한가? 1.3. 사업의 기획은 목표를 달성하기에 적절한가? 1.4. 기획된 사업 내용이 수혜자들의 문화적·민족적 배경과 일치하는가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 1.1 수요자들에게 제공된 자원이 실제 필요로 하는 내용이었는가? 실제로 필요로 하지 않았다면 왜 필요로 하지 않았는가? 필요로 하는 것은 무엇이었는가? 1.2 수요자들에게 제공된 자원이 상황에 맞게 구성되었는가? 상황에 적합하지 않았다면 왜 상황에 적합하지 않았는가? 1.3 수요자들의 관심도와 이해도가 증가하였는가? 어떤 부분의 관심도와 이해도가 증가했는가? 증가하지 않았다면 왜 증가하지 않았는가? 기존에 가지고 있던 관심과 이해도는 무엇인가? *서비스 공급자 측면 세부 질문 1.4 공급자 측면에서 제공할 자원이 수요자들이 필요로 하는 방식이었는가? 수요자들이 필요로 하지 않았다면 제한된 이유는 무엇인가? 1.5 공급자들의 교육을 위해 제공된 프로그램이 시간적 공간적으로 충분한 수준으로 제공되었는가? 부족했다면 어떤 것이 부족했고 충분했다면 어떤 것이 충분했는가? 1.6 공급자들에게 제공된 자원이 실제로 사용할 수 있는 자원이었는가? 실제로 사용되고 있는가? 실제 사용이 불가능한 자원이었다면 왜 사용이 불가능했는가? 그런 자원이 지원되었다면 왜 준비단계에서 확인되지 못했나? 1.7 사업이 수원국 및 대상 지역 내 모자보건 문제 원인과 수혜자 수요에 부합하거나 상호보완적인가? 1.8 사업이 수혜자들의 문화적 · 민족적 배경과 일치하는가?	교육 및 자원 적절성과 적합성	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서 이해관계자 면담 등)	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등
일관성	*핵심 평가 질문	내적일관성 및	사업 관련 자료	문헌조사,

	2.1. 외적일관성 : 사업은 국가 정책, 국제 이니셔티브, SDGs 목표, 파트너 기관 전략에 부합하는가? 2.2. 내적일관성 : 사업 요소별로 일관성 있게 기획되고 수행되었는가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 2.1 다른 건강서비스들과 일관성을 가지고 제공되었는가? 일관성이 없었다면 왜 일관성이 없었는가? 기존 건강서비스와의 충돌지점은 무엇인가? 2.2 기존의 교육방식과 일관성을 가지고 제공되었는가? 일관성이 없었다면 왜 일관성이 없었는가? 기존 교육방식과의 충돌지점은 무엇인가? 2.3 기존의 방식 혹은 다른 지원사업들과 충돌되어 조직의 저항이 발생한 지점이 어느 지점인가? *서비스 공급자 측면 세부 질문 2.4 공급자들이 제공받은 자원이 외적으로 일관성 있게 제공되었는가? 서로 형평성 있거나 일관성 있게 제공되지 않았다면 어떤 자원이 일관되지 않았는가? 그렇다면 그 이유는 무엇인가? 2.5 공급자들이 제공받은 자원을 제공할 때 일관성 있게 전달하였는가? 일관성 있게 제공하지 못했다면 왜 못 했는가? 일관성 있게 제공했다면 어떻게 일관성 있게 제공하고자 노력했는가? 2.6 기존의 가지고 있던 혹은 제공되었던 자원과 내적으로 일관성 있게 조화를 이루고 있는가? 조직의 저항이 있었다면 왜 저항이 발생하였는가? 2.7 사업은 한국 정부 및 국내 타기관, KOICA 사업 간 연계, 상호보완성, 원조 조화, 성과 고도화 및 시너지효과 등을 고려하여 기획되었는가? 2.8. 본 사업이 대상 국가 및 지역의 내·외적 변수에 조정해나가며 목적 달성을 위한 연결성을 보였는가?	외적일관성 시너지효과 여부	(사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서, 이해관계자 면담 등)	현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등
효과성	핵심 평가 질문 3.1. 계획 대비 사업의 산출물 및 성과가 달성되었는가? 3.1.1. 수요자 측면에서 서비스 미충족 경험 및 서비스 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가? 3.1.2. 공급자 측면에서 역량강화 프로그램의 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가? 3.1.3. 공급자 측면에서 건축 및 기자재 지원에 대한 만족도는 어떠하였으며 결정요인은 무엇인가? 3.2. 사업의 효과성을 높이기 위해 향후 추가적으로 필요한 사업의 내용은 무엇인가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 3.1 실질적으로 유용성을 가진 정보가 제공되었는가? 유용성이 있었다면 어떤 것이 유용성이 있었나? 유용성이 없었다	산출물 성과의 목표 대비 달성률 사업 활동 추진의 작동 및 비작동 요인	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서, 이해관계자	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등

	면 어떤 것이 유용성이 없었는가? 3.2 효과적인 방법으로 정보를 취득할 수 있었는가? 효과적이었다면 어떤 것이 효과적이었는가? 효과적이지 않았다면 어떤 것이 효과성이 없었는가? 3.3 해당 사업을 통해 개선된 건강 상태를 얻을 수 있었는가? 해당 사업을 통해 개선된 건강 상태는 어떤 것이었는가? 개선되지 않았다면 왜 개선되지 않았는가? 어떤 지점에서 개선되었거나 개선되지 않았다고 생각되었는가? *서비스 공급자 측면 세부 질문 3.4 공급자가 지역사회에 대해 효과적으로 기여있다고 인식하고 있는가? 지역사회에 효과적으로 기여하고 있지 않다면 왜 효과적으로 기여하고 있지 않은가? 3.5 공급자의 역량이 효과적으로 개선되었는가? 어떤 역량이 가장 크게 개선되었는가? 개선되지 않았다면 왜 개선되지 않았는가? 3.6 공급자가 제공받는 방식이 효과적이었는가? 어떤 것이 효과적으로 제공되었는가? 효과적으로 제공되지 않았다면 어떻게 해야 효과적으로 제공 받을 수 있는가? 3.7 당초 계획 대비 사업의 산출물 및 성과가 달성되었는가? 3.8 외부효과가 아닌 사업을 통해 모자보건 서비스 사용 상황이 개선되었는가? 3.9 지역사회에 대한 모자보건 서비스 체계가 확장되었는가? 3.10 각 프로그램이 상호 연계되어 사업 목표 달성에 영향을 주었는가? 3.11 성과 달성을 위해 개선할 수 있는 점은 무엇인가?	성과 달성의 촉진/저해 요인	면담 등)	
효율성	핵심 평가 질문 4.1. 예상치 못한 상황(코로나-19)이 발생했을 시에 대내외 상황변화에 적합하고 현실적인 위기관리 대응이 마련되고 실현되었는가? 4.2 필요한 자원이 적절한 시기에 제공되었는가? 적절한 시기에 제공되지 못하게 된 주요 원인은 무엇인가? 4.3. 제공된 자원의 이용과 협력의 방식이 효율적인 방식으로 이루어졌는가? 더 효율적으로 변화하려면 어떤 것이 필요한가? 4.4. 파트너십사업 해당) KOICA-사업 주체-현지 이해관계자 간 파트너십 및 커뮤니케이션은 효율적으로 관리되었는가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 4.1 서비스 이용과정에서 시간과 비용이 충분하게 효율적이었는가? 효율적이지 않았던 부분이 있었다면 비효율이 발생	자원의 효율적 사용 및 의사결정 효율성	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서 이해관계자 면담 등)	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등

	한 지점이 무엇인가? 4.2 필요한 자원이 적절한 시기에 제공되었는가? 적절한 시기에 제공되지 않았다면 주요 제공 시점은 언제인가? 적절한 시기에 제공되지 못하게 된 주요 원인은 무엇인가? 4.3 필요한 지원을 얻는데 걸리는 시기가 효율적이었는가? 지나치게 긴 대기가 있었다면 왜 대기가 길어졌는가? 체감하는 대기과 대기의 어느 시점에서 (예약, 접근) 대기가 발생했는가? *서비스 공급자 측면 세부 질문 4.4 자원의 이용과 협력의 방식이 효율적인 방식으로 개선되었는가? 협력의 방식이 비효율적으로 바뀌었다면 왜 비효율적으로 바뀌었는가? 더 효율적으로 변화하려면 어떤 것이 필요한가? 4.5 활동에 있어서 필요한 권한위임이 충분하여 의사 결정과정에서 불필요한 손실이 발생하지 않는가? 권한위임이 충분하지 않다면 어떤 권한위임이 필요한가? 어떤 부분의 간섭과 개입이 비효율을 초래하는가? 4.6 내외부적 인식할 수 있는 불만 사항, 비효율성이 있는가? 그것이 발생한 이유는 무엇인가? 불만 사항, 비효율성을 얻게 된 계기가 무엇인가? 개선을 하고자 한 노력이 있었는가? 4.7 예상치 못한 상황(코로나-19)이 발생했을 시에 대내외 상황변화에 적합하고 현실적인 위기관리 대응책이 마련 및 실현되었는가?			
지속 가능성	핵심 평가 질문 5.1. 수원국 제도가 사업을 지원하는가? 5.2. 사업 대상 지역사회의 주인의식이 사후에도 사업을 계속 발전시킬 수 있을 만큼 충분한가? 5.3. 향후 프로그램이 지속적으로 운영되기 위한 사업의 요소는 무엇인가? 파악이 이뤄졌다면 어떤 부분들이 개선되어야 하는가? 5.4. 건축물의 관리는 잘 이뤄지고 있는가? 5.5. 기자재 및 소모품의 관리 및 활용은 잘 이뤄지고 있는가? 5.6. 의료시설 내 감염관리는 잘 이뤄지고 있는가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 5.1 향후 프로그램이 지속적으로 운영되기 위한 수요자 측면의 이해는 무엇인가? 파악이 이뤄졌다면 어떤 부분들이 개선되어야 하는가? 5.2 프로그램을 장기적으로 지역사회가 실천할 의향이 있는가? 없다면 어떤 부분이 장애요인인가? 5.3 사업을 지속적으로 이어나가기 위해 전파할 의향이 있는가? 없다면 왜 없는가? 있다면 구체적으로 어떤 프로그램	정치적·인적·재정적·인프라 지속성 사회 환경 변화 여부 출구전략 존재 여부 주요 시설 및 기자재 사후 관리 가능 유무 지역	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기초선 및 종료선 조사 결과보고서, 이해관계자 면담 등)	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등

	혹은 지식을 전파하고 싶은가? 5.4 본인, 가족, 지인의 건강증진을 위해서 필요한 영역이나 사업 및 정책이 무엇이라고 생각하는가? *서비스 공급자 측면 세부 질문 5.4 사업이 종료된 이후 지속적인 관리 및 재원 지원이 이뤄지고 있는가? 지속적인 관리가 어떤 방식으로 이뤄지고 있는가? 이뤄지지 않고 있다면 왜 중단되었는가? 향후 재개될 수 있는가? 5.5 사업이 종료된 이후에도 타 공급자들과의 연계성이 유지되고 있는가? 연계성이 잘 이뤄지지 않는다면 그 이유는 무엇인가? 언제부터 연계성이 이뤄지지 않고 있다고 생각하는가? 장기적으로 재개될 수 있다고 생각하는가? 5.6 공급자들이 사업에 참여하지 않은 공급자들에게도 기여하여 전반적인 시스템 향상을 도모하고 있는가? 전반적인 시스템 향상이 이뤄지고 있지 않다면 제한조건은 무엇인가? 5.7 사업을 통해 수원국 정부와 대중을 위해 더 유용성을 높일 수 있는 시스템을 소개하였는가? 5.8 수원국의 제도가 사업을 지원하는가? 5.9 사업 대상 지역사회의 주인의식이 사후에도 사업을 계속 발전시킬 수 있을 만큼 충분한가? 5.10 사용된 시스템이 수원국 사회문화 조건에 부합되는가?			
영향력	핵심 평가 질문 6.1. 수요자들이 건강관리 방식에 있어서 변화를 인식하고 실천하고 그 영향력을 인식하고 있는가? 영향력이 있다면 어떤 영향이 있었는가? 6.2. 프로그램이 공급자 간, 공급자와 수요자 관계에서 신뢰 관계 및 행동양식에 미친 영향이 있는가? 향후 유사 사업 추진 시에 신뢰 관계를 형성하기 위해서는 어떻게 반영할 것인가? *서비스 수요자 측면 세부 질문 6.1 수요자들이 건강관리 방식에 있어서 변화를 인식하고 실천하고 그 영향력을 인식하고 있는가? 영향력이 있다면 어떤 영향이 있었는가? 6.2 수요자들이 프로그램에 직접 참여하지 않은 수요자들에게도 기여하여 전반적인 참여율을 증대시키고 있는가? 증대시키지 못한다면 왜 증대시키지 못하고 있는가? 6.3 수요자들이 가정 내에서 충분한 영향을 미치고 있다고 인식하고 있는가? 가정 내에 영향력을 제한하는 요소가 있다면 어떤 것이 제한하고 있는가? *서비스 공급자 측면 세부 질문	사업이 지역사회에 미친 영향력과 향후 파급력	사업 관련 자료 (사전 조사 보고서, 사업 실행계획서, 사업 이행 결과서, 분기별 보고서, 기조선 및 종료선 조사 결과보고서, 이해관계자 면담 등)	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰, 설문조사 등

	6.4 사업 후 단계적으로 공급자들이 지역사회 주민들의 건강방식의 변화를 파악하고 그 영향력을 분석하고 있는가? 있다면 그 영향력은 어느 정도인가? 변화가 없다면 왜 변화가 없는가? 6.5 향후 프로그램이 장기적으로 영향력을 행사하기 위해서 필요한 부분들이 적절하게 파악되고 있는가? 파악이 이뤄졌다면 어떤 노력이 필요한가? 파악이 잘 되지 않는다면 왜 파악이 잘 안되는가? 6.6 프로그램이 공급자 간, 공급자와 수요자 관계에서 신뢰 관계 및 행동양식에 미친 영향이 있는가? 향후 유사 사업 추진 시에 신뢰 관계를 형성하기 위해서는 어떻게 반영할 것인가?			
원조 소의 계층 포용 / 성 주류화	핵심 평가 질문 7.1. 인권주류화 및 젠더 주류화: 소수 민족, 원거리 마을주민, 여성 등 취약 계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요를 반영한 프로그램을 기획하였는가? *원조소의계층 포용 세부 평가 질문 7.1 사업이 지역의 취약계층(학교밖 아동, 장애인, 난민, 고아 등)을 식별하고, 그들의 차별적 수요 또는 소외/차별의 원인을 파악하고, 대응 방안이 반영됐는가? 향후 유사 사업 추진 시 어떻게 사업설계에 반영되어야 하는가? 7.2 취약계층의 사업 참여 또는 관련 정보공유를 제한하는 요인을 사전에 파악하고 해결하려는 노력이 있었는가? 만약 그렇지 않았다면, 향후 유사 사업 추진 시 어떠한 사전 조치가 이루어져야 하는가? 7.3. 사업은 취약계층에 대한 차별의 유무를 파악하고 해결하려는 노력(사회경제적 그룹별 분리데이터 모니터링 등)을 통해 차별적 성과(differential results)를 보장하는가? 7.4 소수 민족, 원거리 마을주민 등 취약 계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요를 반영한 프로그램을 기획 및 제공했는가? *성주류화 세부 평가 질문 8.1 기획 시 지역의 성별에 따른 차별적 수요와 역할, 책임, 이로 인한 불평등 요소의 여부와 원인을 파악하고, 사업설계에 반영했는가? 만약 반영되지 않았다면, 향후 유사 사업 추진 시 어떻게 사업설계에 반영되어야 하는가? 8.2 성별에 따른 사업 참여 또는 정보공유를 제한하는 요인을 사전에 파악해 해결하려는 노력이 있었는가? 만약 그렇지 않았다면, 향후 유사 사업 추진 시 어떠한 사전 조치가 이루어져야 하는가? 8.3 사업은 성별에 따른 차별의 유무를 파악하고 해결하려는 노력(사회경제적 그룹별 분리 데이터 모니터링 등)을 통해 차별적 성과(differential results)를 보장하는가? 8.4 사업 진행 과정에서 여성은 일방적인 수혜자가 아닌 주도로 참여했는가?	취약계층 식별 및 취약 계층 대상 차별적 성과 달성 여부 성별에 따른 불이익을 평가함.	이해관계자	문헌조사, 현장 조사, 이해관계자 인터뷰

평가자료 평가 2025-68-215	
캄보디아 동북부 소외지역 모자보건 프로그램 ('19 - '23 / 700만불) 종료평가 결과보고서	
발행 책임평가 자	2025년 7월 김 옹 한
발행처 주소 전화 팩스 홈페이지 I S B N	한국국제협력단 [13449] 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 1588-0434 (031) 740-0260 http://www.koica.go.kr
[본 보고서의 저작권은 한국국제협력단에 있으며, 한국국제협력단의 허락없이 무단 전재와 복제를 금합니다.]	

평가자료
2025-68-215